



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SUCRE

PLAN MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SUCRE



Save the Children



REALIDADES

Elaborado por Tahí Abrego Marín – Consultora Save The Children

Equipo de apoyo técnico a la elaboración del diagnóstico:

José Manuel Bejarano – ONG Realidades

Alejandra Benavidez – ONG Realidades

Adriana Maite Garabito Huarachi; Jhenifer Lopez Quiroga; Manuel Alejandro Sanchez Zambrana;

Lucina Mansilla Cortez; Paola Andrea Vaca Maita; Juan Pablo Fernandez Quispe - Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho USFXCH

Equipo de consulta técnica

Marisol Llanos Secretaria de desarrollo humano y social GAM Sucre

Carla Ortuño – DNA GAM Sucre

Nicolas Mamani – DNA GAM Sucre

Jonny Galvan – DNA GAM Sucre

Jose Arce – Prevención GAM Sucre

Fabiola Rosales – CIDIM

Edwin Mita – Programa de protección social NNATS

Equipo revisor

Jonathan Beimar Ramirez – Planificación SDHS – GAM Sucre

Jimena Tito - Save The Children

José Rodolfo Vargas – Save The Children

José Rodrigo Arcienega - Save The Children

Equipo de apoyo al recojo de propuestas del Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de Sucre 2021-2023

Emilie Mark – Presidenta

Li Choque

Kevin Ventura

Carlos Subirana

Edwin Campos

Mariela Arancibia Caba

Sucre – Bolivia 2023

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. ENFOQUE POLÍTICO	6
1.1. ENFOQUES	7
1.2. MARCO NORMATIVO	8
1.2.1. Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Constitución Política del Estado	8
1.2.2. Marco normativo internacional	9
1.2.3. Normativas nacionales de Derechos de la niña, niño y adolescente	12
1.2.4. Normativa Autonómica de Derechos de la niña, niño y adolescente	18
1.3. MARCO INSTITUCIONAL Y COMPETENCIAL	20
1.3.1. Descripción de roles y atribuciones de los GAM	20
1.3.2. Descripción competencial de los GAM	21
1.3.3. Descripción alcance funcional de las instituciones locales	21
2. DIAGNOSTICO - SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE	28
2.1. CONTEXTO	28
2.1.1. Demografía y pobreza	28
2.1.2. Gasto social	32
2.2. DERECHO A LA SUPERVIVENCIA	35
2.2.1. Condiciones de vida	35
2.2.2. Infraestructura y equipamiento sanitario	38
2.2.3. Centros de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes – AIDAJ	39
2.2.4. Salud integral madre niño	41
2.2.4.1. Cuidados prenatales	41
2.2.5. Salud integral en adolescentes	43
2.2.5.1. Salud sexual y reproductiva	43
2.2.6. Discapacidad	49
2.3. DERECHO AL DESARROLLO	50
2.3.1. Cobertura educativa.	50
2.3.2. Tasa de Abandono y promoción escolar	53
2.3.3. Infraestructura y equipamiento educativo primaria y secundaria	56
2.3.4. Centros de educación especial	57
2.3.5. Gabinetes de atención integral para Estudiantes GAIE	57
2.4. DERECHO A LA PROTECCIÓN	58
2.4.1. NNA en actividad laboral	58
2.4.2. Prevención ante la vulneración de derechos	62
2.4.3. Protección integral	66
2.4.3.1. Casos de violencia atendidos	66
2.5. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN	74
2.5.1. Gobiernos estudiantiles	74
2.5.2. Comité de la niña, niño y adolescente	75
2.6. PROBLEMAS Y RESPUESTA MUNICIPAL	78
2.6.1. Problemas identificados	78
2.6.1.1. problemas identificados por el Comité Municipal de Niñez y Adolescencia	78

2.6.1.2.	Problemas identificados por las entidades que conforman el Consejo Municipal Intersectorial de la niñez y adolescencia	78
2.6.2.	Alternativas de solución priorizadas	82
2.6.2.1.	Alternativas de solución identificadas por las entidades que conforman el Comité Municipal de la Niña, Niño y Adolescente	82
2.6.2.2.	Alternativas de solución identificadas por el Consejo Municipal Intersectorial de la niñez y adolescencia	83
3.	POLÍTICA Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	86
3.1.	POLÍTICA	86
3.2.	LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	87
3.2.1.	Visión	87
3.2.2.	Misión	87
3.2.3.	Líneas estratégicas	87
3.3.	ESTRATEGIA	88
3.3.1.	Criterios operativos	88
3.3.2.	Gestión de implementación del Plan	89
3.3.3.	Seguimiento y monitoreo	90
3.3.4.	Evaluación	90
4.	PROGRAMACIÓN BASADA EN DERECHOS	91
4.1.	Articulación a las políticas públicas nacionales y ODS	91
4.1.1.	Articulación con los ODS	91
4.1.2.	Articulación PGDES	91
4.1.3.	Articulación PDES 2021-2025	91
4.2.	RESPONSABILIDAD POR ACTOR INSTITUCIONAL	91
4.3.	PROGRAMACIÓN	99
4.4.	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN FINANCIERA	107
4.4.1.	Presupuesto asignado en el PTDI 2021 – 2025 de Sucre	107
4.4.2.	Otras fuentes de financiamiento	108

PRESENTACIÓN

Sucre es un municipio joven donde el 38,8% de su población son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, afectados por múltiples situaciones de vulneración de derechos como la violencia en todas sus formas - la violencia en el ámbito educativo, la violencia sexual y la violencia digital-; el embarazo en adolescentes; el trabajo infantil; las brechas en el ejercicio de derechos a la educación y salud, sobre todo en áreas rurales; y el limitado acceso a servicios de protección, entre otros.

Frente a esas situaciones, el Estado en sus diferentes niveles ha promovido importantes avances normativos, reflejados en el Código Niña, niño y adolescente a nivel nacional, y la Ley N° 120/2018 Ley Municipal de la niña, niño y adolescente, a nivel autonómico municipal en Sucre, y se han elaborado una serie planes, manuales y protocolos, que progresivamente se están implementado a nivel municipal, fortaleciendo el sistema de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, mediante la articulación entre los diferentes servicios de atención y acceso a la justicia, definiendo las competencias de cada instancia del sistema penal y de protección, ampliando la cantidad de atribuciones normativas de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y designando atribuciones específicas a los Gobiernos municipales como entes rectores de la niñez y adolescencia a nivel local.

Pero existen distintas limitaciones a nivel de la implementación de las políticas públicas, por ejemplo en relación al sistema de información se ha consolidado a nivel local; respecto a los reducidos procesos de institucionalización y especialización del personal que atiende a las niñas, niños y adolescentes; del limitado diseño de planes y programas municipales; y la reducida coordinación interinstitucional, intersectorial e intergubernativa; además de la limitada asignación presupuestaria estipulada para el área social, que ha disminuido progresivamente en los últimos años, concentrando la mayor parte de los recursos en el ámbito de atención, y no de prevención.

En este contexto, el Gobierno Autonómico Municipal de Sucre, cumpliendo sus atribuciones, ha iniciado un proceso participativo de elaboración del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, con el apoyo de Save The Children y en coordinación con ONG Realidades. Proceso participativo que se ha desarrollado recogiendo propuestas de los miembros del Comité Municipal de la niña, niño y adolescente y del Consejo Municipal Intersectorial de la niñez y adolescencia, en reuniones técnicas y audiencias públicas.

El presente Plan Multisectorial Municipal de la niñez y adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se elaboró en un proceso de 4 fases:

- La primera Fase de organización y planificación, donde se definieron la metodología, el cronograma de trabajo y la coordinación interinstitucional para el desarrollo de las siguientes fases, siempre en coordinación con el Comité Municipal de la niñez y adolescencia de Sucre.
- La segunda fase de sistematización que permitió recabar propuestas que se habían planteado hasta la fecha; además de desarrollar el diagnostico de situación de la niñez y adolescencia, en base a datos de fuentes oficiales nacionales y registros administrativos del gobierno local; Y finalmente recabar el marco normativo internacional, nacional y autonómico.
- La tercera fase de recojo de propuestas se desarrolló mediante diferentes actividades participativas: Después de difundir el proceso a través de medios de comunicación, el Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de Sucre 2021-2023, recogió propuestas en

audiencia pública y en buzones de sugerencias de los 8 distritos municipales y de poblaciones de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo, de centros de acogida y de reintegración social y de lugares estratégicos de la ciudad como el mercado campesino. Luego realizó reuniones de análisis y sistematización de las propuestas priorizando las mismas. Y el Consejo Municipal intersectorial de la niñez y adolescencia sostuvo varias reuniones presenciales y virtuales en las que participaron diferentes entidades como la DNA, la Policía, Juzgados de la niñez y adolescencia, la unidad de familia y Prevención del Gams, SEDGES, ONG Realidades, Aldeas SOS, Save The Children, Cemse, CEADL, CIES, Cerpi – IPTK, las Promotoras Comunitarias entre otras.

- La cuarta fase de validación se desarrolló mediante 3 estrategias: Validación técnica con un equipo interdisciplinario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; revisión técnica con un equipo de especialistas de niñez y adolescencia de Save The Children y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; y validación participativa en el Congreso Municipal de niñez y adolescencia, con la participación del Comité Municipal de la niña, niño y adolescente de Sucre y las entidades que conforman el Consejo Municipal Intersectorial de niñez y adolescencia.

El presente Plan Multisectorial Municipal de la niñez y adolescencia del Municipio de Sucre 203-2025 cuenta con 4 partes:

- El enfoque político, que contiene los enfoques y el marco normativo competencial en el que se basa el presente plan.
- El Diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia, que describe el contexto, la situación del derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, a la protección y a la participación, en base a datos de fuentes de información oficiales estatales; Y la descripción de problemas identificados y soluciones propuestas por las niñas y niños y por las entidades del sistema de protección.
- La política y lineamientos estratégicos, detallando la Misión, Visión y líneas estratégicas en 4 ejes: Participación, Sistema de protección, Prevención de la violencia y vulneración de derechos, Atención y reparación integral del daño y Protección Social de grupos prioritarios.
- La programación basada en derechos, y la alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de desarrollo general económico y social de Bolivia - PDGES, el Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES, el Plan Territorial de Desarrollo Integral de Sucre - PTDI; Y la planificación de acciones estratégicas e indicadores.

1. ENFOQUE POLÍTICO

El enfoque político del Plan de Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre está orientado a garantizar el ejercicio de los derechos de infantes, niñas, niños y adolescentes con atención especial a las poblaciones en mayor riesgo de vulnerabilidad (abandono familiar, violencia, trabajo infantil, embarazo adolescente, entre otros) atendiendo de manera integral sus problemáticas y necesidades en las áreas de educación, salud integral diferenciada, servicios básicos y de protección, promoviendo la participación de las niñas, niños y adolescentes; e involucrando a las familias y a la comunidad corresponsables de los derechos de la niñez y adolescencia.

El Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se articula al PTDI Municipal 2021-2025, responde a los lineamientos de la Ley Municipal N° 120/2018,

la Ley N° 548, el Plan Multisectorial de la niñez y adolescencia. Y es un insumo central de la Planificación estatística del municipio.

1.1. ENFOQUES

- **Enfoque de protección integral**

El enfoque de protección integral establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce a las niñas y niños como sujetos de derechos, que, en el marco del principio del interés superior, por estar en etapa de desarrollo, son sujetos de protección reforzada.

Desde este enfoque el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 buscará contribuir al bienestar y desarrollo integral, como construcción multidimensional, que toma en cuenta factores como las condiciones materiales e ingresos de los hogares, el acceso a servicios de salud, educación y cuidado; y reconoce el derecho a la participación de las niñas y los niños en espacios sociales, culturales y comunitarios, dentro de los cuales tienen derecho al buen trato y a vivir una vida sin violencia.

- **Enfoque de derechos**

El enfoque de derechos que parte del concepto de que las niñas, niños y adolescentes como sujetos y titulares de derechos, son el centro de la política pública municipal, es decir del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, que contribuirá a que el Estado a nivel municipal pueda cumplir con su rol de garante de derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de sus competencias constitucionales y autonómicas y las atribuciones normativas, procurando la prevención de la amenaza o vulneración de derechos, y la atención, además de la seguridad de su restablecimiento inmediato en el marco de la normativa autonómica, nacional y los tratados, instrumentos y estándares internacionales de derechos.

Además, aplicando el enfoque de derechos el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, reconoce la importancia de garantizar el efectivo ejercicio a la participación de las niñas, niños y adolescentes, que han sido escuchados por las autoridades públicas en el proceso de formulación del plan y sus opiniones están siendo tomadas en cuenta en los mecanismos de seguimiento de esta importante política pública que les afecta.

- **Enfoque de género**

El enfoque de género que es un método del derecho y de las ciencias sociales, destinado a identificar discriminaciones en razón de sexo, género, identidad de género, orientación sexual u otros criterios prohibidos de discriminación, para que se asuman medidas normativas, políticas públicas, o cualquier decisión, coherentes con la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad. Contribuirá a que el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 permita de-construir la falsa dicotomía basada en los cuerpos de las personas, así como las consecuencias que se les han atribuido a partir de los roles o estereotipos de género, sexo, de roles sexuales y compuestos.

En este sentido, el enfoque de género se transversalizará en el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, debido a que en esta edad (de la niñez) se instalan los estereotipos y desigualdad de género, que posteriormente expresan y reproducen desigualdades y la violencia en razón de género.

- **Enfoque intercultural**

El enfoque intercultural, que es un método del derecho destinado a identificar las asimetrías y desventajas en las que se encuentran las personas indígenas, por tanto, contribuirá a que el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 pueda abordar y prevenir los tratos discriminatorios basados en la diversidad cultural, en las desventajas socio-económicas que se generan en zonas rurales, periurbanas y por la migración de las niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas, originarios y campesinos.

- **Enfoque interseccional**

El enfoque interseccional, que se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. Permitirá que el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 pueda tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, para tomarlos en cuenta, por ejemplo una niña menor de 5 años, indígena, con discapacidad, vive múltiples causas de discriminación, por lo que requiere una protección reforzada y permite una comprensión más exhaustiva de la realidad de cada una de ellas.

1.2. MARCO NORMATIVO

1.2.1. Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos, con los límites establecidos en la misma, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. (Art. 58 CPE).

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, a vivir y crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, y cuando no sea posible tendrá derecho a una familia sustituta, por otro lado, las niñas, niños y adolescentes tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores, también tienen derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores (Art. 59 CNNA)

Por otro lado, también define que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado (Art. 60 CPE).

En la constitución se describen las competencias de los diferentes niveles del Estado, estableciendo que son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción; además de promover y desarrollar proyectos y políticas de niñez y adolescencia (Art. 302 I. 2 y 39 CPE) entre otras poblaciones de atención prioritaria.

Además, la Constitución Política del Estado consagra el principio de Supremacía Constitucional, la Jerarquía Normativa en el Estado y establece que el Bloque de Constitucionalidad, que está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario ratificados en el País (Artículo 410 II CPE), que son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección (Artículo 109 I. CPE).

Reconociendo de esta manera los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y en directrices, principios y estándares jurisprudenciales que emanan de órganos supra estatales de protección de derechos humanos, por lo que la materialización de estos derechos en el marco de una armonía tanto del Sistema Universal como Interamericano de protección de Derechos humanos, debe ser abordada desde la concepción del Bloque de Constitucionalidad Boliviano. (SC 110/2012-R).

1.2.2. Marco normativo internacional

El Boque de constitucionalidad antes mencionado, reconoce los derechos ratificados por Bolivia en los tratados, convenios y estándares internacionales favorables a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entre los más importantes destacamos los siguientes:

- ✓ **Declaración Universal de los Derechos Humanos** de 10/12/ 1948. Que protege los derechos de todas y todos sin discriminación, el derecho a la vida, a la salud, educación, a la seguridad social, a una vivienda digna, al acceso a la justicia entre otros.
- ✓ **Convención de los Derechos Humanos**, Pacto de San José de Costa Rica, de 22/11/1969, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1430, desarrolla los derechos a la familia, al nivel de vida adecuado, a acceder a cuidados y asistencia especial y a la educación entre otros.
- ✓ **Declaración de Derechos del Niño**, ONU, 1959, define que el niño debe gozar de una protección especial y disponer de oportunidades y servicios que garanticen su desarrollo integral, en condiciones de libertad y dignidad. Determinando además que los niños tienen derecho a un nombre y nacionalidad, a la salud y seguridad social, a la familia, a la educación. Debiendo estar protegido contra toda forma de abandono, crueldad o explotación y contra toda forma de discriminación.
- ✓ **Convención sobre los Derechos del Niño**, de Naciones Unidas de 20/11/1989, ratificada por Bolivia, mediante Ley Nº 1152.
 - Establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. (Art. 19 CDN)
 - Define que esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
 - Compromete a los Estados Partes a tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar al niño la protección y el cuidado requeridos para su bienestar,

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas y consagra la “**Doctrina de Protección Integral**”, que reconoce al Niño, como verdadero sujeto de derecho y no solo objeto de protección, y se sustenta en 4 pilares, el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación, reconocida en la OC 17/02 y también por el Tribunal Plurinacional de Bolivia en la SC 0203/2007-R y la SC 0735//2012-R y congruente con el Art. 1.1. de la CADH, que establece la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación alguna, reconociendo que las niñas y niños tienen como derecho adicional y complementario la protección especial (OC 19/02) reforzada.

- ✓ **Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos del niño** que abordan diferentes temas entre los que destacamos los siguientes:
 - OG N° 14 Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial;
 - OG N° 8 sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo, crueles o degradantes;
 - OG N° 13 El derecho del Niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia;
 - OG N° 14 Sobre el derecho del Niño a que su interés superior sea una consideración primordial;
 - Recomendación General N° 31 al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y Observación General N° 18 del Comité de Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta;
 - Observación General N° 25 sobre los derechos de los niños en relación con el entorno digital.
 - Observación General N° 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia.
 - Observación General N° 12: Derecho del niño a ser escuchado
 - Observación General N° 19: Sobre el gasto publico y los derechos del niño

Por otro lado, resaltamos otros instrumentos internacionales de derechos fundamentales que también se constituyen en marco de derechos de las niñas, niños y adolescentes también:

- ✓ Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo de la Organización de naciones unidas Ley N° 4024 del 15/04/2009.
- ✓ Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW ratificada por ley N° 1100 del 15/09/1989.
- ✓ Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer ratificada por Ley N° 2103 del 20/06/2006.
- ✓ Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer – Belem do Para ratificada por Ley N° 1599 del 18/10/1994.
- ✓ Recomendación General N° 35 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer CEDAW, resalta que los Estados partes deben proporcionar servicios accesibles, asequibles y adecuados para proteger a las mujeres contra la violencia por razón de género, evitar que vuelva a ocurrir y proporcionar o garantizar la financiación de reparaciones para las víctimas y supervivientes (2017).
- ✓ Programa de acción de la conferencia de población y desarrollo de El Cairo, (CIPD 1994)

- ✓ Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, Convenio N°182 de la OIT
- ✓ Conferencia internacional de lucha contra la pornografía infantil en la internet (Viena 1999)

Mediante estos instrumentos internacionales ratificados por Bolivia, el Estado en sus diferentes niveles se compromete a adoptar diferentes medidas legislativas, administrativas, desarrollar políticas públicas y proporcionar recursos presupuestarios suficientes.

- ✓ Finalmente detallamos las principales Recomendaciones al Estado de Bolivia por parte del Comité Internacional de derechos del niño: El Comité Internacional de derechos del niño, le recomienda al Estado Plurinacional de Bolivia¹:
 - Fortalecer el Sistema Integral Plurinacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia y su labor de coordinación con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, dotarla de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para combatir la corrupción y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y fiscales;
 - Adoptar medidas urgentes en relación a la violencia contra los niños (párr. 23), explotación sexual (párr. 26), niños privados de un entorno familiar (párr. 30), niños con discapacidad (párr. 33), nivel de vida (párr. 39) y administración de justicia de menores (párr. 48).
 - Facilitar la coordinación intersectorial entre las instituciones públicas que reúnen datos, incluso para permitir el funcionamiento adecuado del sistema de protección de la infancia a todos los niveles; Velar por que se reúnan datos desglosados por edad, sexo, sexo, discapacidad, situación socioeconómica, nacionalidad, origen étnico, ascendencia indígena, contexto rural o urbano, situación migratoria y ubicación geográfica para todas las esferas de la Convención; Velar por la reunión y el análisis de datos sobre la discriminación contra los niños, la salud mental, los niños más pequeños, los niños indígenas, los niños acogidos a otros tipos de tutela, la pobreza infantil, los niños en el sistema judicial, los niños cuya nacionalidad se desconoce y la violencia contra los niños, el trabajo infantil, la trata, la explotación y el abuso sexuales.
 - Hacer participar sistemáticamente a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de niños, en la planificación, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas, planes y programas relacionados con los derechos del niño, incluso en el proceso de presentación de informes al Comité y en el seguimiento de las presentes observaciones finales. B. Definición del niño (artículo 1)
 - Promover la participación significativa y empoderada de todos los niños en la familia, las comunidades y las escuelas e incluya a los niños en la adopción de decisiones en todos los asuntos relacionados con los niños, incluidos los asuntos ambientales; Velar por que todos los profesionales pertinentes, incluidos los jueces, los maestros y los profesionales de la atención a la juventud, que trabajan con y para los niños, reciban sistemáticamente una formación adecuada sobre el derecho del niño a ser escuchado y que se tenga en cuenta su opinión de acuerdo con su edad y madurez.
 - Sobre los castigos corporales (OG8): Difundir ampliamente el Protocolo actualizado sobre la prevención, respuesta y denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en las

¹ El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Bolivia (CRC/C/BOL/5-6) en sus sesiones 2676ª y 2678ª, celebradas los días 19 y 20 de enero de 2023, y aprobó las presentes observaciones finales en su 2698ª sesión, celebrada el 3 de febrero de 2023

escuelas y los centros de educación especial. Establecer protocolos y procedimientos para adoptar medidas cuando se efectúen castigos corporales; Invertir en la en la promoción de formas positivas, no violentas y participativas de crianza y disciplina de los niños; Intensificar campañas de sensibilización dirigidas a los padres y profesionales que trabajan con y para los niños a fin de promover el cambio de actitud, dentro de la familia y la comunidad, con respecto a los castigos corporales.

- Sobre la violencia sexual contra los niños; el elevado número de violaciones infantiles, embarazos forzados y maternidad forzada; y la explotación sexual de los niños en la prostitución, incluso en las regiones mineras. El Comité insta velar por la aplicación efectiva del Protocolo sobre prevención, respuesta y denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en las escuelas y centros de educación especial y por una vía para combatir la violencia sexual, particularmente en las zonas rurales; Permitir que todos los niños víctimas de abusos sexuales tengan acceso a recursos y reparaciones por abusos sexuales, y dar prioridad al derecho de las víctimas a ser escuchadas; Llevar a cabo actividades de sensibilización para luchar contra la estigmatización de los niños víctimas de explotación y abuso sexuales, incluido el incesto, y garantizar canales de denuncia accesibles, confidenciales, adaptados a los niños y eficaces para denunciar esas violaciones.
- Sobre el derecho a la familia: Proporcionar recursos humanos y financieros suficientes a los servicios sociales y de protección, garantizar la reintegración familiar de los niños en instituciones y apoyar medidas de cuidado alternativo en entornos familiares; Adoptar medidas para eliminar gradualmente la institucionalización; Colaborar con las familias en situación de riesgo para evitar que los niños de familias inmediatas o ampliadas se vean privados de su entorno familiar; Velar por que las decisiones de colocación de niños en centros de acogida e instituciones de salud mental se revisen periódicamente y porque los niños tengan acceso a la justicia.
- Velar por que se adopte un enfoque amplio y orientado al desarrollo de la pobreza infantil, prestando especial atención a los niños de familias desfavorecidas, incluidos los niños indígenas, los niños de hogares monoparentales, los niños de familias dependientes de la asistencia social, los niños migrantes, los niños sin residencia habitual.
- Adoptar medidas para erradicar las peores formas de trabajo infantil y evitar que los niños sean víctimas de la servidumbre por deudas o del trabajo forzoso; eliminar las prácticas laborales peligrosas en las que los niños trabajadores están expuestos a factores de riesgo ambientales, promover alternativas más seguras y garantizar el seguimiento de los niños afectados; Aumentar e las inspecciones en lugares remotos, para poner fin al trabajo infantil de los menores de 14 años y mejorar y regular las condiciones de trabajo de los niños mayores; Responsabilizar a los responsables de los casos de trabajo infantil y velar por que los niños reciban el tratamiento y la indemnización necesarios por los daños sufridos
- Velar por que todos los adolescentes con responsabilidad, tengan acceso a la educación, los servicios de salud y la formación profesional.

1.2.3. Normativas nacionales de Derechos de la niña, niño y adolescente

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Constitución Política del Estado, en Bolivia se han desarrollado diferentes normativas nacionales a favor de las niñas, niños y adolescentes, entre las que destacamos las siguientes:

✓ **El Código Niña, Niño y Adolescente – Ley 548** y su Reglamentación DS 2377. (de 2014)

Describe de forma amplia los derechos de las niñas, niños y adolescentes, describe sus deberes, los deberes de los padres y madres, además de las garantías que el Estado en sus diferentes niveles debe brindar para la protección del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de las siguientes medidas:

- Se reconocen los derechos Derecho a la Vida, al nivel de vida adecuado, a la salud, a la salud sexual y salud reproductiva, al medio ambiente, al agua y saneamiento con calidad, a la familia, a la nacionalidad, identidad y filiación, a la educación, a la recreación y esparcimiento, a opinar, participar y realizar peticiones, a la protección en el trabajo desde los 14 años, a la libertad, respeto dignidad, privacidad e intimidad familiar, a la protección de la imagen y confidencialidad, a la Integridad personal, al Buen Trato, a ser protegidas y protegidos contra la Violencia sexual y al acceso a la justicia.
- Por otro lado, es importante mencionar que el Código Niña, Niño y Adolescente determina los siguientes PRINCIPIOS (Art. 12 CNNA): Interés superior del niño. Prioridad Absoluta. y garantías de las niñas, niños y adolescentes. Especialidad. Igualdad y no discriminación. Equidad de Género. Participación. Diversidad Cultural. Desarrollo Integral. Corresponsabilidad. Rol de la Familia. Ejercicio progresivo de derechos.
- Se crea el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, que es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales de interés público, de cooperación, coordinación y colaboración, desarrolladas por entes del sector público y del sector privado. (Art. 13.I. II. CNNA) Compuesto por los siguientes sistemas:
 - El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente
 - El Sistema Penal para Adolescentes
- Se establecen las responsabilidades para la gestión del Sistema y define las atribuciones del Ministerio de Justicia, de los Gobiernos Departamentales y Municipales, de la Instancia técnica departamental de política social, de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que se articulan en torno al Consejo de Coordinación sectorial e intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, que además debe coordinar con los Comités Municipales de Niñez y Adolescencia.

En el marco de responsabilidades, el Código niña, niño y adolescente, establece los lineamientos del Plan Plurinacional, Planes Departamentales y Municipales de las niñas, niños y adolescentes, y sus respectivos Programas, en el marco de la Política Pública, sin perjuicio de que se creen otros programas por las instancias competentes. (Art. 13. I. y Art. 162.I.c CNNA).

Entre los programas que los gobiernos autónomos municipales deben implementar destacamos los siguientes:

- De prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral

- De lucha integral contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes
- De detección y prevención temprana de discapacidad
- De prevención contra la violencia
- De cuidado integral y atención a niñas y niños en su primera infancia
- De atención y prevención para niñas, niños y adolescentes en situación de calle
- De prevención de embarazo en adolescentes
- De prevención de la asociación de adolescentes en pandillas
- De atención y apoyo para su desarrollo integral para niñas y niños de padre o madre privados de libertad
- De ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia de alcohol u otras drogas
- De capacitación, especialización, actualización e institucionalización de servidores públicos que trabajan en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Una de las atribuciones de los gobiernos autónomos municipales de acuerdo al Código Niña, niño y adolescente, es la de diseñar e implementar el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023 - 2025, en el marco de las políticas nacionales (Art. 184b).

- Además, el Código determina que los Gobiernos Municipales deben ejercer la rectoría municipal para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; asegurar la calidad profesionalidad e idoneidad y actualización técnica permanente de las servidoras y servidores públicos que trabajan con las niñas, niños y adolescentes institucionalizándolos; diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las medidas de protección social, de acuerdo a lo establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente, promover el conocimiento y difusión de derechos y garantías, elaborar informes anuales sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes (Art. 184 CNNA)
- ✓ **La Ley 1173 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha contra la violencia a niñas, niños y adolescentes y a mujeres (de 2019)**

Establece entre otros aspectos medidas de protección especial. Definiendo que en casos de urgencia, o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, el servidor/a público de la DNA, que tome conocimiento del hecho de violencia hacia NNA podrá disponer inmediatamente Medidas de Protección Especial de Urgencia, que serán notificadas al agresor/a con apoyo de la Policía, y serán comunicadas posteriormente a la jueza o juez de instrucción (en 24 horas) y ratificación, modificación o revocatoria por el la jueza o el juez que atendiendo a las circunstancias del caso, resuelva la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las 72 horas siguientes a la comunicación. (Artículo 389 ter. I. CPP Modificado por la Ley 1173)

Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia. Son de aplicación inmediata. Buscan salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. (Art. 32 Ley 348)

Las medidas de protección especial de urgencia que se pueden aplicar son las siguientes: Salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble; Prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar; Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; Prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; Devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima; Prohibición de acercarse, en el radio de distancia que determine la jueza o el juez, al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima; Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima.

En los casos en los que la violencia se ejerza al interior de la familia, el equipo interdisciplinario de la DNA realiza el rescate y la búsqueda de la familia ampliada que brinde el cuidado y protección de manera inmediata previa suscripción de Acta de compromiso y responsabilidad como medida de protección inmediata (Art. 54 II. Ley N° 1168), a falta de esta última se procederá con el acogimiento circunstancial como medida de extrema urgencia.

De acuerdo a la Ley N° 1173 la o el juez también pueden aplicar las siguientes medidas de protección especial, suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia con la víctima; medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente; Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de la víctima; Someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales; Fijación provisional de la asistencia familiar, cuando la persona imputada sea el progenitor; Fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar inmediato aviso (en el plazo máximo de 24 horas) a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; en caso de delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, la guarda provisional de la niña, niño o adolescente, se otorgará en favor de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y ordenar que toda la familia ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. La fijación provisional dispuesta, se mantendrá hasta tanto el juez de la niñez y adolescencia resuelva.

Y en caso de incumplimiento de las medidas de protección, el/la abogado/a de la DNA deberá informar al/la Juez, quien, en audiencia, dispondrá detención preventiva del infractor (389 quarter y 389 quinter Ley N° 1173).

- ✓ **El Protocolo de Prevención atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes** (2013) que desarrolla un conjunto de procedimientos específicos que describen la forma cómo las entidades públicas, privadas, instituciones de la sociedad civil y la familia, con la participación de las niñas, niños y adolescentes, deben actuar para garantizar a las víctimas de violencia sexual la restitución de sus derechos. Determinando que las medidas que deben asumirse para proteger la integridad física y salud de la niña víctima de violencia sexual que como resultado de la violación, incesto o estupro hubiesen quedado embarazadas es la de: “Aplicarse de manera inmediata

tratamiento para la prevención de Hepatitis B, ITS, VIH/Sida. Y, en caso de encontrarse en edad reproductiva, se deberá ofrecer Anticoncepción de Emergencia para prevenir el embarazo. Y a sola presentación de copia de la denuncia, los servicios de salud privados o públicos deberán proceder a la interrupción legal del embarazo cuando la niña o adolescente víctima de agresión sexual así lo requiera” de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0206/2014.

- ✓ **Sentencia Constitucional 0026/2014** modifica el artículo 266 del Código Penal referido al aborto impune que señalaba: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”.

A partir de la SCP 0206/2014 fue declarada la inconstitucionalidad de las frases: “siempre que la acción penal hubiese sido iniciada” y “autorización judicial en su caso”. En ese sentido, las niñas o adolescentes que como resultado de la violación, incesto o estupro hubiesen quedado embarazadas, únicamente deberán presentar una copia de la denuncia efectuada para que el servicio de salud (público o privado) proceda a realizar la interrupción legal del embarazo.

Otras normativas nacionales importantes a tomar en cuenta que modifican garantías define las sanciones para los agresores, y determinan los roles de las entidades que conforman los sistemas de protección que deben garantizar la prevención, atención y restitución de derechos y la reparación integral del daño de las víctimas son las siguientes:

- ✓ Código Penal y Ley N° 1768 de 10/03/1997. Y Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25/03/1999.
- ✓ Ley N° 2033 De Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, de 29/10/1999.
- ✓ Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, del 9/03/2013
- ✓ DS N° 2145 de 14 de octubre de 2014, Reglamento a la Ley 348 Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia del 14 / 10/ 2014
- ✓ D.S. N° 1320 Erradicación de la Violencia Sexual en las Unidades Educativas del 08/08/2012.
- ✓ Ley N° 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia del 09/03/2013.
- ✓ La Ley N° 1443 - Ley de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente.
- ✓ Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.
- ✓ Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” .
- ✓ Ley N° 263 Integral contra la Trata y Tráfico de personas y delitos conexos.
- ✓ Ley N° 264 de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- ✓ Ley N° 341 de Participación y Control Social.
- ✓ Ley N° 259, de Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
- ✓ Ley N° 777, del Sistema Integral de Planificación del Estado

- ✓ Ley N° 1168 de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las NNA
- ✓ Ley N° 1171 ley de modificación del CNNA, modificado por la Ley N° 1168 de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las NNA

Por otro lado, entre las principales políticas públicas nacionales relacionadas a la violencia tenemos las siguientes:

- ✓ El Protocolo de prevención, atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes
- ✓ Modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual. Ministerio de Salud
- ✓ Guía de atención a víctimas de violencia sexual para garantizar la aplicación de la sentencia constitucional – Ministerio de Justicia
- ✓ Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014
- ✓ Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de vulneración a La Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes

Finalmente debemos tomar en cuenta los lineamientos del **Plan Multisectorial de desarrollo integral para vivir bien** de la niñez y adolescencia 2021-2025 PMDI NyA, que desarrolla los siguientes lineamientos multisectoriales articulados con los pilares, ejes estratégicos, metas, resultados y acciones del PMDI NyA 2021-2025, son los siguientes:

- Implementar y promocionar medidas y mecanismos de prevención y atención de todo tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes
- Implementar condiciones materiales y gestión pedagógica e institucional para las denuncias por violencia dentro del Sistema Educativo Plurinacional
- Incrementar el acceso a los servicios de salud de las niñas, niños y adolescentes para su atención integral
- Fortalecer acciones de prevención de la violencia dentro el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
- Fortalecer la capacitación sobre la eliminación de toda forma de discriminación, la exclusión y prevención de la violencia a garantes de los derechos de la niñez y adolescencia

Estos lineamientos se desarrollan en el marco del modelo ecológico, de acuerdo al siguiente detalle:

- Eje 1: Macro / institucional: Que abarca todos los resultados y actividades previstas en el trabajo con las instituciones con competencias en la temática
- Eje 2: Comunidad: Organiza los resultados y actividades planificadas para promover cambios a nivel socio – comunitario
- Eje 3: Familia: Agrupa los resultados y actividades diseñadas para promover cambios favorables al ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes
- Eje 4: Pares: Organiza los resultados y actividades a ejecutar con los grupos de pares de niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres para contribuir al cambio de patrones sociales que impiden el ejercicio de sus derechos

- Eje 5: Individuos: Agrupa los resultados y actividades orientadas al empoderamiento personal de niñas, niños y mujeres y hombres adolescentes para avanzar con mayores recursos en su desarrollo personal y el ejercicio de sus derechos

EL PMDI NyA 2021-2025 prioriza los siguientes objetivos estratégicos:

- Fortalecer la coordinación intersectorial e intergubernativa para la implementación eficaz del PMDI, de acuerdo al marco competencial vigente
- Fortalecer el accionar de las instituciones estatales involucradas en la implementación del PMDI
- Fortalecer los espacios de participación de niñas, niños y adolescentes en la implementación, monitoreo y evaluación del PMDI
- Fortalecer los sistemas de información sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes
- Fortalecer el trabajo colaborativo con las comunidades, familias, grupos de pares y las niñas, niños y adolescentes

1.2.4. Normativa Autonómica de Derechos de la niña, niño y adolescente

Tomando en cuenta que los Gobiernos Autónomos de las entidades territoriales tienen reconocido el ejercicio de las facultades legislativa y reglamentaria, entre otros (Art. 272 CPE), varios gobiernos autónomos departamentales y municipales - como el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre - han elaborado y promulgado leyes autonómicas de niñez y adolescencia, en el marco de su competencia exclusiva de Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. (Art. 300.I.30 y Art. 302. I.39):

- ✓ La **Ley Departamental de políticas públicas de la niña, niño y adolescente del departamento de Chuquisaca – Ley N° 247** y su Reglamentación Decreto Departamental CH/N°76 que establece, entre otros, la conformación del Sistema Departamental de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, (Art. 37.I.4 Ley N° 247) que funciona a través del Sub - consejo departamental sectorial e intersectorial de derechos de la niñez y adolescencia, compuesto a su vez por diferentes subsistemas: De la Mesa Penal adolescente; De Protección Judicial; De Protección social; De Sociedad Civil Organizada; Subsistema Legal; Subsistema de Información.

Debiendo la Defensoría de la Niñez y adolescencia participar en los primeros 3: Subsistema de la Mesa Penal adolescente, Subsistema de Protección Judicial y Subsistema de Protección social. (Art. 41. I; Art. 42.II.; Art. 44.II. y Ley N°247).

- ✓ La **Ley Municipal de niñez y adolescencia – Ley 120/2018** establece diferentes lineamientos para que el gobierno autónomo municipal de Sucre pueda garantizar el efectivo ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia, entre los que destacamos los siguientes:
 - Define los principios de gratuidad, especialidad, capacitación continua, protección integral, gestión de calidad, prioridad absoluta, respaldo estadístico, presupuesto sostenible, coordinación, estandarización y planificación. (Art 4 Ley N° 120/2018)
 - Establece las garantías y lineamientos de políticas públicas de salud, prevención y detección temprana; salud sexual, reproductiva y prevención; información y apoyo pedagógico; cultura; deporte, recreación y juego además de los lineamientos de protección reforzada para poblaciones de atención prioritaria para la prevención

de violencia y entorno seguro; prevención y apoyo contra la discriminación; erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente; trata, tráfico de niñas, niños y adolescentes; niñas, niños y adolescentes en situación de calle; niñas, niños y adolescentes con discapacidad. (Art 8 a 20 Ley N° 120/2018).

- Establece como parámetros mínimos del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025:
 - Concentración, ya que agrupa todos los programas, proyectos y acciones que atiende el GAM a favor de las NNA del municipio
 - Vigencia, de 5 años
 - Implementación, para la que deben garantizarse los recursos económicos suficientes y recursos humanos especializados
 - Aprobación, por el sistema municipal integral de la NNA
 - Respaldo estadístico, realizada en base a información tomando en cuenta la línea de base
 - Construcción participativa y evaluación periódica en base a indicadores
 - Concordancia, con contenidos vinculados a los planes plurinacional y departamental de NNA y al PTDI municipal. (Art 21 Ley N° 120/2018)

Se definen como prioridades del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 las siguientes (Art 22 Ley N° 120/2018):

- Lucha contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes;
 - Atención a la primera infancia;
 - Protección integral a NNA en actividad laboral;
 - Atención y apoyo a NNA con discapacidad;
 - Prevención de la trata y tráfico de NNA;
 - Prevención y protección del embarazo adolescente;
 - Prevención y protección integral a NNA con problemas de situación de calle y con problemas de conducta;
 - NNA en situación de abandono
 - Prevención de la afiliación a pandillas;
 - Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias controladas;
 - Gestión de la calidad de los servicios y programas del GAM;
 - Migración adolescente;
 - Creación y uso de base estadística e información.
- ✓ Describe que el sistema municipal integral de la niña, niño y adolescente tiene como atribución el diseño, elaboración, implementación y monitoreo del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 (Art 23 Ley N° 120/2018) a través del congreso municipal de derechos de la niña, niño y adolescente que tiene la atribución de aprobar y evaluar el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 (Art 27 II. Y 29 Ley N° 120/2018), que debe contemplar también la participación del Comité Municipal de la NNA (Art 30 y 33 b) Ley N° 120/2018) y que debe ser implementado en coordinación con el Consejo Municipal intersectorial de la NNA (Art 35 y 36 b) Ley N° 120/2018)
 - ✓ La ley autonómica N° 301/2022 Ley Municipal de política de asistencia integral a Niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de feminicidio, que define medidas de asistencia integral para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad hijos de víctimas de feminicidio, que garanticen sus derechos y aseguren condiciones dignas para el desarrollo

integral con igualdad y equidad, mediante la persona o personas que tengan la condición de guardadora o guardador, tutora o tutor legal, dispuesta por autoridad judicial competente en materia de niñez y adolescencia.

Se establece el registro municipal de NNA hijos de víctimas de feminicidio; los pasos de la ruta de atención que debe implementar la DNA, que además deberá brindar atención psicológica, y en casos excepcionales en que no pueda coordinar con SEDEGES o SEDEPOS; Y se definen medidas de promoción de inserción laboral del responsable de las NNA víctimas de feminicidio y la exención del 20% en impuestos municipales.

- ✓ Ley N° 48/14, Ley de declaración del día municipal de la niña en el municipio de Sucre, el 21 de octubre, con la finalidad de erradicar la desigualdad de género y la violencia en contra de las niñas, a través de la socialización para fomentar el respeto a los derechos de las niñas en cuanto a la prevención de violencia y discriminación y el desarrollo de políticas municipales.
- ✓ Ley N° 213/ 2021 ley municipal autonómica para la prevención, rehabilitación, y reinserción social de personas bajo la dependencia de alcohol y drogas, que tiene el objeto de construir políticas públicas en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de adicciones, privilegiando los derechos humanos y la igualdad de género. Prioriza entre las políticas de prevención, fortalecer los programas de prevención municipal sobre el consumo de alcohol y drogas priorizando la introducción de métodos interactivos para el abordaje del tema dirigido a niñas, niños y adolescentes, donde se incluyan a los padres o tutores, para reforzar aprendizaje en referencia a la realidad del consumo de alcohol y drogas (Art. 7 Ley 213/2021) El Gobierno municipal contara con un Centro municipal para la rehabilitación y reinserción de personas con problemas con dependencia de alcohol y drogas, con infraestructura, equipamiento y personal especializado. (Art 16 Ley 213/2021)

1.3. MARCO INSTITUCIONAL Y COMPETENCIAL

1.3.1. Descripción de roles y atribuciones de los GAM

Es muy importante resaltar que el Código Niña, Niño y Adolescente, determina como atribuciones de los Gobiernos Autónomos Municipales, las siguientes:

- a) Ejercer la rectoría municipal para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente.
- b) Diseñar e implementar el Plan Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, en el marco de las políticas nacionales.
- c) Asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad, así como la actualización técnica permanente de las servidoras y los servidores públicos, que presten servicios a la niña, niño o adolescente.
- d) Institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y crearlas en los lugares donde no existan.
- e) Hacer el seguimiento y control de la Política y del Plan Municipal.
- f) Contribuir para la formulación de la Política Nacional, mediante la remisión de información que sea requerida por el nivel central.
- g) Crear una instancia de monitoreo del funcionamiento de los servicios municipales en materia de protección de la niña, niño y adolescente.

- h) Diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las medidas de protección social, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.
- i) Promover la participación de la sociedad a través de actividades de difusión, promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de la niña, niño y adolescente, estimulando la creación de programas de iniciativa privada de acuerdo a las necesidades del municipio.
- j) Promover el conocimiento y difusión de los derechos y garantías de la niña, niño y adolescente, en su jurisdicción; Código Niña, Niño y Adolescente.
- k) Proporcionar información al registro estadístico especializado en niñez y adolescencia, de acuerdo a reglamento.
- l) Apoyar la conformación y funcionamiento del comité municipal de niñas, niños y adolescentes.
- m) Elaborar el informe anual sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en su jurisdicción, con base en los indicadores nacionales, y enviarlo al nivel central; n) Promover la participación de las comunidades sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- n) Otras propias del ejercicio de sus competencias. (Art. 184 CNNA)

Así mismo, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia hacia las mujeres, establece que los gobiernos autónomos municipales, deben articular los instrumentos políticos, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. (Art. 9.5. Ley N° 348)

Además, deberán adoptar medidas específicas destinadas a erradicar toda forma de violencia, contra las mujeres y establecer un nuevo marco social para garantizar el respeto a una vida libre de violencia para lo cual se establece, entre otros, el programa de prevención, en los ámbitos estructural, individual y colectivo que consolide una nueva cultura de respeto hacia las mujeres, a su dignidad y derechos (Art. 914. 1. Ley N° 348)

1.3.2. Descripción competencial de los GAM

Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la función de impulsar el desarrollo económico local, humano, y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo local. (Art. 8.3. Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías - LMA)

Además, el alcalde o alcaldesa tienen la atribución de diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de políticas públicas municipales, que promuevan la equidad social y de género en la participación, igualdad de oportunidades e inclusión. (Art. 26.16. Ley N° 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales)

1.3.3. Descripción alcance funcional de las instituciones locales

Son atribuciones específicas de las **Defensorías de la Niñez y Adolescencia** las siguientes (Art. 188 CNNA con Modificaciones por la Ley N° 1139):

- a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso.

- b) Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso.
- c) Remitir a conocimiento de la autoridad judicial, los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo.
- d) Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que no se otorgue prioridad en la atención a la niña, niño o adolescente.
- e) Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente.
- f) Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de la niña, niño y adolescente ante cualquier instancia administrativa o judicial.
- g) Llevar un registro del tiempo de permanencia de la niña, niño o adolescente en centros de acogimiento.
- h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado.
- i) Demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de autoridad materna, paterna o desconocimiento de filiación.
- j) Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, e informar a la Instancia Técnica Departamental de Política Social.
- k) Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor.
- l) Promover reconocimientos voluntarios de filiación u orientar para hacer efectiva la presunción de filiación.
- m) Promover acuerdos de asistencia familiar para su homologación, de oficio por autoridad competente.
- n) Agotar los medios de investigación para identificar a los progenitores o familiares, y procurar el establecimiento de la filiación con los mismos en caso de desprotección de la niña, niño o adolescente, conforme al reglamento de la instancia municipal.
- o) Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, niños o adolescentes, ante la Autoridad Central o ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo al caso.
- p) En coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador.
- q) Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- r) Exigir a otras instancias de los Gobiernos Autónomos Municipales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Código.
- s) Crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social.
- t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente.
- u) Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente.
- v) Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescente en situación de calle.
- w) Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda.

- x) Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol u otras drogas.
- y) Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el presente Código.
- z) Generar y remitir a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, la información necesaria para el sistema nacional de información.
- aa) Realizar la inventariación de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la niña, niño o adolescente, en los casos que corresponda.
- bb) Expedir citaciones en el ejercicio de sus atribuciones.
- cc) Verificar las denuncias de violencia con facultades de ingreso a lugares públicos.
- dd) Realizar acciones para la recuperación de los enseres personales y útiles escolares, en los casos que corresponda.
- ee) Verificar en las terminales, la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales.
- ff) Autorizar la actividad laboral por cuenta propia y ajena realizada por adolescentes;
- gg) Registrar obligatoriamente las autorizaciones de la actividad laboral por cuenta propia y por cuenta ajena realizada por adolescentes."

Por otro lado, la Ley Municipal de niñez y adolescencia de Sucre, establece que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, además de las atribuciones dispuestas en el Código Niña, Niño y Adolescente, tienen las siguientes atribuciones (Art. 47 Ley N° 120/2018):

- Coadyuvar en la formulación y ejecución del Plan Municipal de NNA
- Implementar tecnologías de comunicación e información para el manejo administrativo en la atención de casos y otras responsabilidades
- Mantener actualizado el Sistema de Registro Municipal de casos atendidos y remitir la información a las instancias competentes
- Definir y aplicar de manera obligatoria el Protocolo de atención y seguimiento de NNA en Centros de Acogida, promoviendo la restitución de sus derechos
- Constituirse en parte denunciante o querellante en contra de las personas naturales o jurídicas que amenacen, restrinjan o vulneren los derechos de NNA, debiendo solicitar la imposición de sanciones
- Elaborar informes periódicos de gestión y resultados alcanzados en cumplimiento de sus atribuciones
- Otras atribuciones que serán desarrolladas en el Reglamento dentro del marco de la presente ley.

Además, se establece que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia serán parte del Sistema Municipal Integral de la niña, niño y Adolescente (Art. 6. I. j) Reglamento Ley N°120/2018) y participaran en el Congreso Municipal de niñez y adolescencia y del Consejo Municipal Intersectorial de niñez y adolescencia (Art. 9.f); 16.7) Reglamento Ley N°120/2018).

Y El Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de vulneración a La Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de Justicia establece que *el acompañamiento y seguimiento a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia son las acciones de ayuda y apoyo durante todo el proceso que las entidades promotoras de la denuncia, y con carácter obligatorio las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, deben brindar a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso de sus derechos.*

El acompañamiento que efectúa el equipo multidisciplinario de la DNA consiste en: Brindar terapias psicológicas a la víctima desde la apertura de la denuncia hasta la finalización del proceso penal. Asimismo, la DNA podrá coordinar con instancias, tanto gubernamentales (SEDEGES, CEPATs) como no gubernamentales especializadas en la atención de violencias, la realización de terapias psicológicas a la víctima para su tratamiento y restitución psico-emocional.

Las y los funcionarios de la DNA deberán realizar un acompañamiento psico-social legal oportuno, con calidad y calidez durante todas las etapas y momentos que precise, ofreciendo seguridad y confianza desde el inicio del proceso pasando por su conclusión hasta llegar a obtener el resarcimiento integral del daño sufrido por la víctima

En materia de **salud**, en el marco de las competencias concurrentes de la ley marco de autonomías, se establece, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas y rurales; la ejecución de programas de protección social; la ejecución de las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos públicos y de servicios, centros laborales, educativos, de diversión, de expendio de alimentos y otros con atención a grupos poblacionales, para garantizar la salud colectiva. (Art. 81 III.2.)

En el marco de las competencias concurrentes establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y disposiciones legales, las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones referidas a la **gestión educativa**: Gobiernos Municipales: a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción. b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia. (Art. 80 2. A y b Ley N° 070)

Además, el Gobierno Municipal tiene las competencias concurrentes de planificación y asistencia técnica para la implementación de los Planes Municipales de Educación (Los planes contendrán proyectos educativos bajo las directrices nacionales, cofinanciado por el Gobierno Nacional); Provisión de servicios de alimentación complementaria escolar en los niveles inicial, primaria y secundaria de las unidades educativas públicas y de convenio; Servicios de transporte escolar; Implementación de internados escolares y hospedajes; Generación de becas escolares e incentivos; Equipamiento, mantenimiento y reposición de equipo informático y software, audiovisuales, bibliotecas de escuelas, bibliotecas de aula y material didáctico; Material de escritorio, limpieza e higiene y seguridad a las unidades educativas; Distribución y conservación de los materiales educativos producidos por el Ministerio de Educación; Promoción de procesos educativos en pueblos indígenas, comunidades rurales y barriales, con base en sus usos y costumbres, en coordinación con instancias nacionales; Apoyo a procesos de educación en medio ambiente y conservación de la biodiversidad desde un enfoque transversal; Construcción y mantenimiento de centros culturales en las unidades educativas (DS 28421, DS 29565, Ley 144)

Los consejos municipales de **seguridad ciudadana** compuestos por autoridades municipales, policiales y de organizaciones sociales y juntas vecinales, (Art. 21 Ley N° 264) tienen la atribución de aprobar, ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana con la activa participación de la sociedad civil (Art. 11 y 23 Ley 264), podrán crear observatorios de seguridad ciudadana, para recopilar, procesar, analizar e interpretar información

sobre seguridad ciudadana, los delitos y otras (Art. 24. 4. Ley 264) además los Gobiernos Autónomos Municipales deben realizar las siguientes acciones en relación a la seguridad ciudadana:

- Coordinar con la policía boliviana y educación la planificación e implementación de proyectos educativos, estrategias y campañas de comunicación social educativa en materia de seguridad ciudadana (Art. 62 Ley N° 264)
- Crear y dirigir programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social y a personas drogodependientes y alcohólicas (Art. 66 Ley N° 264)
- Creación y funcionamiento de los centros de capacitación laboral productiva al interior de los recintos penitenciarios para promover el trabajo remunerado y la reinserción laboral (Art. 68 Ley N° 68)

Otras atribuciones que tienen los Gobiernos Autónomos Municipales son la generación de estadísticas municipales (Art 302. I. 9 CPE); el deporte en el ámbito de su jurisdicción (Art 302. I. 14 CPE); Y la creación, mantenimiento y atención de los centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros municipales (Art 302. I. 25 CPE)

En materia de atención a la **primera infancia**, la ley N° 323/23, Ley municipal de desarrollo integral para la primera infancia en los centros infantiles del municipio de Sucre, que tiene por objeto motivar el desarrollo integral de la primera infancia en los centros infantiles del municipio para alcanzar una mejor calidad de vida, garantizando la educación y desarrollo integral de la primera infancia de manera integral e intersectorial, mediante la implementación de, modelo de calidad para la atención y desarrollo, en el marco del modelo sistémico de prevención, atención, cuidado y protección social, en corresponsabilidad con padres de familia, educadores, facilitadores y autoridades municipales.

Los centros infantiles municipales para el desarrollo infantil promoverán el desarrollo integral a través de los siguientes ejes:

- Desarrollo cognitivo y psicomotriz (área pedagógica)
- Desarrollo afectivo y emocional (trabajo social y psicología)
- Crecimiento y desarrollo físico (Salud, nutrición, fisioterapia y psicomotricidad)

En materia de **familia**, la Ley N° 58/15, Ley para la integración familiar del gobierno autónomo municipal de Sucre, que tiene por objeto la implementación del Programa municipal de asistencia social a la familia desconcentrada, multidisciplinario e institucionalizado, que fortalezca la integralidad y protección de la familia. Que es un servicio municipal gratuito y permanente, que promueve la integración familiar, a través de servicio social, psicológico, ético – moral, pedagógico y jurídico, que busca velar por la protección, desarrollo, información y promoción de los derechos de la familia. Programa que cuenta con:

- Centros municipales de apoyo especializados en la integración familiar, que ejecuta proyectos y actividades destinados a promover la integración familiar, que tiene entre otros objetivos, la promoción y prestación de asistencia social, psicológica, ética – moral, pedagógica, jurídica y consejería familiar dirigida entre otros a padres de familia, niñas, niños, adolescentes, con enfoque de prevención de la desintegración familiar y fortalecimiento de principios y valores de la familia; e intervenir acciones psico – educativas en familias en alto riesgo social o en situación de calle, en coordinación con otras entidades públicas o privadas.

- La escuela de padres, que tiene entre otros objetivos el de promover la comunicación asertiva y escucha dentro del núcleo familiar; asesorar, sensibilizar y concientizar a los padres de familia para atender problemas de alcoholismo, drogadicción, adulterio, pornografía, prostitución y otros.
- El centro municipal de estadística – área social, que tiene entre otros objetivos el de realizar estudios e investigaciones en el municipio sobre temas relacionados a la familia, abandono familiar, migración, deserción escolar, consumo de alcohol, drogas, pornografía, prostitución, equidad de género, democratización de roles y otros.
- Las Unidades móviles de prevención, prestar servicios de orientación familiar, y otros para el bienestar de la familia.

De acuerdo a las normativas vigentes tanto nacionales como autonómicas anteriormente mencionadas, son diferentes instancias las responsables de desarrollar acciones de prevención, atención y protección, a nivel municipal destacamos las siguientes:

MUNICIPALES	COMPETENCIAS O ATRIBUCIONES	Entidades con las que deben coordinar
PREVENCIÓN		
Servicio de capacitación y educación en prevención en consumo de drogas y lucha contra la violencia – GAM	Prevención primaria y secundaria, estructural, individual, colectiva y comunitaria en coordinación intersectorial, interinstitucional, inter gubernativa	• Policía – Seguridad Ciudadana • Dirección de Educación • SEDES • CEPAT – GAD • SEDEGES – GAD • JIO – GAD • Medios de comunicación • Organizaciones de Sociedad Civil (ONGs, Fundaciones)
Defensoría de la Niñez y Adolescencia – GAM	Prevención terciaria, brindar atención integral a víctimas de violencia y de vulneración de derechos (para la reparación del daño y la reintegración familiar, educativa y social) y a adolescentes con responsabilidad penal (para la responsabilización del hecho)	
CIDIM – GAM	Prevención primaria y secundaria con niñas y niños de la primera infancia y sus familias a través de la implementación del modelo sistémico de prevención, atención, cuidado y protección social, en el marco del modelo sistémico de prevención	
Unidad de Familia – GAM	Prevención primaria y comunitaria: Unidades móviles de prevención (orientación familiar) Abordaje con enfoque de prevención de la desintegración familiar y fortalecimiento de principios y valores de la familia; a través de los Centros municipales de apoyo especializados en la integración familiar y las escuelas de padres	
SLIM – GAM	Prevención estructural, individual, colectiva y comunitaria	
Salud - GAM	Prevención primaria y terciaria con víctimas de violencia con la aplicación de protocolos de atención a víctimas de violencia física y sexual, y de la ILE	
Educación – GAM	Prevención Primaria y en el ámbito educativo a través de Planes de convivencia pacífica y armónica, proyectos comunitarios educativos y desarrollo	

	curricular con enfoque de derechos, genero, EIS, prevención de la violencia y del embarazo en adolescentes	
Seguridad ciudadana – GAM	Prevención primaria: proyectos educativos, estrategias y campañas de comunicación social educativa en materia de seguridad ciudadana Prevención terciaria con agresores y adolescentes con responsabilidad penal: Programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social y a personas drogodependientes y alcohólicas. Centros de capacitación laboral productiva al interior de los recintos penitenciarios	• Policía • Educación • Centros de rehabilitación de alcohol y drogas • Centros de reintegración social • Régimen penitenciario • Ministerio de trabajo, empleo y previsión social • GAD
ATENCIÓN		
Defensoría de la Niñez y Adolescencia	Atención bio- psico-socio- legal durante todo el proceso hasta la reparación integral del daño	• Juzgados NNA y Mixtos • Fiscalía • Policía • Defensa Pública • SEDEGES • CEPAT • SEPDAVI • UAPVT • SIJPLU • Servicios de atención psicológica • SEDES • Subsistema de protección judicial • Subsistema penal adolescente • Organizaciones de Sociedad Civil (ONGs, Fundaciones)
PROTECCIÓN SOCIAL		
Unidad de Familia- GAM	Desarrollar acciones psico – educativas en familias en alto riesgo social o en situación de calle a través de centros municipales de apoyo especializados en la integración familiar	• SEDEGES • SEDES • Dirección de Educación • Subsistema de protección social • Organizaciones de Sociedad Civil (ONGs, Fundaciones)
Programa de protección social para niñas, niños y adolescentes trabajadores- GAM	Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo y sus familias brindándoles atención nutricional, educativa y social, desde un enfoque preventivo y de restitución de derechos, para que menores de 14 años dejen de trabajar, mayores de 14 años tengan trabajo digno y se erradiquen los trabajos prohibidos y peligrosos	
CIDIM- GAM	Brindar atención para el desarrollo integral de la primera infancia en los centros infantiles del municipio para alcanzar una mejor calidad de vida, garantizando la educación y desarrollo integral de la primera infancia de manera integral e intersectorial, mediante la implementación de, modelo de calidad para la atención y desarrollo, en corresponsabilidad con padres de familia, educadores, facilitadores y autoridades municipales.	

Fuente: Elaboración propia en base a normativa vigente

Para lograr una adecuada prevención y atención integral, es fundamental que las diferentes instancias del Gobierno Autónomo Municipal desarrollen y fortalezcan su capacidad de

coordinación interinstitucional, intergubernativa e intersectorial para implementar programas coordinados entre todas las instancias llamadas por ley, desarrollando acciones estratégicas de mediano y largo plazo conjuntas que permitan mejorar el impacto de sus acciones, optimizando recursos económicos, logísticos, técnicos y humanos especializados.

2. DIAGNOSTICO - SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE

2.1. CONTEXTO

2.1.1. Demografía y pobreza

- **Ubicación geográfica**

El Municipio de Sucre se encuentra en el departamento de Chuquisaca, que se extiende con una superficie de 51.524 km². Y se encuentra ubicado en el sudeste del país. Limita al norte con los Departamentos de Potosí, Departamento de Cochabamba y el Departamento de Santa Cruz; al sur con el Departamento de Tarija; al este con el Departamento de Santa Cruz y la República de Paraguay y al oeste con el Departamento de Potosí.

Sucre cuenta con una superficie de 1.876,91 km². y forma parte de la unidad geomorfológico denominada “Cordillera Andina Oriental”. La topografía por tanto es disectada, con predominancia de cerros y montañas y reducidas superficies planas aptas para cultivo, situadas en la zona norte de la sección y en terrazas de ríos. El clima dominante es templado sub – húmedo.

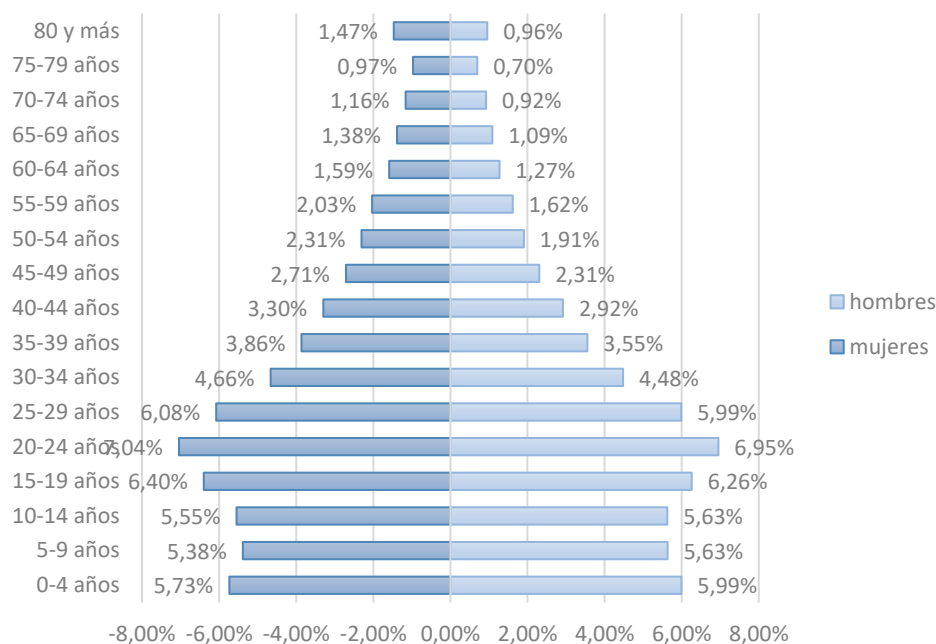
- **Población del municipio**

En el Municipio de Sucre, de acuerdo a las proyecciones al 2020 se estima una población de 353.996 habitantes, (treientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y seis) equivalente al 54 % de la población en Chuquisaca que es de 654.035 habitantes (de acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020, UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística.)

Del total de habitantes de Chuquisaca el 49% son Hombres y el 51% son mujeres. En Sucre el 48,6% de la población son hombres y el 51,4% mujeres, de acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020.

- **Población de niñas, niños y adolescentes: estructura según grupo etario.**

Sucre es un municipio Joven, del total de la población de Sucre 137.627 son infantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 19 años que equivalen al 38.88% de la población total del municipio.

Pirámide Poblacional Municipio de Sucre

Fuente. PMPEA en base a datos UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, proyecciones poblacionales - revisión 2020

De acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020, UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 19 años de Sucre:

- El 25,2% son infantes de 0 a 4 años (34.648)
- El 23,7% son niños y niñas de 5 a 9 años (32.557)
- El 24% son niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años (33.019)
- Y el 27,2% son adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (37.403).

Del total de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 19 años de Sucre el 51,2% tiene entre 10 a 19 años y el 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres.

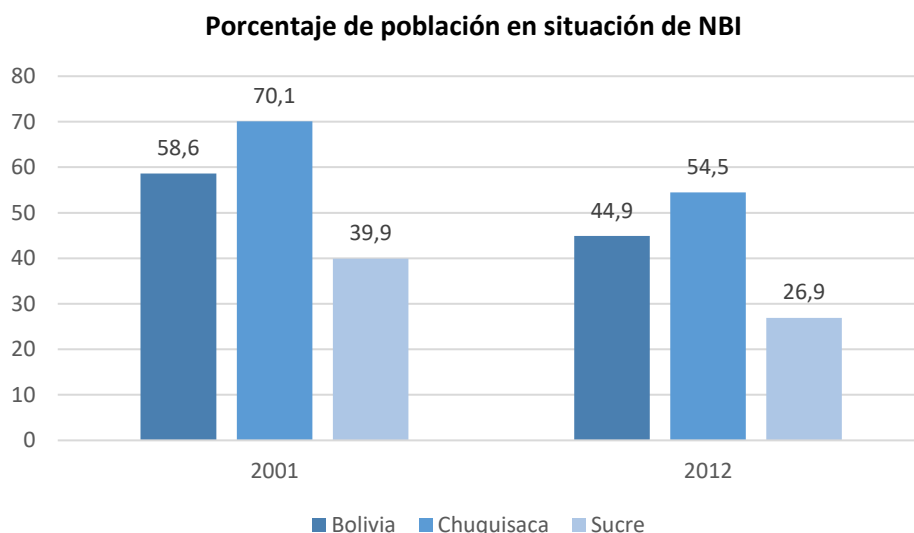
- **Población urbana y rural**

CLASIFICACIÓN DISTRITOS	POBLACIÓN (CENSO 2012)	%	SUPERFICIE (HA)	%	DENSIDAD (HAB/HA)
DISTRITOS URBANOS					
Distrito 1	19.393,00	7,42%	229,45	0,13%	85
Distrito 2	105.533,00	40,40%	1.064,00	0,62%	99
Distrito 3	54.021,00	20,68%	1.384,00	0,80%	39
Distrito 4	26.960,00	10,32%	426,71	0,25%	63
Distrito 5	29.132,00	11,15%	335,46	0,19%	87
Sub Total	235.039,00	89,97%	3.439,62	2,00%	69
DISTRITOS RURALES					
Distrito 6	8.639,00	3,31%	34.880,69	20,26%	0,13
Distrito 7	8.751,00	3,35%	84.086,84	48,84%	0,1
Distrito 8	8.772,00	3,36%	49.762,02	28,90%	0,18
Sub Total	26.162,00	10,02%	168.729,55	98,00%	1,13
Total	261.201,00	100%	172.169,17	100%	1,52

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Además, es importante tomar en cuenta que el municipio de Sucre, se distribuye en 8 distritos, de los cuales 5 distritos están en el área urbana con una población de 235.039 habitantes, y los 3 distritos rurales cuentan 26.162 habitantes. El Distrito 2, concentra el mayor porcentaje población, con un 40% y es el segundo en superficie entre los Distritos urbanos, entre los distritos rurales el de mayor porcentaje de población corresponde al Distrito 8, con un 3,36% (PTDI Sucre 2021-2025 en base al CNPV 2012)

- **Caracterización de la pobreza: índice de pobreza**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, CNPV 2012

En el municipio de Sucre la tasa de pobreza se ha reducido significativamente del año 2001 al 2012, el porcentaje de población en situación de necesidades básicas insatisfechas redujo en un 13% alcanzando al 26,9% de población en situación de pobreza con rezago y brechas en el acceso a la educación, a la salud y a la falta de calidad de los servicios públicos al 2012.

Por otro lado, podemos identificar que la Encuesta ODS Sucre 2018 (EODS, 2018) evidencia que para ese año, el 24,8% de las personas en el municipio eran pobres por NBI, con mayor concentración en los distritos rurales, especialmente en el distrito 8, donde el 76% de su población era pobre: 35,8% en la indigencia, 38,9% en pobreza moderada y 1,5% en marginalidad.

La pobreza medida a través de las NBI, muestra que el 24,8% de las personas en el municipio de Sucre son pobres frente a un 75,3% no pobre. La población pobre se encuentra más concentrada en los distritos rurales, en especial el distrito 8, donde el 76% de la población es pobre, de la cual el 34,8% se encuentra en la indigencia y el restante 39% en la pobreza moderada. Por otra parte, los distritos urbanos 2 y 4 son los que tienen un mayor porcentaje de población no pobre con un 71,4% y 54,5%, respectivamente. Los distritos más vulnerables por caer en la pobreza son el 5 y 6, ya que cerca de un 40% y 35% de su población, es vulnerable al encontrarse en el umbral de la pobreza. (Encuesta ODS 2019, PNUD. Proceso de datos: Real Data)

En esta línea de reflexión, la Agenda municipal ODS 2030 de Sucre describe cómo Bolivia es uno de los países con mayores porcentajes de empleo informal en la región. El informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), indica

que en países como Guatemala, Nicaragua o el Estado Plurinacional de Bolivia el trabajo informal tiene un alcance próximo al 80%. En el sector comercial mayorista y minorista, el informe menciona que la informalidad llega a superar el 90% en el país, cifra también alcanzada en el sector transporte, entre otros.

En Sucre, los distritos con mayores niveles de desocupación son los de las áreas periurbanas como el 4, seguido del 2 y el 5. Los ciudadanos de los distritos rurales son los que menos desocupación declararon, ya que su actividad está más relacionada con la actividad agrícola. El distrito 2 el que concentra mayor proporción de personas ocupadas (30%), seguido del distrito 3 (22%). La población masculina ocupada (53%) es mayor en seis puntos porcentuales a la participación de las mujeres en la población ocupada (47%).

El 43,8% corresponde a trabajadores informales; es decir, que no cuentan con protección social, frente a un 55,7% de trabajadores formales. Dentro de la informalidad, el 35,8% son trabajadores por cuenta propia o independientes, seguidos de los trabajadores familiares o aprendices con un 6,5%, siendo en su mayor parte mujeres, y empleadas del hogar con un 1,5%.

La situación de los trabajadores informales de ambos sexos, y especialmente la de las mujeres y las personas jóvenes, indígenas y migrantes es más vulnerable por lo que se deben asumir medidas urgentes de mitigación. En Sucre el 48 % de los empleados de MIPyMEs son jóvenes de hasta 28 años, el 35 % padre o madre soltera. Debido a la precaria inserción laboral de las mujeres y su mayor participación en el trabajo informal, estas se encuentran en una situación aún más vulnerable. (Agenda municipal ODS 2030 de Sucre. GAM Sucre 2022)

Aunque en Sucre, existió una mayor contratación de mano de obra a nivel local en 2021, toda vez que la tasa de ocupación creció un 11,72%, este incremento no repercutió directamente en el nivel de desempleo, que se incrementó un 3,95%, menor a la media nacional (17,36%), respecto a la gestión anterior. (Encuesta continua de empleo. INE 2021)

En este sentido es necesario resaltar que Sucre muestra una importante desigualdad en términos de ingreso, reflejado en el índice de GINI de 24,3%.

La inequidad socioeconómica entre mujeres y hombres se puede explicar también porque las mujeres siguen relegadas a los sectores vinculados con sus roles tradicionales de género y también con el trabajo domestico no remunerado y tareas de cuidado que recaen a mujeres y sobre todo en las más pobres, sumiéndolas en un circulo vicioso de informalidad y precariedad laboral.

A esto se suma que, de acuerdo al INE, entre el 2008 y el 2015, la brecha salarial entre hombres y mujeres se incremento de 60 a 410 bs., es decir que mientras las mujeres no registran un incremento en su salario, los hombres tienen un incremento de mas del 680%. Además, el ingreso promedio de la mujer se sitúa un 44% superior al salario mínimo establecido en la norma, y no cubre el valor de la canasta familiar (solo representa el 78%), por lo que una familia monoparental, con jefatura de una mujer y con un promedio de 3 hijos, no puede mantener a su familia, obligando al trabajo infantil. (Mujer por tus derechos, senderos de luchas conquistas y flagelos de violencia: Una mirada desde el municipio de Sucre. 2018)

Por otro lado, el estudio Milena (UNFPA 2022), denota que el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan definitivamente en el desarrollo local social y económico de las mujeres, y no solo puede resultar perjudicial para el desarrollo personal de las niñas, niños y adolescentes y su entorno familiar, sino también genera costos a nivel agregado. Este análisis denota que las mujeres que fueron madres en la adolescencia ganan en promedio un 28,1% menos que las mujeres que postergan su maternidad a la vida adulta. La brecha que se genera por la diferencia entre el ingreso laboral promedio anual de las mujeres que fueron madres en la adolescencia y entre quienes lo fueron en la vida adulta joven, representa una pérdida de 322,4 millones anuales en términos de ingresos generados por la población femenina, según base de datos procesada en la encuesta de hogares 2019. A esto se suma que la tasa de desempleo es mas alta cuando se trata que fueron madres en la adolescencia (5,7%) en relación a las mujeres que fueron madres a la edad adulta joven con el 3,5% (Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Bolivia. Ministerio de salud y deportes 2022)

En este marco, vemos que el empleo es un tema crítico en el desarrollo de las economías locales y aún más después de la crisis sanitaria por COVID-19 que profundizó las condiciones de un mercado laboral caracterizado por la escasez del empleo formal, la creciente informalidad y la precarización de las condiciones de trabajo, donde poblaciones como las madres adolescentes se ven aún más afectadas. Durante la gestión 2020, las restricciones a la movilidad y las dificultades para acceder a los recursos productivos derivaron en una mayor pérdida de fuentes de trabajo e ingresos de las familias, consolidando condiciones que ya eran propias del mercado laboral de Sucre y que tienen que ver con la migración del capital humano, la informalidad y la invisibilización de los aportes del sector productivo rural y periurbano a la dinámica económica del municipio. (Agenda municipal ODS 2030 de Sucre. GAM Sucre 2022)

2.1.2. Gasto social

- **Magnitud y estructura del gasto social del presupuesto municipal**

De acuerdo al Informe rendición publica de cuentas POA 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el año 2022 el municipio tuvo un presupuesto de 449.406.906,00 bs en ingresos y 90.972.709,23 de gastos, con un super habit de 358.434.196,77 bs

PRESUPUESTO 2022 (Expresado en bolivianos)

Descripción	Presupuesto aprobado (LM N° 210/2021)
Ingresos	449.406.906,00
Gastos	90.972.709,23
(Déficit) / Superávit	(358.434.196,77)

Fuente: Informe rendición publica de cuentas POA 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 2022.

Presupuesto del que se asignaron los siguientes montos a las diferentes direcciones, unidades, servicios y programas dependientes de la Secretaria Municipal de desarrollo humano y social y la Dirección de Gestión Social:

Categoría programática Presupuesto ejecutado en Bs	Unidad	Beneficiarios
454.441,04	Unidad Municipal de atención a personas con discapacidad UMADIS – CMRPDV	961 usuarios atendidos por el equipo multidisciplinario.
305.658,74	Centro integral de desarrollo infantil municipal de la niñez y la familia	25 padres y madres formados en la escuela municipal de padres • 46 niños y niñas beneficiarios con la atención integral • 9 educadoras y manipuladoras de alimentos formadas en atención a la primera infancia • 500 personas beneficiarias de las ferias realizadas
693.949,36	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL CIDIM CENTRAL	90 niños, niñas beneficiados por mes.
665.771,86	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL CIDIM CAMPESINO	45 niños y niñas beneficiados con una buena nutrición complementaria, protección y desarrollo óptimo en estimulación a la primera infancia.
653.210,81	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO GUARDERIA LUSAVI FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO GUARDERIA LUSAVI	• 40 Niños y niñas de CIDIM LUSAVI
245.740,00	APOYO A LA FUNDACIÓN AMAZONIA HOGAR MALLORKA Y MISKI HUASI	
101.048,77	PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA	• 1937 Estudiantes de Secundaria • 382 Estudiantes de Primaria • 382 Padres de familia de Primaria • 540 Maestras y maestras de la las Unidades Educativas del Municipio de Sucre capacitados. • Población atendida de manera General: 3251 Beneficiarios
1.445.249,97	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-URBANO Y RURAL	• 9.935 Casos atendidos a Niñas, Niños y Adolescentes de los 8 distritos del Municipio de Sucre
31.988,98	FUNCIONAMIENTO HOGAR TRANSITORIO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	• 231 Niñas, Niños y Adolescentes acogidos de manera circunstancial
359.437,68	PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NATs Y ADOLESCENTES TRABAJADORES	100 niños, niñas y adolescentes Beneficiados del Programa de protección social a NATs y adolescentes trabajadores
1.193.252,92	PROGRAMA DE PROTECCION INTEGRAL Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1,435 niños y niñas beneficiados con una buena nutrición complementaria, protección y desarrollo óptimo en estimulación a la primera infancia. • 1,200 familias beneficiadas de los 8 distritos municipales (47 centros iniciales guarderías, 156 educadoras)

Fuente: Elaboración propia en base a Informe rendición pública de cuentas POA 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 2022.

Llama la atención la diferencia económica presupuestada a equipos interdisciplinarios de DNA y SLIM que llegan a una población menor (SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL – S.L.I.M. + IDH con un presupuesto ejecutado de 2.023.879,85 bs, y 3.366 casos atendidos por los equipos multidisciplinarios, además de 2 talleres y 1 encuentro de promotoras).

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre también tiene asignado presupuesto en otras unidades que indirectamente benefician a las niñas, niños y adolescentes (pero no cuenta con una desagregación de información), entre los que destacamos los siguientes:

Categoría programática Presupuesto ejecutado en Bs	Unidad	Beneficiarios
60.705,10	ÁREA DE ASUNTOS ÉTNICOS GÉNERO Y GENERACIONAL	beneficiaron 7.636 personas entre Niños, Jóvenes, Adultos, Hombres, Mujeres y Población Vulnerable en General del Municipio de Sucre.
4.369.000,00	AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,883 Personas con Discapacidad que fueron beneficiadas con el bono mensual de Bs. 250 mediante caja Nº 2 de Ex Hotel Municipal de los diferentes meses.
53.803,42	CASA DE ACOGIDA	39 mujeres víctimas de violencia con sus dependientes acogidos en la casa de acogida a la mujer en situación de violencia
255.413,73	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A LA FAMILIA	193 atenciones Psicológica, Jurídicas y Sociales. • 71 alumnos que ingresaron a la Escuela Municipal de Padres que corresponde a los pabellones de Población (23 hombres) pabellón 4 (23 hombres) y bloque mujeres 15 alumnas.
214.500,93	FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS JUVENTUDES	A 5061jóvenes y adolescentes beneficiados en el Municipio de Sucre
84.092,29	PROGRAMA JUVENTUDES – CENTRO JUVENIL DE EMPLEO	A 2123 jóvenes y adolescentes beneficiados en Municipio de Sucre

Fuente: Elaboración propia en base a Informe rendición pública de cuentas POA 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 2022.

Por otro lado, es importante resaltar que los recursos asignados a seguridad ciudadana cubren costos de actividades preventivas puntuales en festividades, no se asignan recursos para programas permanentes o campañas de prevención de violencia, excepto por algunos gastos en brigadas escolares y vecinales, y el resto de recursos se asigna al funcionamiento de los espacios de atención policial, toda vez que se registran los siguientes gastos:

Categoría programática Presupuesto ejecutado en Bs	Unidad
592.300,94	CONTROL URBANO Y SEGURIDAD CIUDADANA
563.459,66	FORTALECIMIENTO A LA FELCV
991.204,00	ADQUISICION DE VEHICULOS EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA
159.518,32	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD CIUDADANA
101.783,90	ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
2.610.068,95	FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS MUNICIPALES

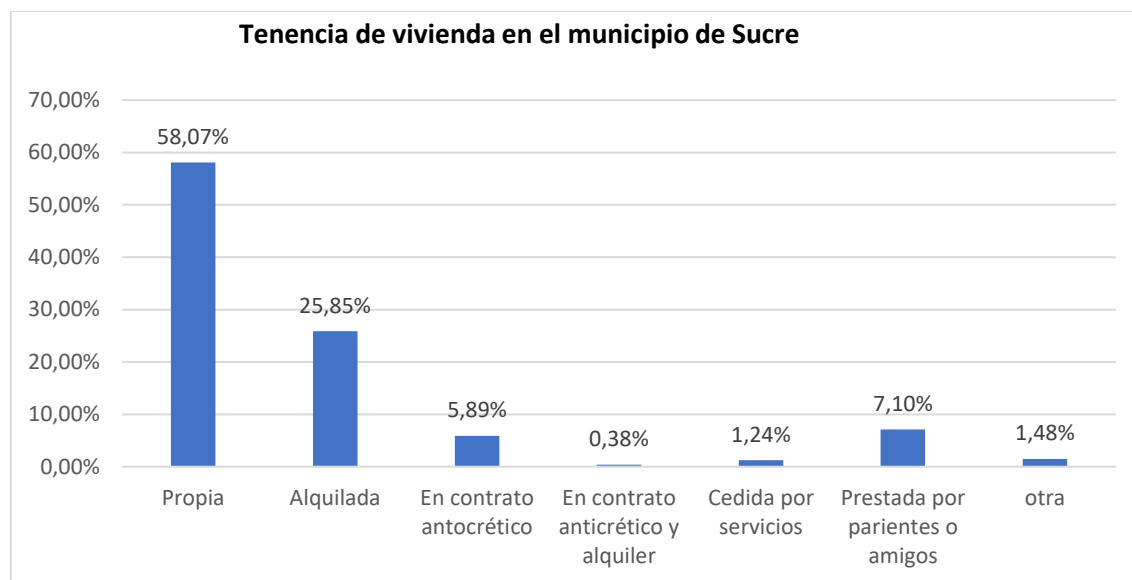
Fuente: Elaboración propia en base a Informe rendición pública de cuentas POA 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 2022.

2.2. DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

2.2.1. Condiciones de vida

- **Vivienda: tenencia y materiales de construcción**

De acuerdo al PTDI 2021-2025 del Municipio de Sucre, aunque el 58,07% de las población del municipio de Sucre tienen una vivienda propia, alrededor de 29.279 hogares no tienen casa propia.



Fuente: elaboración propia en base a datos INE 2012

En relación a las viviendas es importante resaltar que existe un alto índice de hacinamiento, que se expresa en la cantidad de personas por dormitorio, aunque el 55% tiene hasta 2 personas por dormitorio, en el departamento de Chuquisaca se puede identificar el siguiente detalle:

- Mas de 2 hasta 3 personas por dormitorio el 16,5%
- Mas de 3 personas por dormitorio el 39,6%

Y en viviendas con cuartos multiuso tenemos el siguiente detalle:

- Hasta 2 personas por cuarto multiuso el 82%
- Mas de 2 hasta 4 personas por cuarto multiuso el 20%
- Mas de 4 personas por cuarto multiuso el 5,01%

Respecto a estas características de viviendas con características de hacinamiento, es importante tomar en cuenta que esta situación se puede constituir en un factor de riesgo para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en general, y como un factor de riesgo de violencia sexual en particular.

Si las viviendas no cuentan con las condiciones necesarias para que las niñas y niños puedan realizar diferentes actividades tanto de descanso, como lúdicas y de estudio, no contribuyen a un desarrollo integral, incluso social, debido a la limitada capacidad habitacional para realizar actividades sociales, como trabajos escolares de grupo o juegos con las y los amigos.

Por otro lado, las viviendas de cuartos multiuso pueden incrementar las posibilidades de estrés y de exposición de las niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia al interior de las familias.

Finalmente, los cuartos con presencia de varias personas y multiusos no contribuyen a que las niñas y niños cuenten con espacios de seguridad y privacidad, situación que puede causar diferentes circunstancias negativas como tener que compartir la cama con más personas, de diferentes edades y sexo, presenciar relaciones sexuales entre adultos, amplificando los riesgos de violencia sexual.

- **Servicios básicos:**
 - **Agua: distribución y cobertura de agua potable.**

De acuerdo al PTDI 2021-2025 del GAM Sucre, ELAPAS no cuenta con planos actualizados de ubicación y características de las redes de conducción y distribución por lo que no se puede identificar las zonas construidas que cuentan con el servicio.

En los distritos urbanos (1, 2, 3, 4 y 5) del municipio de Sucre se presentaba una cobertura de agua del 90, 6%, durante la gestión 2012 la cobertura se incrementó en 95,2% respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas la cobertura de agua en el municipio de Sucre ascendió a 91,4% , considerando que el 54, 6 % de los hogares tiene agua por cañería de red, el 10,4% cuenta con una pileta pública para poder acceder al agua, el 11,8% accede al agua por el carro repartidor, el 6,6 % de los hogares cuenta con pozo, y el restante 9,5% de hogares accede al agua en ríos, vertientes, acequias, lagos laguna y curichi.

La zona de influencia rural del municipio de Sucre, está vinculada a una red de abastecimiento de agua no potable, cuyo servicio es de tipo público y en menor proporción de tipo domiciliario; los centros poblados rurales y comunidades nucleadas del Municipio en los tres distritos rurales cuentan con el abastecimiento de agua por cañería (no potabilizada), la misma que se hallan administradas por un comité de Agua, y respaldada por reglamento y estatuto interno elaborado por los mismos beneficiarios que es la que se encarga del mantenimiento de la red y de la distribución y cobranza de consumo de agua no potable en la oficina denominada (Comité de Aguas).

A nivel Rural se tiene un elevado porcentaje de comunidades que no acceden al servicio de Agua Potable. Solo el 27,89% tiene el servicio de manera permanente de agua por tubería que no es potable por no contar con plantas potabilizadoras. El 16,33% no accede de manera adecuada. (información generada por el INE durante el censo 2012 y la base la información secundaria dotada por la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre ELAPAS)

- **Servicios sanitarios**

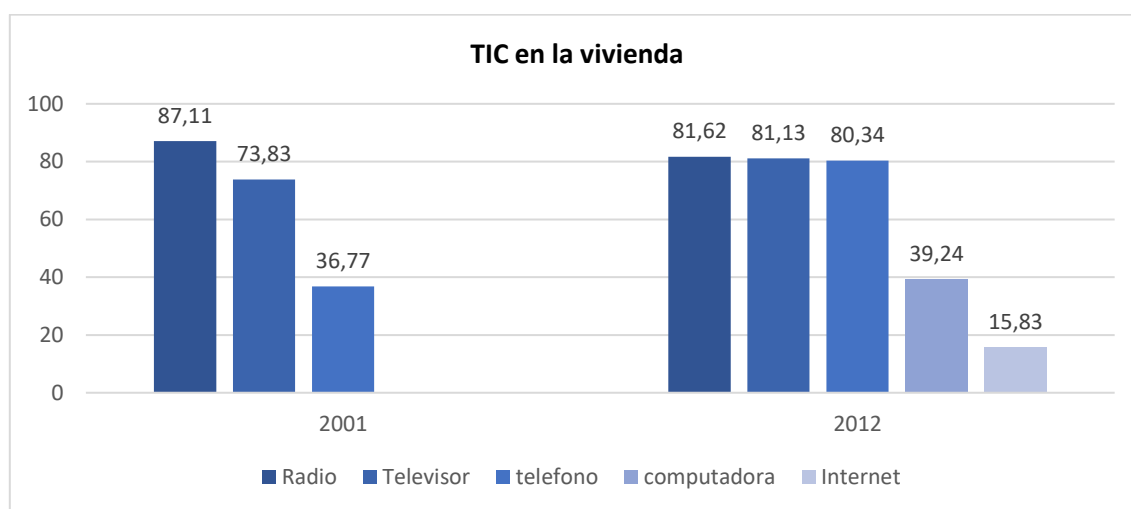
El servicio de saneamiento básico en la ciudad de Sucre, que comprende cinco distritos municipales, la empresa encargada de prestar el servicio es la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre, (ELAPAS). El área de concesión para el servicio es el mismo del Agua Potable. Para la gestión 2018 según información secundaria la empresa ha logrado realizar alrededor de 46.473 conexiones domésticas, 2.368 conexiones comerciales, 19 industriales y alrededor de 904 conexiones en establecimientos públicos. Para la misma gestión la cobertura de alcantarillado para la ciudad de Sucre fue de 90,46% y alrededor de 9,54% de las viviendas no tienen el servicio de alcantarillado.

Según datos del censo 2012, en lo referente a servicios de desagüe del servicio sanitario de un total de 55.623 viviendas establecidas en la ciudad de Sucre, 53.726 viviendas contaban con servicio de alcantarillado que representa el 96,6%, alrededor de 646 viviendas eliminaban a un pozo ciego que es el 1,7% y alrededor de 544 viviendas evacuaban a una cámara séptica que representa el 1,0% y el resto de las viviendas desaguaban a las otras formas de eliminación de excretas y aguas residuales.

En el área rural o distritos 6,7 y 8 del Municipio los centros poblados y comunidades en su gran mayoría no existían sistemas de alcantarillado mucho menos un servicio establecido por la empresa ELAPAS; las comunidades nucleadas y centros poblados en crecimiento como forma de eliminar sus aguas servidas y excretas aplican las cámaras sépticas, pozos ciegos o a la calle, generando focos de contaminación. Y letrinas sanitarias en Quila Quila

En algunos casos el sistema de eliminación de excretas o aguas servidas, son conducidos por tuberías improvisadas que desembocan a las calles o quebradas circundantes al centro poblado respectivamente.

- Servicios de telecomunicación



Fuente: elaboración propia en base a datos INE 2012, CNPV 2012

Según la información del PTDI 2021-2025 del Municipio de Sucre, el porcentaje de hogares por disponibilidad de tecnologías de información y comunicación en la vivienda está en ascenso, el uso de la computadora y la cobertura de internet mostraron un crecimiento progresivo durante la gestión 2020, los indicadores de telecomunicaciones en cuanto a la conexiones a líneas telefónicas móviles fueron 512.018, las concesiones a internet alcanzaron a 488.152 las líneas telefónicas son 24.753.

En cuanto a las conexiones de internet se incrementó el número de conexiones en la última década, de 69.502 en el 2012 a 488.152 en la gestión 2020.

2.2.2. Infraestructura y equipamiento sanitario

- **Establecimientos de salud:**

TIPO DE INFRAESTRUCTURA	Nº
1er Nivel	82
2do Nivel	2
3er Nivel	5

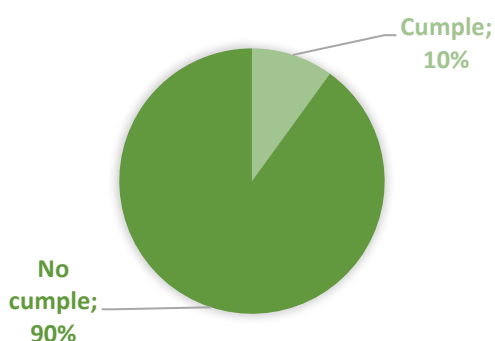
Fuente: Dirección Municipal de Salud del GAMS. 2020

De acuerdo al PTDI 2021-2025 el sistema de salud del municipio de Sucre, en toda la Red 1 está compuesta por 89 establecimientos distribuidos en 3 niveles donde 5 hospitales son de 3er nivel, 2 hospitales de 2do nivel y 82 centros de salud son de 1er nivel.

De acuerdo a UNFPA, en base a datos del SNIS a junio del 2023, el número de establecimientos de salud de la red en el Municipio de Sucre es de 127 en total: 103 de primer nivel, 10 de segundo nivel y 10 de tercer nivel.

- **Personal de salud**

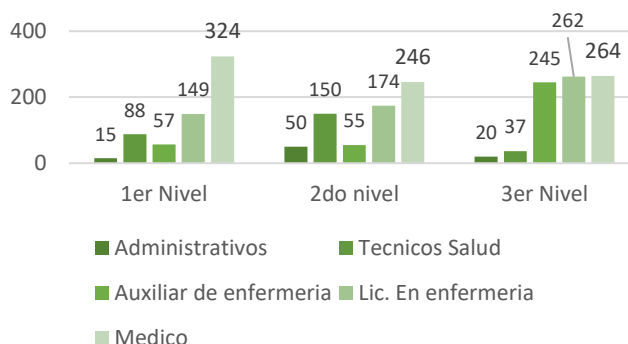
Infraestructura de centros de salud



Fuente: dirección municipal de salud del GAMS, 2020

De acuerdo a los datos del PTDI 2021-2025 del municipio de Sucre, el 90% de los establecimientos de salud del Municipio no cumple con la infraestructura necesaria según la normativa vigente. El 43% de los establecimientos de salud de primer nivel no cuentan con ambientes propios, debido a que los ambientes son alquilados.

Recursos humanos de salud por nivel



Fuente: DIMUSA-SEDES 2020

Los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel del municipio de Sucre, cuentan con un total de 2.136 recursos humanos considerando los planteles médicos, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería, técnicos en salud y administrativos. La relación entre recurso humano por habitante es de 0,0064. En resumen, el número de médicos por 1.000 habitantes en el municipio de Sucre, es de 2,5, enfermeras de 1,7 y auxiliares de enfermería 1,2. Siendo los recursos humanos del sector salud insuficientes para la población del municipio de Sucre, lo que ocasiona una demora en la atención, obteniendo una calificación regular por parte de la Defensoría del Pueblo. (2022)

2.2.3. Centros de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes – AIDAJ

Centros que brindan atención integral diferenciada a adolescentes y jóvenes en Bolivia

Descripción	Municipio	Total
Centros de salud acreditados	Beni	10
	Oruro	3
	Cobija	8
	Total	21
Centros de salud en proceso de acreditación	Beni	69
	Cochabamba (Cercado)	6
	Chuquisaca	22
	La Paz (El Alto)	36
	Oruro	128
	Total	261

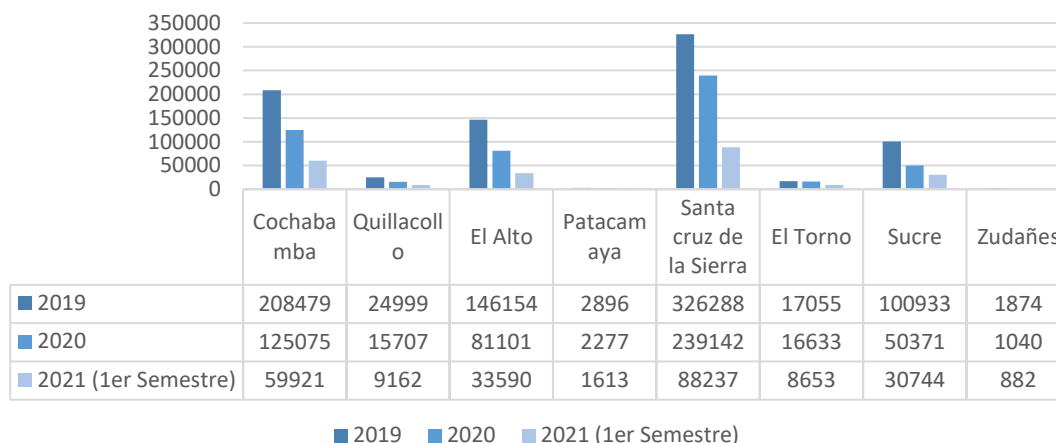
Fuente: Ministerio de Salud (responsable de adolescencia y juventud)

En relación a los Centros de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes – AIDAJ (Resolución Ministerial 1771, 2012), que son servicios de salud especializados para la atención de adolescentes y jóvenes, llama la atención de que al 2021 existan solo 21 centros certificados en Bolivia, de los cuales ninguno se encuentra en Chuquisaca, pero 22 están en proceso de acreditación en el departamento. (Barreras para acceder a servicios públicos que limitan el ejercicio de los derechos y derechos reproductivos de adolescentes en 8 municipios de Bolivia. 2021).

En 2022 se han certificado 2 Centros AIDAJ en Sucre: El Centro de Salud Poconas y el Centro de salud CIES.

A pesar de la limitada atención de salud diferenciada en Sucre, es importante destacar la importante cobertura de atención médica para adolescentes y jóvenes de las gestiones 2019 y 2020 y del primer semestre de la gestión 2021. Los reportes del Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), presentan la cobertura en la atención médica a adolescentes y jóvenes que en Sucre llegó a 1000.933 en 2019, de acuerdo a detalles del siguiente grafico:

SNIS-VE/2019-2021: Consultas medicas a adolescentes y jóvenes entre 14 y 19 años de edad por gestión y municipio



Fuente SNIS-VE / Ministerio de Salud

De acuerdo al estudio de Barreras para acceder a servicios públicos que limitan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de adolescentes en 8 municipios de Bolivia (2021), el Ministerio de Salud, busca fortalecer los centros de salud públicos en atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes, a fin de asegurar la calidad a través de los siguientes indicadores:

- ✓ La accesibilidad, es decir, consultas a bajo precio.
- ✓ La orientación y la información, pues toda o todo adolescente y joven que asiste a nuestras clínicas es informado y orientado de manera gratuita, con profesionales calificados.
- ✓ Confidencialidad, que promueve el cuidado de su identidad y el respeto al cumplimiento de sus decisiones autónomas.
- ✓ Personal altamente calificado y sensibilizado, capaz de entender y resolver las necesidades de las y los adolescentes y jóvenes; capaz de promover el respeto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los usuarios.

Sin embargo, el mencionado estudio describe que, según la percepción de adolescentes y jóvenes, las principales barreras de acceso a servicio de AIDAJ son las siguientes:

Barreras primarias:

- El personal de salud aún es adultocentrista, no está capacitado, a diferencia de los que trabajan en centros AIDAJ certificados que son comprometidos con los y las AJ.
- Los padres y madres de familia deben fortalecer la comunicación como base para la confianza y los nuevos aprendizajes, especialmente, en niñas y niños, para que crezcan más seguros. Desconocen qué es un centro de salud AIDAJ. Se trabaja con las juntas escolares. Muchos padres no están de acuerdo con tratar la SSySR, piensan que solo se habla de MAC, y que así se está motivando a los y las adolescentes a tener relaciones sexuales.

- En relación al personal de salud, se están realizando talleres de atención diferenciada para CS y hospitales. La primera etapa es la sensibilización al personal.
- Socioambientales: La confidencialidad limitada porque familiares que son personal de salud genera desconfianza de AJ a la hora de acudir a los centros de salud. El personal de salud aún es adultocentrista, con una visión paternalista. El origen del embarazo y el círculo de pobreza en el que entra el adolescente no se resuelven. No hay un trabajo coordinado entre sectores. Esta problemática ya se ha planteado en la mesa de trabajo del Ministerio de Justicia, es necesario que se trate de manera multisectorial, para hacer seguimiento a las políticas, y con las instancias relacionadas con factores sociales y económicos.

Barreras secundarias:

- Los centros AIDAJ requieren un lugar exclusivo y personal exclusivo. Hay mucha rotación de personal. -Todo el personal debe estar capacitado y sensibilizado
- Entre las barreras estructurales se advierte un desconocimiento de la normativa relacionada con la atención diferenciada. Existe, además, escasa coordinación intersectorial (salud, educación y justicia) en el trabajo con adolescentes y una falta de normativas gubernamentales que regulen el trabajo intersectorial con adolescentes

2.2.4. Salud integral madre niño

2.2.4.1. Cuidados prenatales

- **Natalidad, Mortalidad y Fecundidad**

Tasas de Natalidad, Mortalidad y Fecundidad en Sucre

Año	Esperanza de vida al nacer			Tasas bruta de natalidad X 1000	Tasa bruta de mortalidad X 1000	Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			
2020	74,66	71,32	77,96	21,27	6,48	2,47

Fuente: PTDI Sucre 2021 2025 en base a datos del INE

De acuerdo a datos del INE 2020, la tasa de natalidad del municipio de Sucre, tuvo un decrecimiento del 2,74; para la proyección de la gestión 2020 por cada 1.000 habitantes nacen 21.

Por otro lado, la tasa de la tasa de mortalidad es de 6,48 por cada 1.000 habitantes, donde la esperanza de vida en el municipio de Sucre, es de 75 y 65 años promedio; diferenciado por sexo, las mujeres tienen un promedio de esperanza de vida con 78 años y los Hombres con 71,32 años. La tasa global de fecundidad es de 2,74 hijos por mujer según las proyecciones del INE 2020, lo cual significa que en promedio las mujeres en el Municipio tienen entre 2 y 3 hijos en su vida.

- **Mortalidad materna**

La mortalidad materna es un grave problema de salud pública. Las complicaciones del embarazo y el parto son las causas principales de muerte entre mujeres en edad reproductiva.

De acuerdo a la Agenda 2030 del GAM Sucre, según la Organización Mundial de la Salud, la atención especializada durante el parto es un factor determinante de cara a reducir la mortalidad materna (OMS, 2019). En la ciudad de Sucre, la información obtenida mediante la Encuesta Municipal de Hogares de Sucre – EMHS 2019, muestra que el 78,3 % de los partos con asistencia en el municipio fueron atendidos por personal sanitario especializado; es decir, médico o especialista (71,9 %), enfermera o auxiliar de enfermería (4,1 %), promotor de salud o agente comunitario de salud (0,9 %) y partera o matrona (1,4 %). De acuerdo con la desagregación de este dato por zona, en el área urbana el 72,5 % de las mujeres fueron atendidas por un médico o especialista, frente a un 63,8 % del área rural.

En relación con el lugar de atención del parto, un 46,4 % de las mujeres del área urbana y un 37,3 % de las mujeres del área rural fueron atendidas en un hospital general. Los porcentajes se invierten cuando se trata de postas o centros de salud, pues el 22,2 % de las mujeres del área rural acudieron a este tipo de centros, frente a un 4 % de las mujeres del área urbana. En el caso de las clínicas u hospitales privados, un 3,7 % de los partos del área urbana fueron atendidos en estos centros, porcentaje que se reduce al 1,4 % en el área rural (Encuesta ODS 2019, PNUD. Proceso de datos: Real Data)

- **Mortalidad neonatal, post neonatal, infantil y en la niñez**

Los trastornos hipertensivos, hemorragias, infecciones y otras patologías provocaron 60 muertes durante el embarazo o en el trabajo de parto en Chuquisaca.

Mortalidad neonatal, post-neonatal, infantil, post-infantil y en la niñez

ÁREA Y DEPARTAMENTO	MORTALIDAD NEONATAL (MN)	MORTALIDAD POST-NEONATAL 1 (MPN)	MORTALIDAD INFANTIL (1q0)	MORTALIDAD POST-INFANTIL (4q1)	MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (5q0)
Urbana	20	16	36	7	43
Rural	36	31	67	22	87
Chuquisaca	19	3	22	9	31
BOLIVIA 2016	15	10	24	4	29

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Demografía y Salud 2016

De acuerdo al EDSA 2016, la mortalidad neonatal en Chuquisaca es de 19 superior en 4 puntos en relación al índice de Bolivia; la mortalidad infantil en Chuquisaca es de 22, ligeramente inferior al índice de Bolivia que alcanza a 24; y la mortalidad en niñez en Chuquisaca es de 31, superior al índice de Bolivia que es de 29.

Respecto a la muerte neonatal la principal causa es la prematuridad y la segunda causa es asfixia intrauterina y malformaciones congénitas” (responsable del Área Continua de la Vida).

En el municipio de Sucre, durante la gestión 2019 la tasa de mortalidad infantil fue de 18 muertes por cada mil nacidos vivos y la tasa de mortalidad en la niñez es de 22 muertes por cada mil

menores de 5 años las principales causas de mortalidad infantil figuran las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) y las infecciones respiratorias agudas (IRAs), subnutrición y por las complicaciones perinatales. (PTDI Sucre 2021-2025)

- **Lactancia materna**

De acuerdo a datos brindados por SEDES Chuquisaca en 2017, 67 madres de cada 100 dan de lactar a sus bebés hasta sus 6 meses de edad.



Fuente: ONG Realidades, en base a fuente SEDES Chuquisaca 2017

Entre las niñas y niños que lactaron, 64% empezó a lactar dentro de la primera hora de nacidos y esa proporción sube a 90% dentro del primer día.

Se observan diferencias importantes: el inicio temprano es menor en el área urbana (61%) que en el área rural (67 %), se reduce a medida que aumenta el nivel de educación de la madre y el quintil de riqueza del hogar.

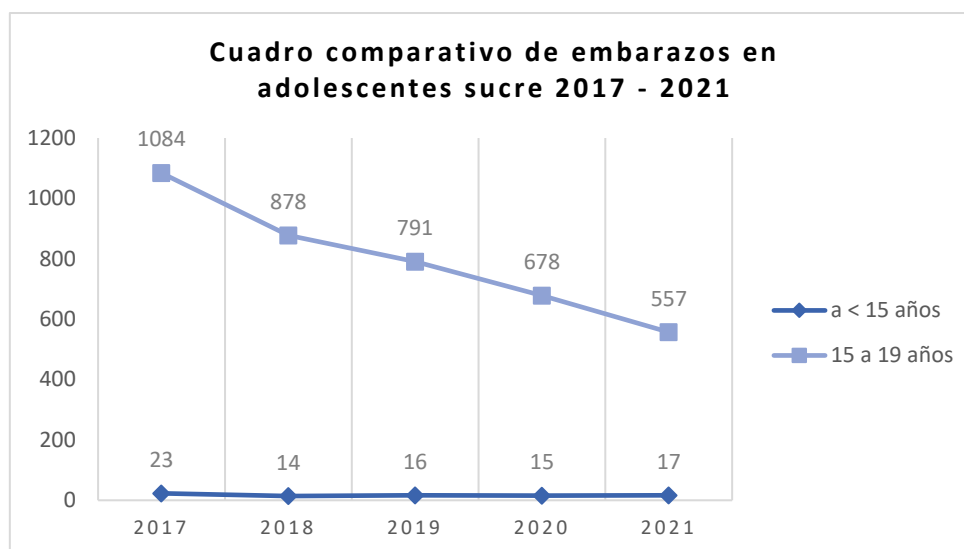
La cuarta parte de los niños y niñas (29%) recibieron algún alimento diferente de la leche materna durante los primeros tres días de nacidos/as antes de que la madre empezara a amamantar de manera regular. Este porcentaje es mayor en el área urbana (34%) que en la rural (22%); y presenta grandes variaciones por nivel de educación de la madre (18% en madres sin educación frente a 44% en madres con educación superior) y por quintil de riqueza (21% en el quintil más bajo en comparación con el 42% en el quintil más alto) (SEDES Chuquisaca 2017).

2.2.5. Salud integral en adolescentes

2.2.5.1. Salud sexual y reproductiva

- **Tasa de embarazos según grupo etario**

De acuerdo a los datos sistematizados en el Plan Municipal de prevención de embarazo en adolescentes, según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en 2020 hubo hasta cuatro embarazos por día, en adolescentes y jóvenes, entre 10 y 19 años de edad en Chuquisaca. En la mayor parte de los municipios del departamento subió la cantidad de embarazos, sin embargo, Sucre tiene las cifras más altas.



Fuente: UNFPA en base a Datos del INE. 2017 a 2021.

Los datos comparativos de embarazo en adolescentes en Sucre entre el 2017 al 2021, reflejan que se produjo una reducción progresiva de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en el Municipio de Sucre. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que se produjo una reducción importante entre el 2017 y el 2018, se ha vuelto a producir un ligero incremento progresivo de embarazos en menores de 15 años entre el 2018 y el 2021.

En datos absolutos, en relación a la gestión 2020 se observa un incremento al 2021 de 2 casos en embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Y una reducción de más de 100 casos, en relación a embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19, del 2020 al 2021.

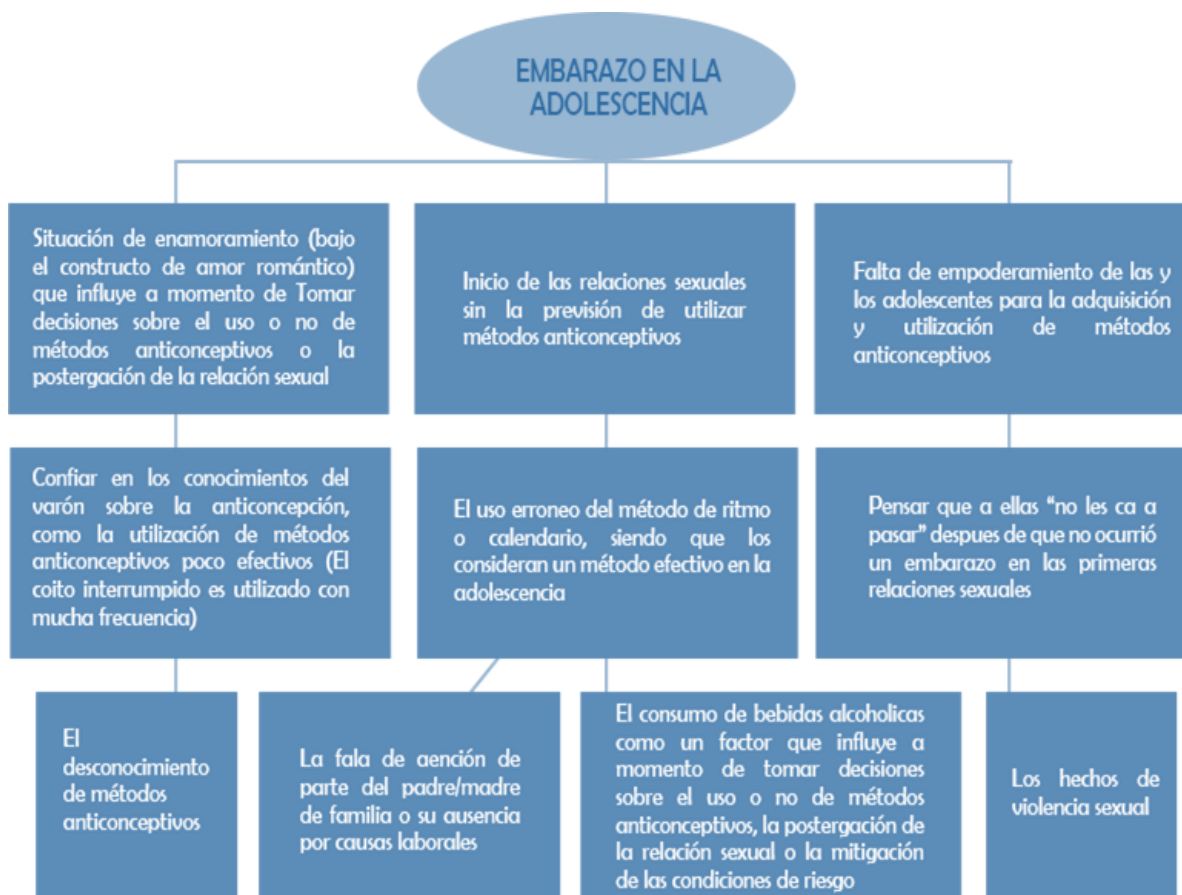
De los 574 embarazos en adolescentes que se registraron en 2021 en Sucre:

- 557 fueron embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años edad (97%).
- 17 embarazos fueron en niñas y adolescentes menores de 15 años en edad (3%).

El “Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia” (2016) realizado por el Fondo de Población de naciones Unidas UNFPA nos muestra una realidad desde la percepción de las adolescentes encuestadas, denotando importantes respuestas a ser tomadas en cuenta entre las que destacamos:

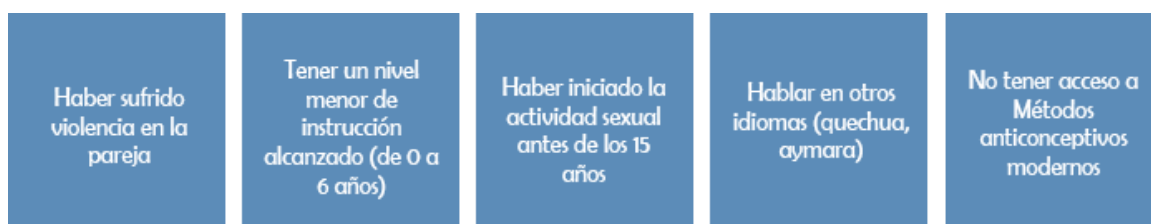
- La percepción sobre los factores que promueven el embarazo en la adolescencia es diversa y se explica desde aspectos culturales que tienen que ver con el “amor romántico” que es transmitido culturalmente mediante canciones o cuentos infantiles y sitúa a la adolescente mujer en una posición de dependencia afectiva y emocional que puede contribuir a aceptar tipos de violencia o la “prueba de amor” respondiendo a la presión de la pareja de tener relaciones sexuales a temprana edad, hasta la falta de conocimiento y uso inadecuado de los métodos anticonceptivos por falta de información o limitada comunicación con los padres y madres en temas de salud sexual y salud reproductiva, o incluso por situaciones ligadas al consumo de alcohol y drogas o a delitos de violencia sexual.

En el mencionado estudio se identifican los siguientes factores relacionados al embarazo en la adolescencia:



Fuente: Elaboración propia a partir de UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016.

En relación a estas percepciones es importante identificar que las mismas coinciden con los factores asociados a la variable de "alguna vez estuve embarazada" identificados por el "Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia" (2018) elaborado por el INE, que refiere los siguientes:



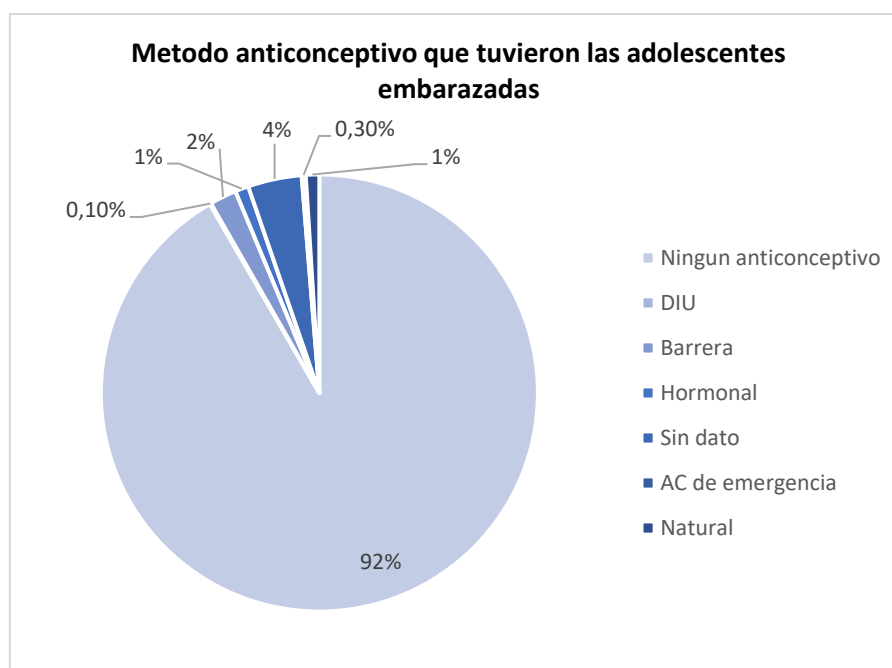


Fuente: UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016.

De acuerdo al EDSA 2016, aproximadamente la cuarta parte de las adolescentes de 15 a 19 años que no asiste a la escuela, da como motivo de esa inasistencia al hecho de que quedó embarazada.

Respecto a la **Planificación Familiar**, que es el derecho que tienen las personas a decidir libremente cuando y cuantos hijos tener y el Uso de Anticonceptivos, es importante resaltar que la mayor parte de los embarazos en adolescentes no son planificados, ya que solo el 2 de cada 10 adolescentes planificaron su embarazo (24%), y 5 de cada 10 adolescentes no planificaron su embarazo (54%). (UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016)

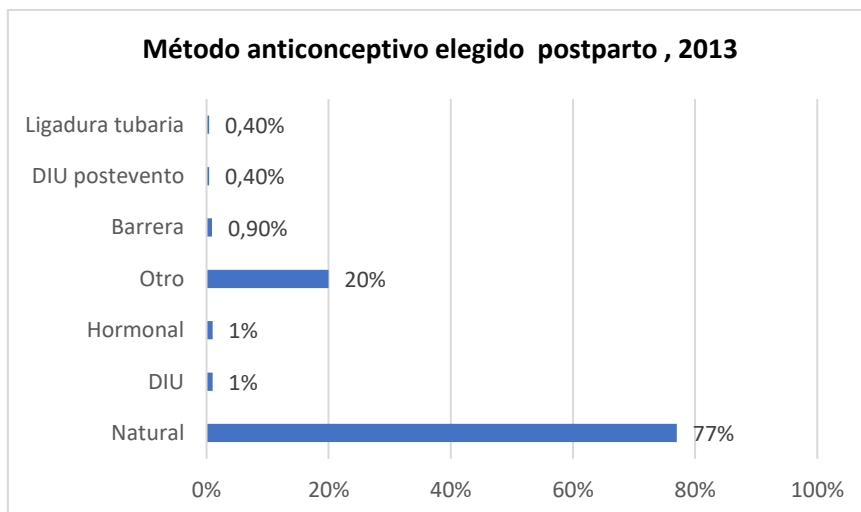
Por otro lado, se puede identificar que entre las adolescentes que no habían planificado su embarazo, 9 de cada 10 no usaba ningún tipo de método anticonceptivo, es decir el 92%; y solo el 5% usaba el método de barrera (condón) o métodos hormonales. (UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016.

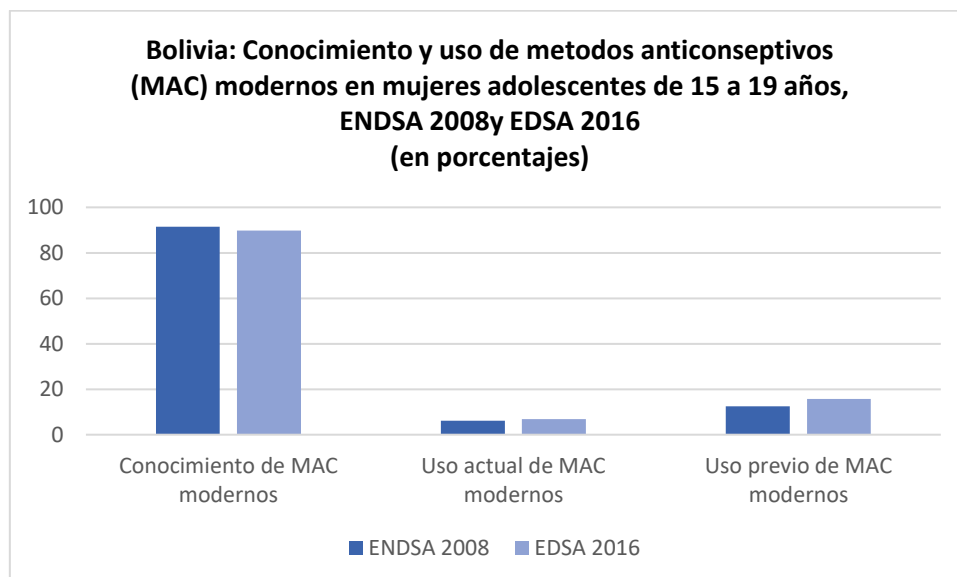
- Casi 8 de cada 10 adolescentes recibió orientación en métodos anticonceptivos después del parto, es decir el 79%; Y solo el 66% de ellas eligió usar un método anticonceptivo.

Pero el 77% eligieron el método natural (Ritmo, coitus interruptus o método de lactancia y amenorrea), y solo el 5% eligió algún método anticonceptivo moderno (DIU, Hormonal, Barrera y en menor proporción la ligadura tubaria)



Fuente: Elaboración propia a partir de UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016.

Estos datos se relacionan a los datos nacionales que reportan como a pesar de que las mujeres adolescentes de 15 a 19 años conocen los métodos anticonceptivos modernos, no los utilizan con frecuencia.



Fuente: Plan municipal de prevención de embarazo en adolescentes en base a datos del INE. Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia. 2018.

El Estudio el “Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia” (2018) elaborado por el INE, muestra que el 89,8% de las adolescentes de 15 a 19 años conocen los Métodos Anticonceptivos Modernos, pero solo el 6,8% usa los mismos y el 15,7% uso Métodos

Anticonceptivos Modernos alguna vez en el pasado. Estas cifras se incrementan cuando las variables se analizan en adolescentes de 15 a 19 años “alguna vez embarazadas”:

Bolivia: Porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas según característica seleccionada, ENDSA 2008 y EDSA 2016
(En porcentaje, número y puntos porcentuales)

Característica seleccionada	ENDSA 2008		EDSA 2016		Diferencia en puntos porcentuales 2016 - 2008
	%	Nº	%	Nº	
Usa actualmente MAC modernos	20,6	130	25,5	87	4,9
Uso alguna vez MAC modernos	41,2	260	58,3	200	17,1✓
Tiene acceso a MAC modernos	30,7	194	25,9	89	(4,8)
Conocen MAC modernos	91,7	579	89,7	307	(2,0)
Edad de inicio de actividad sexual antes de los 15 años.	30,6	193	26,2	90	(4,4)
Edad de inicio de actividad sexual a los 15 años o más.	68,8	435	73,8	252	5,0
Violencia de la pareja	40,6	256	32,3	111	(8,3)✓
Vive en hogar NO estructurado	7,1	45	6,7*	23	(0,4)
Ningún nivel de instrucción alcanzado o primaria.	51,2	323	16,3	56	(34,9)✓
Nivel de instrucción secundaria o superior.	48,8	308	83,7	286	34,9✓

Fuente: INE. Plan municipal de prevención de embarazo en adolescentes en base a datos del Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia. 2018. En base a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2016.

* Con coeficiente de variación superior al 20%, emplearlo solo de forma referencial.

✓ Corresponde a diferencias entre proporciones estadísticas significativas con un nivel de confianza de 95%.

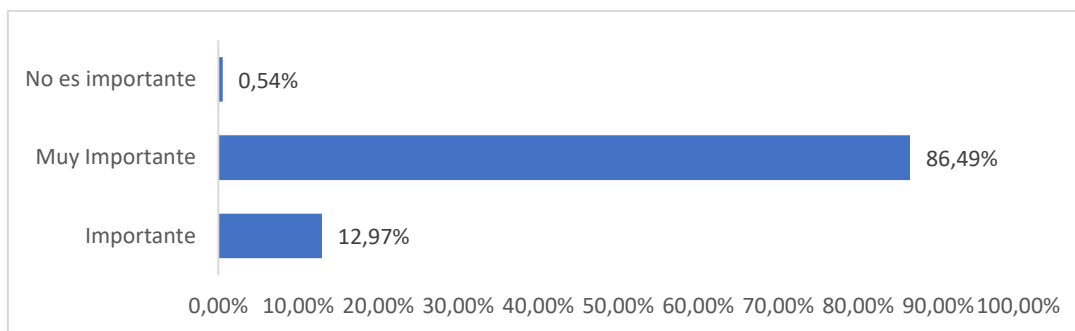
En relación a las adolescentes entre los 15 a 19 años “alguna vez embarazadas” se puede identificar que casi 9 de cada 10, es decir el 89,7%, conocen Métodos Anticonceptivos Modernos, y caso 6 de cada 10, es decir el 58,3% alguna vez uso los mismos, pero solo el 2 de cada 10, es decir el 25,5% los usa actualmente. Hecho que nos muestra a pesar de conocer los Métodos anticonceptivos Modernos los usan poco, pero el uso se incrementa en aproximadamente un 20% después de que se han embarazado alguna vez.

Finalmente, de acuerdo al EDSA 2016, 3 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas, fue víctima de violencia de pareja. En este sentido, queda claro que una de las principales causas del embarazo en adolescentes es la violencia sexual.

La violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes “es ejercida por una asimetría de poder, desde una posición de privilegio o dominación, utilizando la manipulación psicológica, el chantaje, el engaño, el uso de la fuerza, basada en un vínculo de dependencia afectiva, emocional y/o económica”² y es la segunda tipología de violencia que se produce con mayor frecuencia tanto en Bolivia como en Chuquisaca.

² Ministerio de Justicia y transparencia institucional de Bolivia. Protocolo de prevención, atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes.

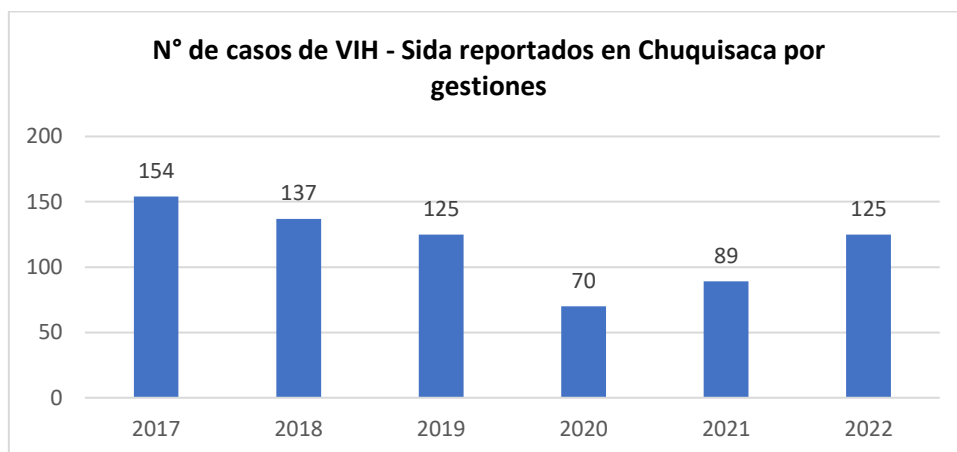
- **Importancia de la educación sexual integral para los jóvenes**



Fuente: Plan municipal de prevención de embarazo en adolescentes en base a datos del Dirección de Juventudes GAM Sucre. Relevamiento de información (2022)

En relación con el anterior gráfico, las y los jóvenes respondieron en un 86% que la educación integral sexual es muy importante, un 13% respondió que es importante, mientras que el 1% respondió que no tiene importancia.

- **Virus de inmunodeficiencia humana (vih/sida)**



Fuente: Elaboración propia en base a SEDES Chuquisaca

En Chuquisaca se registraron en los últimos 3 años un incremento de casos por VIH Sida, en la gestión 2020, por el confinamiento se registraron solo 70 casos, para el 2021, la cifra incremento medianamente y para noviembre del 2022 se registraron 125 casos, en el 2023 se identificaron 74 casos hasta el mes de julio y se proyectaron 140 a fin de gestión.

2.2.6. Discapacidad

Personas con discapacidad, según grado de discapacidad - 2021

Región	Moderada	Grave	Muy grave	Total, pcd's
Sucre	1456	1829	771	4056

Fuente PTDI Chuquisaca 2021-2025

En el Municipio de Sucre se identifican 4056 personas con discapacidad, el 36% tienen discapacidad Moderada, el 45% discapacidad Grave y el 19% discapacidad Muy Grave.

De acuerdo al PTDI 2021-2025 del departamento de Chuquisaca, la mayor parte de las personas con discapacidad son menores de 20 años, en general viven con sus padres y madres de familia y en viviendas familiares. Y solo el 5% vive en una institución. Razones por las que es importante plantear políticas públicas dirigidas no solo a la atención directa de las personas con discapacidad sino también dirigidas a la sensibilización, información y capacitación a sus familias, para que las mismas contribuyan a brindarles una atención integral e inclusiva.

El Servicio Departamental de Gestión Social, atiende a 47 niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada, que se encuentran albergados en centros de diferentes características:

- 18 niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada viven en Centros de Acogida de administración directa (Jesús de Nazareth, Sucre y Calor de Hogar) y delegada (Santa Clotilde, Virgen de la Hiedra, Tata Juan de Dios y Aldeas SOS). Acogidos de manera excepcional por la situación de orfandad y total abandono que los caracteriza. Es importante mencionar que estos centros no cuentan con equipos interdisciplinarios especializados para la atención a esta población.
- 29 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual moderada, grave, física-motora, mixta y múltiple, están acogidos en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, donde el equipo interdisciplinario realiza únicamente los informes biopsicosociales para remitir a los diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia.

En este sentido, se constituye en un reto para el departamento contar con un número mayor de plazas en el Psicopedagógico, donde también se debe reforzar la cantidad de especialistas para niñez y adolescencia, pero al mismo tiempo deben desarrollarse políticas de atención especializada a niñas, niños y adolescentes con discapacidad desde un enfoque inclusivo

2.3. DERECHO AL DESARROLLO

2.3.1. Cobertura educativa.

- Cobertura de estudiantes Inscritos en el Nivel Inicial de Educación

Cobertura de Estudiantes Inscritos en el Sistema Regular - Inicial

Región	2016		2017		2018		2019		2020	
	Inscritos	Docente	Inscrito	Docente	Inscrito	Docente	Inscrito	Docente	Inscrito	Docente
Sucre	11141	289	11208	306	11356	315	11594	325	11806	325
Chuquisaca	17988	473	17494	492	17414	507	17913	527	18112	527

Fuente: Dirección departamental de Educación de Chuquisaca 2020

Entre el 2016 y el 2020, se incrementó progresivamente la población de niñas y niños de 4 e 5 años de edad, que asisten a la escuela en la edad correspondiente, y docentes del Nivel Inicial y en Familia Comunitaria en el Municipio de Sucre.

La cantidad de docentes del nivel inicial se ha incrementado progresivamente entre la gestión 2016 y 2020, llegando a contar con 527 docentes tanto el 2019 como el 2020.

- **Cobertura de estudiantes inscritos en el nivel primario**

Cobertura de Estudiantes Inscritos en el Sistema Regular - Primaria

Región	2016		2017		2018		2019		2020	
	Inscritos	Docente	Inscrito	Docente	Inscrito	Docente	Inscrito	Docente	Inscrito	Docente
Sucre	37156	1742	38099	1707	38777	1706	38918	1707	39347	1710
Chuquisaca	77629	4920	76788	4800	75473	4769	73711	4729	72951	4727

Fuente: Dirección departamental de Educación de Chuquisaca

La población de 6 a 11 años de edad que asiste al nivel Primario de Educación en Chuquisaca, en la edad que corresponde, se ha incrementado en Sucre entre el 2016 y el 2020.

La cantidad de docentes del nivel de educación primario han reducido progresivamente entre el 2016 y el 2020, llegando a contar con 4727 profesores, es decir 193 menos profesores que el 2016.

- **Cobertura de estudiantes inscritos en el nivel secundario**

Cobertura de Estudiantes Inscritos en el Sistema Regular - Secundaria

Regiones	2016		2017		2018		2019		2020	
	Inscritos	Docentes	Inscritos	Docentes	Inscritos	Docentes	Inscritos	Docentes	Inscritos	Docentes
Sucre	34843	2038	34575	2128	35056	2085	35303	2115	35563	2121
Total	62248	3832	61242	3989	60264	4025	60500	4124	60543	4142

Fuente: Elaboración propia en base a información de Dirección departamental de Educación de Chuquisaca - 2020

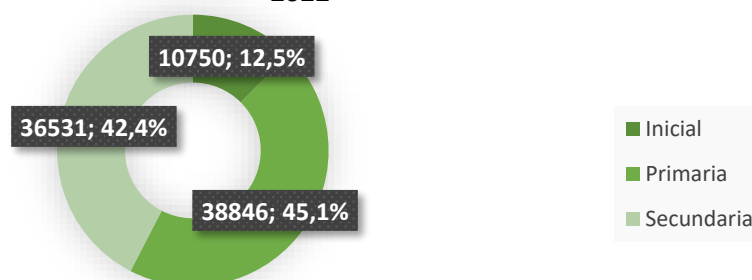
En el Nivel de Educación Secundario, entre la gestión 2016 y 2018 la cantidad de estudiantes de 12 a 17 años inscritos en el municipio de Sucre ha reducido en general, pero entre la gestión 2018 a la 2020 se ha incrementado progresivamente.

Es importante mencionar que la cantidad de profesores del nivel de educación secundario se han incrementado progresivamente entre el 2016 y el 2020, llegando a contar con 4142 docentes del nivel de educación secundaria en 2020, es decir 310 mas que en la gestión 2016.

Por otro lado, es importante mencionar que los datos de la gestión 2022, denotan que Chuquisaca que cuenta con 29 municipios, con 149.846 estudiantes matriculados (que se registraron en el libro de inscripciones de una Unidad Educativa en cualquier año de escolaridad y nivel del Subsistema de Educación Regular durante una gestión escolar dada).

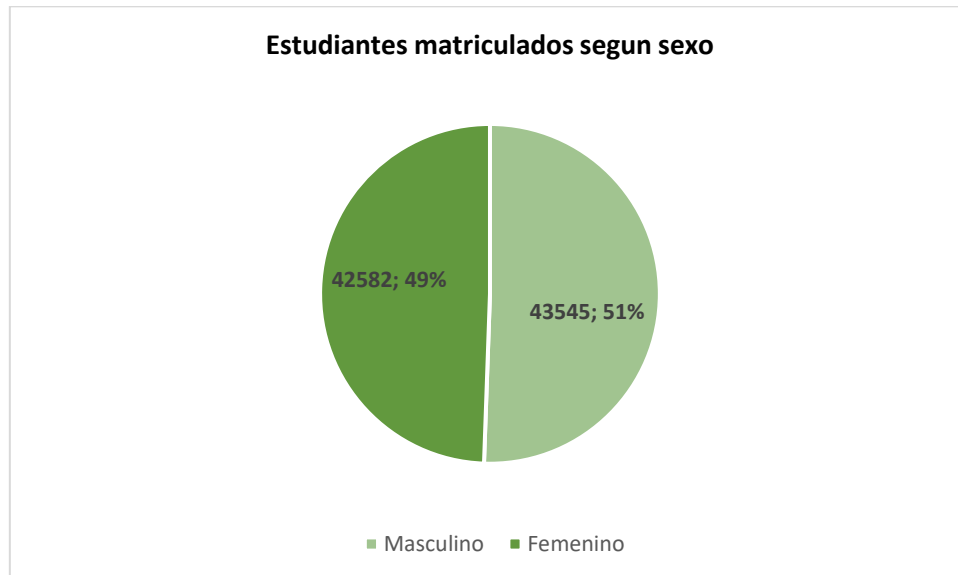
- **Matriculación**

Estudiantes matriculados segun nivel de estudio 2022



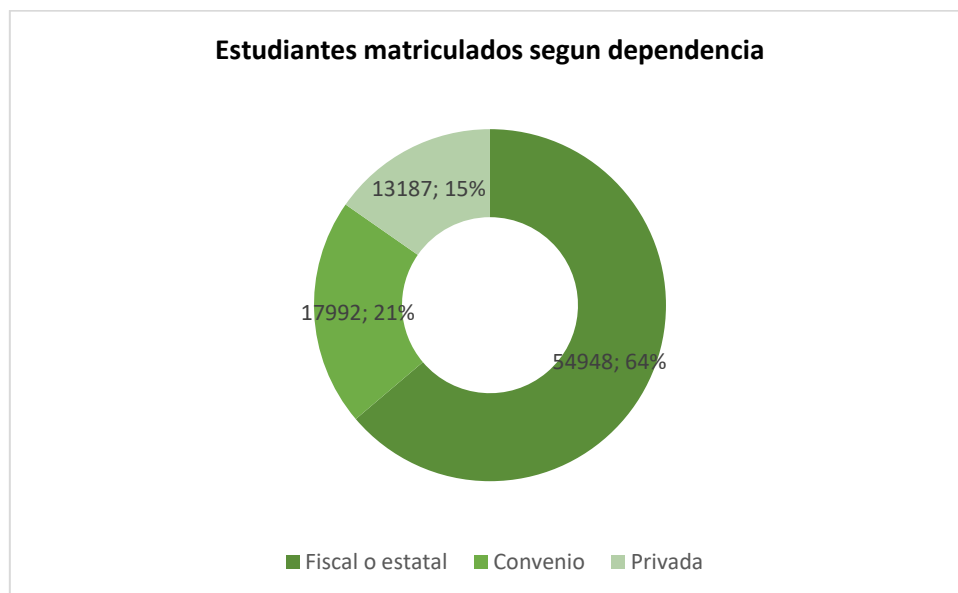
Fuente: Ministerio de Educación 2022

De los que el 57% de estudiantes matriculados se encuentran en el municipio de Sucre, 86.127 estudiantes. El 45.1% están matriculados en el nivel de primaria, seguido del 42.4% que está matriculado en el nivel secundario y finalmente el 12,5% estudiantes de Inicial.³



Fuente: Ministerio de Educación 2022

Podemos identificar que, de los estudiantes matriculados en el sistema educativo, el 49,4% son hombres y el 50,6% son mujeres.



Fuente: Ministerio de Educación 2022

³ [file:///C:/Users/hp/Downloads/CHUQUISACA%20EN%20CIFRAS%202021%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/CHUQUISACA%20EN%20CIFRAS%202021%20(1).pdf)

El 63,8% de los estudiantes matriculados están en colegio fiscal o estatal, el 20,9% asisten a colegios de convenio y finalmente el 15,3% de los estudiantes matriculados asisten a Unidades Educativas privadas.

2.3.2. Tasa de Abandono y promoción escolar

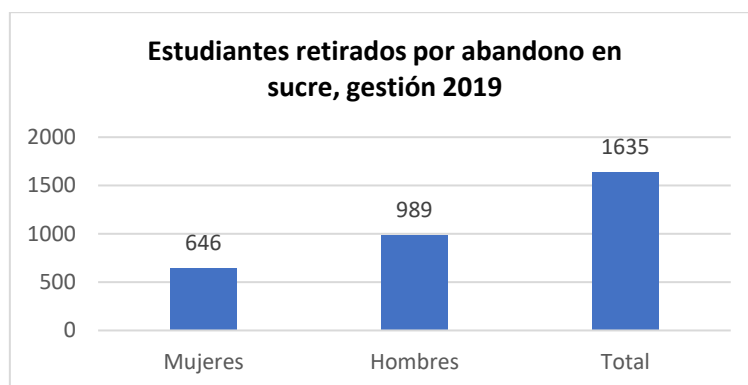
- **Estudiantes retirados por abandono por área geográfica**

Estudiantes retirados por abandono por área geográfica	
Area Geografia	SUCRE - Todos los distritos
Total	1.635
Urbana	1.410
Rural	225

Fuente: informe de la Rendición Pública de Cuentas de la Dirección Departamental de Educación 2019

Según el informe de la Rendición Pública de Cuentas de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, la tasa de abandono escolar Departamental en el nivel inicial fue del 2.48%, en primaria 1.58%, ésta última dentro del rango nacional que en 2017 llegó al 1.6%, y de nivel secundario, 4.41%, aún por encima de la media en el país (3.8%, en 2017). Tomando en cuenta los tres niveles, el promedio es de 2.8% para la gestión 2018.

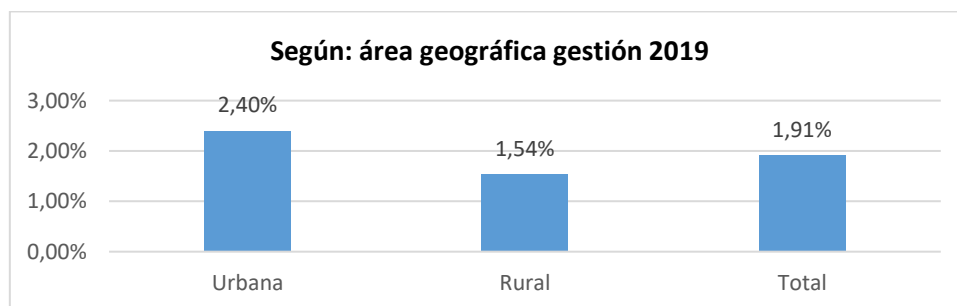
- **Tasa de abandono escolar**



Fuente: Ministerio de Educación 2019

En el municipio de Sucre, en 2019, un total de 1635 estudiantes se retiraron por abandono, representando el 43% de los retirados a nivel departamental, siendo el 86 % del área urbana y el 14% del área rural.

- **Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad según área geográfica**

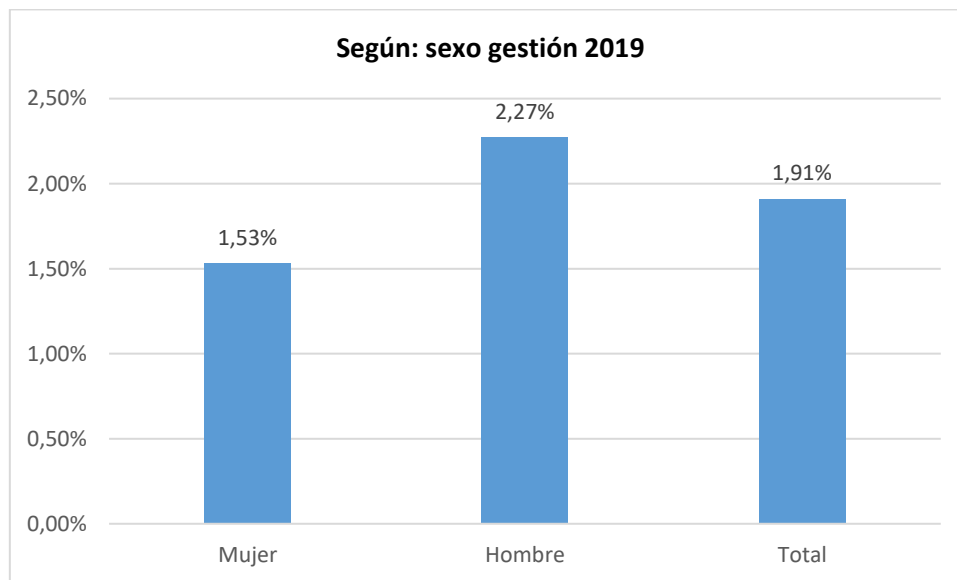


Fuente: Ministerio de Educación 2019

En relación a la tasa de abandono intra anual por año de escolaridad, en total se tiene una tasa total es de 1.91% de abandono intra anual por año del municipio de Sucre en 2019, porcentaje del que el 2.48% se produce en el área rural y 1.84% en el área urbana.

- **Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad según sexo**

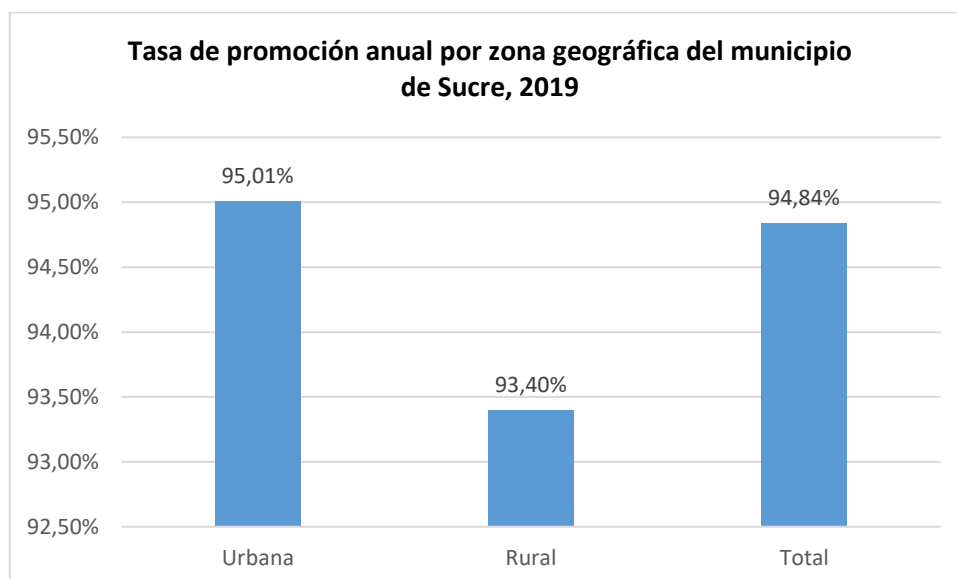
Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad según sexo



Fuente: Ministerio de Educación 2019

La tasa de abandono intra anual por año de escolaridad según sexo en el municipio de Sucre, muestra que el porcentaje en varones es mayor al alcanzar 2,27% y en el caso de las mujeres en MENOR, ES DECIR ALCANZA A 1.53%.

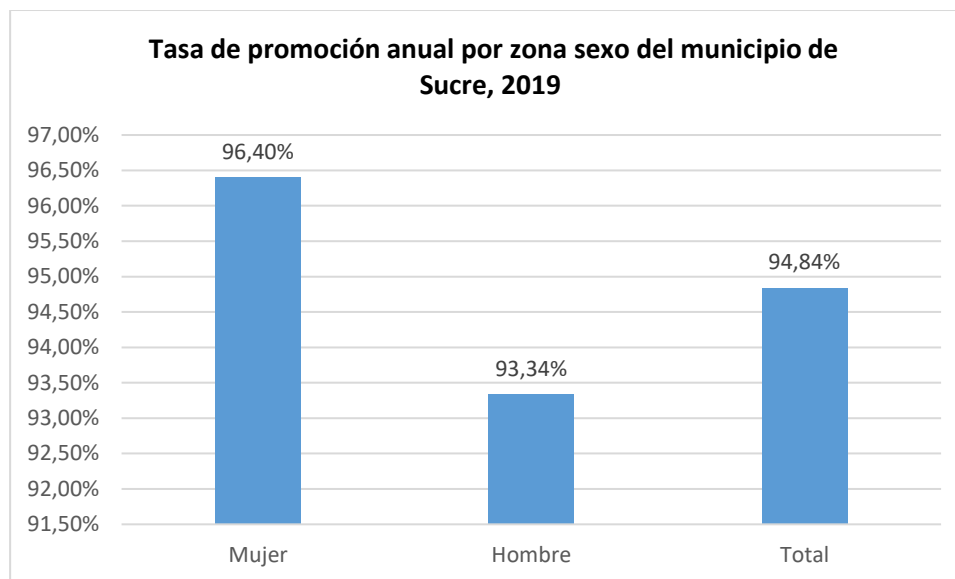
- **Tasa de promoción anual por zona geográfica**



Fuente: Ministerio de Educación 2019

Sobre la tasa de promoción anual por año de escolaridad según su área geográfica se identificó en 2019 (Último dato actualizado del Municipio de Sucre, brindado por el Ministerio de Educación en su página web oficial), que el 95,01% en área Urbana y 93,40% en área rural culminaron sus estudios y lograron promocionarse.

- **Tasa de promoción anual por sexo**



Fuente: Ministerio de Educación 2019

En relación a la tasa de promoción anual en el Municipio de Sucre el 96,40 de las mujeres lograron culminar y de igual manera el 93,4% de los varones.

- **Tasa de Terminación neta de sexto de primaria**

Tasa de Terminación neta de sexto de primaria 2016-2020						
N°	DISTRITOS EDUCATIVOS	2016	2017	2018	2019	2020
1	SUCRE	91%	89%	87%	91%	90%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Departamental de educación 2021

Un dato importante que destacar es que la tasa de terminación neta de sexto de primaria en Sucre es del 90% en 2020, y aunque se ha producido una leve reducción en relación al 2019, denota el progresivo incremento de terminación de educación en los últimos 4 años.

- **Tasa de Terminación neta de sexto de secundaria**

Tasa de Terminación neta de sexto de secundaria 2016-2020						
N°	DISTRITOS EDUCATIVOS	2016	2017	2018	2019	2020
1	SUCRE	69%	69%	68%	63%	62%

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Departamental de educación 2021

Llama la atención sin embargo que la tasa de terminación neta de sexto de secundaria sea del 62% al 2020, misma que se ha reducido progresivamente desde el 2016. Con una diferencia porcentual del 28% en relación a la tasa de terminación de sexto de primaria.

Lo que denota que a pesar de que en el ámbito educativo se han producido mejoras en cobertura y término de educación en el nivel primario, en el nivel secundario de educación, continúan existiendo importantes retos, que posiblemente tengan relación con otras situaciones de vulnerabilidad de derechos en la adolescencia, como el trabajo infantil y el embarazo en adolescentes.

2.3.3. Infraestructura y equipamiento educativo primaria y secundaria

El municipio de Sucre, cuenta con 228 Unidades Educativas, 133 son Unidades Educativas Fiscales, 51 son U.E. de Convenio y 44 U.E. son privadas, las cuales tienen distintas características de atención y cobertura de educación, donde el 69,30% se encuentran en el área urbana del Municipio y el 30,70% está situada en el área rural con 70 Unidades Educativas. Para la gestión 2020, se registró una población estudiantil de 87.029, teniendo una mayor población estudiantil de 64,11% en Unidades Educativas Fiscales.

Características de infraestructura y población escolar

Descripción	Unidades educativas	Población estudiantil			Área de estudio		BTH
		Mujeres	Hombres	Total	Urbano	Rural	
Privado	44	6421	6526	12947	44	-	3
Convenio	51	9453	8836	18289	24	27	12
Fiscal	133	28304	27489	55793	90	43	6

Fuente: Dirección Municipal de educación del GAMS, 2020

A nivel Municipal 21 Unidades Educativas cuentan con Bachillerato Técnico Humanístico, donde solo 3 U.E. privadas cuentan con el BTH, 12 U.E. de convenio y 6 U.E. Fiscales.

Estado de infraestructura y mobiliario de Unidades educativas		
BUENO	REGULAR	MALO
13%	76%	11%

En el Municipio de Sucre, de acuerdo a información del año 2021 de la Dirección departamental de educación de Chuquisaca respecto al estado de la infraestructura e inmobiliario de las unidades educativas, tenemos que:

- El 76% de las Unidades Educativas se encuentran en un estado Regular, es decir cuenta con ambientes satisfactorios, pupitres medianamente completos y otros, debiendo ser atendidas a corto plazo con la mejora de mobiliario y equipamiento educativo.
- El 11% se encuentran en estado malo, es decir cuenta con infraestructura deficitaria, existencia de goteras, humedad, Inmobiliario en mal estado, sillas y /o pupitres insuficientes y aulas deficientes. Debiendo ser atendidas de manera prioritaria, con la mejora tanto de infraestructura, como la ampliación del mobiliario y equipamiento educativo.
- Y solamente un 13% se encuentran en un estado Bueno, es decir que considera aulas y aprendizajes de espacios para el desarrollo de los ensayos y prácticas, espacios para el desarrollo del talento y del entrenamiento, del deporte y la cultura. Techos y paredes en buen estado, iluminación adecuada. Mobiliario en buen estado, calidad de pupitres, mesas sillas acorde a la cantidad de estudiantes.

2.3.4. Centros de educación especial

Cantidad de Centros de Educación Especial y Componentes de Atención

N.º	Distrito	Centro de educación especial	Componentes de atención				
			Visual	Auditivo	Intelectual	Dificultades de aprendizaje	Otro
1	Sucre	Aprecia	X				
2	Sucre	Audiología		X			
3	Sucre	Psicopedagógico			X	X	Talento extraordinario Múltiple
4	Sucre	Síndrome de down			X		
5	Sucre	San Juan de Dios			X	X	Múltiple
6	Yotala	Apostol Santiago		X	X	X	Múltiple
7	Azurduy	Pomabamba		X	X	X	Físico-motora
8	Mocojocoya	Tata Santiago		X	X		Físico-motora Múltiple
9	Padilla	Virgen del Rosario		X	X		
10	Sopachuy	San Pablo		X	X	X	
11	Monteagudo	Apiaguayki Tumpa	X	X	X	X	Múltiple
12	Camargo	Camargo	X	X	X	X	Múltiple
13	San Lucas	René Martínez Gómez	X		X		
14	Villa Serrano	Villa Serrano		X	X		Físico motora Múltiple
15	Villa Vaca Guzmán	Nueva Esperanza	X	X	X	X	
16	Macharetí	Macharetí	X	X	X	X	Físico motora Múltiple

Fuente Dirección departamental de educación de Chuquisaca

De los 16 Centros de Educación Especial con los que se cuenta en el departamento de Chuquisaca, 5 se encuentran en la ciudad de Sucre, que atienden a la población con discapacidad:

- Intelectual (3)
- Auditiva (1)
- Visual (1)
- Además de centros de atención a niñas, niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y Talento extraordinario (2).

2.3.5. Gabinetes de atención integral para Estudiantes GAIE

Los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes (GAIE) son un servicio seguro, confidencial, igualitario y gratuito para el apoyo pedagógico, desarrollo psicosocial integral, liderazgo y de orientación en Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y salud sexual y reproductiva, dirigidos principalmente a estudiantes del nivel secundario, a madres y padres de familia, tutoras/es, a miembros de la comunidad, y a maestras y maestros, que promueve el desarrollo integral de

las/os estudiantes y la comunidad educativa mediante acciones de prevención, atención y promoción.

Contribuyen a prevenir problemáticas sociales como embarazos adolescentes, violencia en los noviazgos, violencia sexual, alcoholismo y drogodependencia, entre otros. (Los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes – Proyecto Bambú GAIE. Una experiencia pionera. 2023).

De los 48 GAIES que actualmente funcionan en el departamento de Chuquisaca, 14 funcionan en el municipio de Sucre, impulsados por la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, con el apoyo de UNFPA, en convenio con la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, los GAIES cuentan con equipos de atención interdisciplinarios compuestos por estudiantes de último año de las carreras de psicología, trabajo social y pedagogía y por maestros dinamizadores. Varias entidades apoyan a los GAIEs como la Defensoría del Pueblo, ONG Realidades, UNFPA, CIES, Caritas - Pascas, entre otras.

Los GAIES en el municipio de Sucre están ubicados en las siguientes Unidades Educativas: Franz Tamayo, Hugo Poppe, Ovando, JRA, Serrano, Llinfi, Benjamin Guzman, Emilio Hochman, Villa Armonía, Tomas Katari, Victoria Diez, Evo Morales, Ruffo, Alberto Bohonquez.

2.4. DERECHO A LA PROTECCIÓN

2.4.1. NNA en actividad laboral

Aunque no se cuentan con datos oficiales actualizados y desagregados por municipios sobre trabajo infantil y adolescente, los datos que se tienen del INE y de la Encuesta de trabajo infantil, permiten identificar una importante cantidad de niñas, niños y adolescentes que trabajan, incluso por debajo de la edad legal permitida para trabajar, es decir los 14 años.

Características Ocupacionales de la Población Ocupada de 10 años o más de edad

	Situación en el empleo			Grupo ocupacional			
	Trabajado ra /or asalariado (%)	Trabajado ra /or por cuenta propia (%)	Otras categorías ocupacion ales (%)	Trabajado ra /or de los servicios y vendedor es (%)	Trabajador es agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros (%)	Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oficios (%)	Otros grupos ocupacion ales (%)
Bolivia	41,5	50,6	7,9	20,4	27,2	18,1	34,3
Chuquisaca	35,5	54,2	10,3	15,2	37,8	16,6	30,4
Sucre	50,3	41,9	7,8	24,3	7,1	23,8	44,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Censo 2012

De acuerdo al INE- Censo 2012 de la Población ocupada mayor de 10 años, en Sucre, el 50,3 % son trabajadores asalariados, el 41,9% son trabajadores por cuenta propia, el 24,3% trabajan en servicios o son vendedores, y el 23,8% son trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros.

- **Trabajo infantil y adolescente**

De acuerdo a la Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan 2016 (ENNA 2016), se registraron 739 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años (24,4%) que realizan alguna actividad laboral o trabajo; de los que el 54% son hombres y el 46% son mujeres; y el 52% son niñas, niños y adolescentes que tienen entre 5 a 13 años y el 48% son adolescentes de 15 a 17 años.

Y de acuerdo a la Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan 2019 (ENNA 2019) se registraron 724 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan una actividad laboral; de los que el 54% son hombres y el 46% son mujeres; y el 54% son niñas, niños y adolescentes que tienen entre 5 a 13 años y el 46% son adolescentes de 15 a 17 años.

Solo en la Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan 2016 se pueden identificar datos del departamento de Chuquisaca donde se registran 75.000 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) entre 5 y 17 años que realizan una actividad laboral o trabajo (43.000 entre los 5 a 13 años y 31.000 entre los 14 a 17 años):

- 26.000 en el marco familiar
- 38.000 ayudante de familia
- 3.000 aprendiz
- 7.000 por cuenta ajena
- por cuenta propia

No se cuentan con datos oficiales desagregados por municipios.

Departamento	Nº de NNA Trabajadores
Chuquisaca	26.753
La Paz	97.455
Cochabamba	68.944
Potosí	29.287
Oruro	13.068
Santa Cruz	105.634
Tarija	18.534
Beni	20.564
Pando	4.088
TOTAL	384.327

Fuente: ONG Realidades, en base a datos del INE - Censo de Población y Vivienda 2012

Ciudad	Nº de NNA Trabajadores
Sucre	9.943
La Paz	48.884
Cochabamba	37.166
Potosí	9.634
Oruro	7.095
Santa Cruz	77.543
Tarija	7.577
Trinidad	12.843
Cobija	1.455
TOTAL	212.140

Fuente: ONG Realidades, en base a datos del INE - Censo de Población y Vivienda 2012

Sin embargo, de acuerdo al Censo 2012 26.753 niñas, niños y adolescentes trabajaban en Chuquisaca, de los que 9.943 trabajaban en Sucre.

Aunque no se pueden realizar análisis comparativos entre los datos de las Encuestas de trabajo infantil y el Censo de población y vivienda, porque son dos estadísticas elaboradas con diferente metodología, podemos considerar que el trabajo infantil se ha incrementado progresivamente, situación que se produce aun con mayor frecuencia desde la pandemia por COVID 19.

Rango de edad	Total, de niñas, niños y adolescentes		Sexo			
	Cantidad	%	Niñas	%	Niños	%
9 – 11	63	50,4	24	19,2	39	31,2
12 – 13	40	32	15	12	25	20
14 – 17	22	17,6	10	8	12	9,6
TOTAL	125	100	49	39,2	76	60,8

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través del programa de protección social para niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo, identificó en la gestión 2023 a 125 niñas, niños y adolescentes en situación laboral, de los que el 50,4% son niñas y niños de 9 a 11 años de edad, 32% son niñas y niños de 12 a 13 años y el 17,6% son adolescentes de 14 a 17 años de edad. Respecto al género, un 39,2% son mujeres y 60,8% son hombres.

En 2021 el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre realizó el Diagnóstico integral de niñas, niños y adolescentes en el espacio público de la ciudad de Sucre – Chuquisaca en el marco de la protección de la niñez y adolescencia, con el apoyo de Maya Paya Quimsa en coordinación con ONG Realidades, a continuación, se resaltan algunos de los principales hallazgos:

Lugar donde viven	
Villa Marlecita	10%
Barrio Alegría	14%
K'ora k'ora/ Barrio Juez Baltazar	1%
Zona La Jastambo	39%
Llinfi	4%
Barrio 21 de octubre	1%
Barrio Jordan	4%
Ex aeropuerto	3%
Uraypampa	1%
Barrio Chayanta	3%
Pampa Sorolla Santa Catalina	1%
Barrio Azari.	1%
Parada final del A Zona Barrio Cessa	1%
Villa Margarita	1%
Zona Molle Molle Av. Evo Morales	4%
Villa Armonia	1%
Barrio San Miguel	1%
Avenida Huata/ Calle Canelas	1%
Zona Mesa Verde	4%
El Tejar	1%
Barrio América	3%
	100%

Llama la atención, que el 100% de NNATS encuestados viven en área periurbana o rural del municipio de Sucre, sin embargo, un porcentaje significativo de ellos realizan sus trabajos en zonas céntricas de la ciudad, lo que significa que esta población pasa por un largo trayecto para movilizarse de su casa a su actividad laboral luego retornar al lugar donde reside.

Las zonas del Municipio de Sucre donde viven la mayoría de NNATS son: La Jastambo con un 39%, Barrio Alegría con 14% y Villa Marlecita con 10%. Que son barrios ubicados en distritos Periurbanos y Rurales, caracterizados por el limitado acceso a calles asfaltadas, en algunos casos con poca iluminación pública, y con limitado acceso a servicios básicos.

Por otro lado, se identificaron en total a 27 Unidades educativas a las que asisten las NNATS: 25% de asisten a la Unidad Educativa Angel Baspineiro, el 16% a la Unidad Educativa Tacopampa, 6% a la Unidad Educativa Tomás Katari, 5% Marcel Quiroga Santa Cruz, 4% Victoria Diez, 4% del Colegio Alegría, 4% a Roberto Alvarado.

Así mismo se identificó asistencia, pero en menor porcentaje a las unidades Educativas: Emili Hoshman B, Gastón Villar, Jorge Revilla Aldana, Josefa María Mujica y villa armonía con el 3% cada una. Así también las unidades educativas: Aniceto Arce, Escuela Villa Marlecita, Fe y Alegría, Franz Tamayo, José Ignacio de Sanjinez, Josefina Goitia, K'ora k'ora, Kulusa llawi, Libertad de las Americas, San José, Sinai, Tucsupaya y el Psicopedagógico, con 1% en cada una de ellas.

Respecto a los trabajos que realizaron antes el 29% afirma que no trabajaba y el 71% identifica diferentes actividades de acuerdo al siguiente detalle:

El 42% realizaban actividades laborales por cuenta propia o de manera independiente, de los que el 29% vendía variedad de productos, como caramelos, gelatinas, etc., el 13% trabajaban limpiando micros o lavando autos, en menor porcentaje.

Por otro lado, el 18% realizaban trabajos por cuenta ajena o de manera dependiente, de acuerdo al siguiente detalle: 6% trabajaba en algún taller, ya sea de carpintería o mecánica; el 5% como ayudante de cocina; el 4% como ayudante de construcción y finalmente en menor cantidad los trabajos de limpieza (Trabajadora del hogar), niñera y cuidado de animales, cada una de las ultimas al 1%. Además, el 10% realizaba actividades de mendicidad combinadas con actividades de alto riesgo como artista callejero como músico o malabarista y de limpia para brizas.

Tomando los datos descritos, y los obtenidos durante el periodo de Observación No Participante se lograron registrar las siguientes **actividades laborales por cuenta propia o de manera independiente** que realizan las **Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Trabajo**:

- Venta de dulces, frutas, verduras, mandiles, gelatina, dulces, barbijos, tortas, cosas de cocina, refrescos, eucalipto, habitas secas, caña de azúcar y pipocas.
- Escaleritas y resadores en el Cementerio General
- Guías turísticos en el Cementerio General
- Lava autos
- Lava micros
- Lustra botas
- Limpia vidrios.

La mayoría de estos oficios realizados en las zonas comerciales de la ciudad donde se encuentra mercados, tiendas, puestos de comida y comercio de productos variados.

También se lograron observar y conocer a través de manifestaciones de adolescentes de actividades laborales por cuenta ajena o de manera dependiente que realizan las **Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Trabajo**:

- Ayudantes de Mecánicas
- Ayudantes de Carpintería
- Ayudantes de cocina
- Meseras
- Niñeras
- Trabajadoras del Hogar
- Ayudantes de comercio
- Cuidado de animales

Además, también se identificaron **actividades de mendicidad que realizan Niñas, Niños y Adolescentes**, realizando de manera itinerante ciertas actividades de mayor riesgo o catalogadas por como delito o trabajo prohibido:

- Dibujos de tiza en aceras
- Cantantes
- Malabaristas
- Limpia parabrizas
- Pedir dinero de manera directa en restaurantes

Frente a esta situación, y respondiendo a las demandas de la Federación de niñas, niños y adolescentes trabajadores – FEDNAYJATS el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre desde el 2015 cuenta con el Programa de protección social para niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo (antes Programa de almuerzo educativo saludable) que brinda una atención integral a las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo brindándoles alimentación nutritiva, apoyo extraescolar, seguimiento social y orientación familiar contribuyendo a que los menores de 14 años dejen de trabajar.

2.4.2. Prevención ante la vulneración de derechos

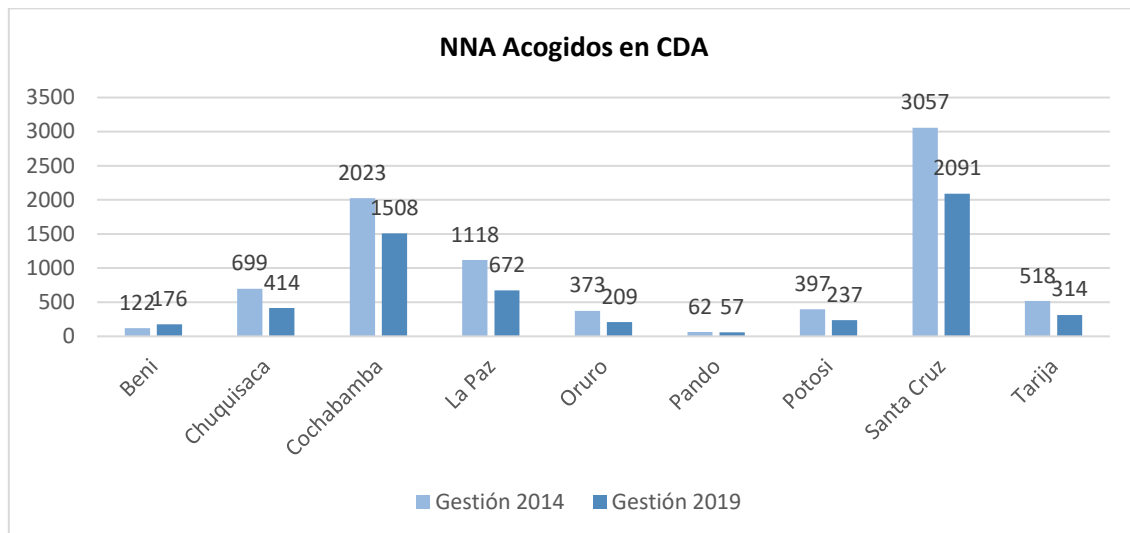
- **Composición familiar**

De acuerdo al Código Niña, Niño y Adolescente, Ley N° 548, se reconoce ella familia como medio natural para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. La derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez.

- **Niños, niñas y adolescentes en centros de acogida**

De acuerdo a UNICEF y el Ministerio de Justicia, en 2021, 5.678 niñas, niños y adolescentes estaban en 180 centros de acogida públicos, privados y de delegación mixta en el país, de los cuales 5.479 estaban acogidos por más de 29 días.



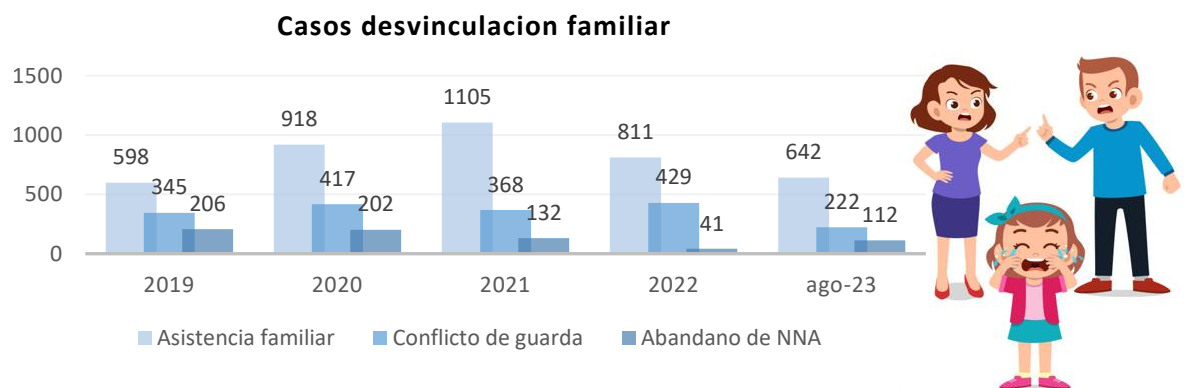
FUENTE: Estudio sobre el estado de situación de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional 2021 (UNICEF y Ministerio de Justicia y transparencia institucional)

De acuerdo al mencionado informe 1 de cada 715 NNA se encuentran privados de cuidados parentales en Bolivia, siendo Chuquisaca el departamento que ocupa el 4to. lugar respecto a los departamentos que mayor cantidad de NNA en 14 centros de acogida (solo 7 cuentan con acreditación), de los que 10 se encuentran en Sucre.

Centros de Acogida (sin visita parental)	2019	INA
Sucre	10	327
Yotala	3	61
Camargo	1	29
TOTAL	14	414

FUENTE: Estudio sobre el estado de situación de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional de (UNICEF y Ministerio de Justicia y transparencia institucional)

327 infantes, niñas, niños y adolescentes se encuentran en los 7 centros de acogida en el municipio de Sucre.



De acuerdo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en la gestión 2021 se tuvo la cifra más alta en atención a casos de asistencia familiar, con 1005 casos. A diferencia de los 598 casos del 2019 y 918 casos del 2020, en la gestión 2022 los casos redujeron significativamente a 811, y continuaron reduciendo para agosto de 2023 donde se atendieron 642 casos.

Así mismo se puede observar que en relación a la atención de casos relacionados a conflicto de guarda el 2019 se atendieron 345 casos, en 2020 se produjo un incremento a 417 casos, en 2021 se redujo a 368, en 2022 vuelve a incrementar a 429 casos. De enero a agosto de 2023 se han atendido 222 casos de conflicto de guarda.

Un dato sin duda relevante es la frecuencia de abandono de las niñas, niños y adolescentes, que ha disminuido progresivamente hasta el 2022; sin embargo, hasta agosto de 2023 los casos de abandono a niñas, niños y adolescentes se incrementaron en Sucre en más del 50% en relación al 2022.

Frente a esta situación el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre cuenta con un Hogar transitorio que acoge circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con el objeto de buscar a su familia de origen o ampliada y restituir sus derechos, y de acuerdo al caso reintegrarlo a su familia, a una modalidad alternativa, o en última instancia y por orden judicial realizar el acogimiento en un centro de acogimiento dependiente del SEDEGES. Por otro lado cuenta con el programa de familia.

El informe defensorial “Límites al ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento: Visitas y reintegración familiar” de la Defensoría del Pueblo (2023) describe que las entidades de protección municipales no cuentan con un sistema de monitoreo que permita reportar información general e individualizada de la situación de NNA en acogimiento y de las intervenciones programáticas a fin de garantizar sus derechos, y en particular su derecho a vivir en familia; que debería ser reportada al SINNA desde el MODEFA, que aún no está en funcionamiento.

Además describe que del total de la población de NNA en situación de acogimiento a nivel nacional, el 63% cuenta con referente familiar, de este dato el 40% recibe visitas y únicamente el 12% se encontraría en procesos de reintegración familiar, lo que denota que no se desarrollan intervenciones eficientes de fortalecimiento familiar, que promuevan las visitas y reintegración familiar, lo que limita el ejercicio del derecho a vivir en familia y tiene como consecuencia la estadía prolongada o definitiva de esta población en los Centros de Acogida.

El mencionado informe refiere también que desde las DNAs se presentan dificultades para ubicar a la familia, así mismo, no brindan información y colaboración al entorno familiar y en su mayoría no realizan el **seguimiento para conocer la situación con relación a visitas** de las NNA en acogimiento institucional, de igual forma, no tienen **registros de promoción de visitas**, desarrollan informes limitativos para posibilitar el retorno al entorno familiar, no realizan seguimiento a los casos y existe poca coordinación interinstitucional a los fines de reintegración familiar, esta situación, origina que las NNA permanezcan en los Centros de Acogida en un tiempo prolongado.

Así mismo, el informe identifica que uno de los aspectos que afecta de manera transversal es el cambio, destitución, reducción de personal y la falta de especialización de las y los operadores, incidiendo en la institucionalización prolongada de las NNA en los Centros de acogida y limitando el retorno a su ámbito familiar; otro aspecto a destacar es que si bien se han creado espacios de trabajo interinstitucional para restituir el derecho a vivir en familia estos no funcionan en todos los departamentos, y aún existen retos para que las determinaciones asumirse sean vinculantes a las entidades participantes.

En la dimensión programática, se advirtió que el Estado en todos sus niveles no cuenta con políticas, planes y programas de fortalecimiento familiar, siendo esta omisión una limitante para el ejercicio del derecho a vivir en familia de esta población, toda vez que no se cuenta con lineamientos estratégicos que permitan prevenir el abandono y promover y acompañar la protección y cuidado respetuoso para el desarrollo integral de NNA en su entorno familiar.

En este marco, la Defensoría del Pueblo recomienda a los gobiernos autonomos municipales capitales de departamento, entre ellos el Municipio de Sucre:

- Desarrollar e implementar **políticas, planes y programas a nivel municipal de “Fortalecimiento Familiar”**, que contengan entre otros aspectos, medidas para el fortalecimiento de vínculos familiares, medidas que propicien las visitas y los procesos de reintegración familiar en el caso de las niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento.
- Establecer **rutras de visitas y reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento**, bajo el principio de celeridad, para garantizar el derecho a vivir en familia. Realizar acciones de seguimiento y coordinación interinstitucional para involucrarse en el proceso de visita y reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento.
- Desarrollar y/o **implementar un sistema que permita tener un registro de información fidedigna, integral y actualizada de los casos de las niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento** (cantidad, visitas y reintegración familiar, entre otros) que contemple datos del **seguimiento individualizado** por departamento.

- **Actividades de prevención**

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre cuenta con un programa de prevención, denominado **Servicio de capacitación y educación en prevención en consumo de drogas y lucha contra la violencia**, que desarrolla su trabajo de prevención con enfoque de derechos, obligaciones y enfoque de bienestar con amor, atención y educación en la diversidad, por un mundo sin violencia.

Con el **objetivo** de “Brindar habilidades para la vida que permitan el análisis crítico – reflexivo sobre el consumo de Alcohol y el ejercicio de todo tipo de violencia, fortaleciendo las habilidades para el control de las emociones y sentimientos, potenciando la formación de habilidades personales-sociales que permitan a los adolescentes, enfrentar de manera efectiva las problemáticas de su entorno”, se desarrolla diferentes programas de prevención abordando los siguientes temas:

- Identificación de riesgos, amenazas relacionadas al consumo de alcohol y ejercicio de la violencia y fortalecimiento de los factores de protección.
- Descripción de la comunicación efectiva y toma de decisiones
- Identificación y comprensión de las habilidades para el control de las emociones y los sentimientos

El servicio de prevención del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre realiza sus actividades coordinando acciones interinstitucionales con otras unidades y servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Unidad de Familia, los CIDIM, y con entidades externas como CEPAT del SEDEGES, la Dirección Distrital y Departamental de Educación, y otros organismos internacionales de derechos, entidades de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizaciones no gubernamentales como Save The Children, ONG Realidades, Simparispa, IPTK, Plan International, Sayari Warmi, la Cooperación Suiza entre otros. Sin embargo, no se cuenta con un programa de prevención interinstitucional e Intergubernativo.

2.4.3. Protección integral

2.4.3.1. Casos de violencia atendidos

- **Casos denunciados a la fiscalía**

En Bolivia la violencia es un fenómeno que se incrementa año a año, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, en relación a los delitos de violencia en razón de género en el marco de la ley 348, que se incrementan cada año, toda vez que en 2020 se reportaron 38.089 casos de violencia y en 2021 se registraron 45.174 y en 2022 se reportaron 51.426 hechos de violencia hacia la mujer.

Delitos de violencia en razón de género en el marco de la Ley 348 en Chuquisaca 2018-2022

Año	2018	2019	2020	2021	2022
Chuquisaca	1.827	1.844	1.731	2.465	2.540
Violencia familiar o domestica	1.451	1.380	1.324	1.907	1.854

Fuente: Fiscalía General del Estado de Bolivia

Al igual que en Bolivia, en el departamento de Chuquisaca, se reporta un incremento anual de violencia pasando de 1.731 casos denunciados en 2020 a 2.465 casos de violencia denunciados en 2021 y 2.540 hechos de violencia en 2022, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado. De los que 1324 en 2020, 1.907 en el año 2021 y 1.854 en el año 2022 fueron casos de violencia familiar o doméstica que afectan directamente a las niñas, niños y adolescentes.

Tipología de violencia sexual contra la mujer en Bolivia 2018-2022

Delitos	2018	2019	2020	2021	2022
Violación	138	152	121	167	207
Estupro (Art. 309)	52	77	86	73	103
Violación infante niña, niño y adolescente (Art. 308 bis)	66	94	107	154	174
Abuso Sexual (Art. 312)	70	87	86	109	155

Fuente: Fiscalía General del Estado de Bolivia

La segunda tipología que se produce con mayor frecuencia en Chuquisaca, de acuerdo a los datos oficiales es la violencia sexual expresada en diferentes formas, que afecta principalmente a las mujeres y a las niñas, y de acuerdo a UNICEF se produce en el 80% en el ámbito familiar (2020).

De acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, se identifican 4 tipos de violencia sexual que se producen con mayor frecuencia:

- 310 casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años (207 son delitos de violación a niña, niño y adolescente, 103 son delitos de Estupro)
- 174 casos de violación a mujer.
- 155 casos de otras formas de violencia Sexual

Numero de Infanticidios por año 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Bolivia	78	66	51	42	38
Chuquisaca	6	6	1	7	1

Fuente Fiscalía general del Estado de Bolivia

Otra de las expresiones más extremas de la violencia es el infanticidio, que en Bolivia se produce generalmente en el seno de las familias. En Chuquisaca los hechos de infanticidio se han incrementado abruptamente entre el 2018, 2019 y el 2021, aunque el 2020 se tuvo 1 caso al igual que el 2022.

Numero de Feminicidios por año 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Bolivia	130	117	113	107	94
Chuquisaca	6	2	5	6	2

Fuente Fiscalía general del Estado de Bolivia

Bolivia es el tercer país en América Latina y el Caribe con las tasas más altas de feminicidio, comprendido como la muerte violenta de las mujeres por razones de género. En Chuquisaca el 2020 y 2021 se han incrementado los feminicidios en un numero de 5 y 6 respectivamente, y el 2022 se han reducido a 2.

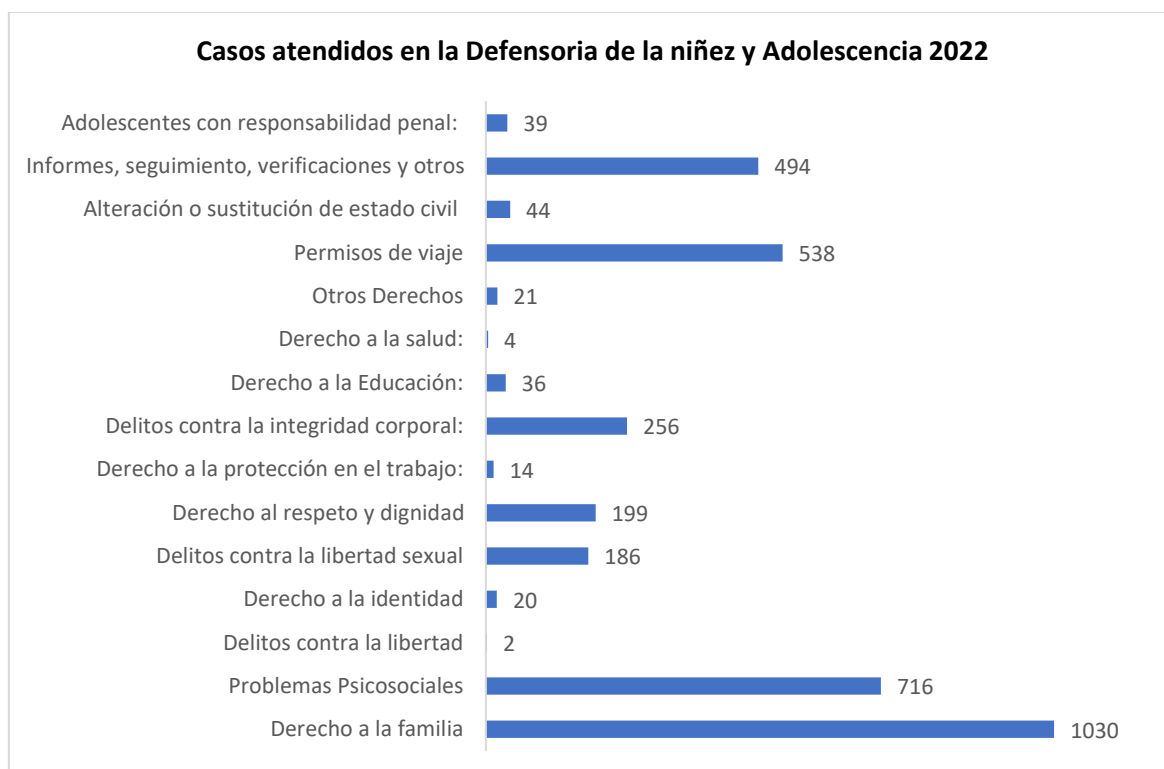
Esta extrema violencia deja además a niñas, niños y adolescentes huérfanos que se constituyen en victimas invisibles.

- **Casos denunciados a defensorías de la niñez y adolescencia**



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación de Defensoría de niñez y adolescencia de Sucre.

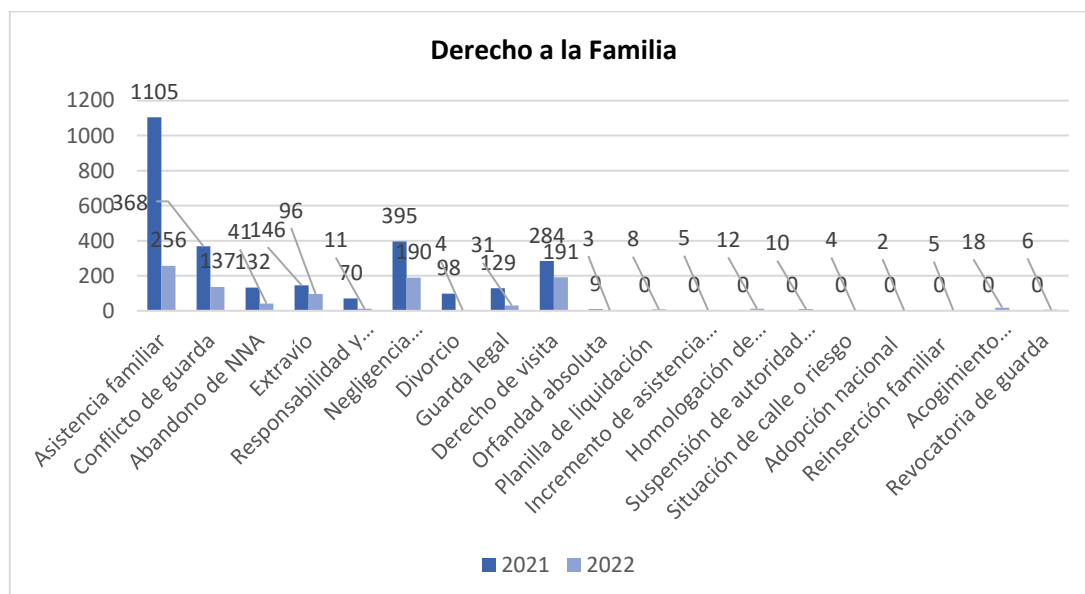
De acuerdo a datos de la Coordinadora de Defensorías dependiente de la Dirección de Gestión Social de la Gobernación Departamental de Chuquisaca, en Sucre la cantidad de denuncias atendidas por las diferentes DNA en todos los distritos del municipio, durante los últimos 5 años, refleja que se atendieron una mayor cantidad de casos el año 2019, llegando a 11788 casos, reduciéndose la atención bruscamente durante la gestión 2020 a 5016 casos y el 2021 a 7332 casos, probablemente por la pandemia por COVID 19, durante la cual se redujo el acceso a servicios de protección en general, por las medidas de confinamiento. Sin embargo, el 2022 la cantidad de casos atendidos volvió a subir llegando a 10034 casos, en un número similar al 2018 y menor al 2019.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación de Defensoría de niñez y adolescencia de Sucre.

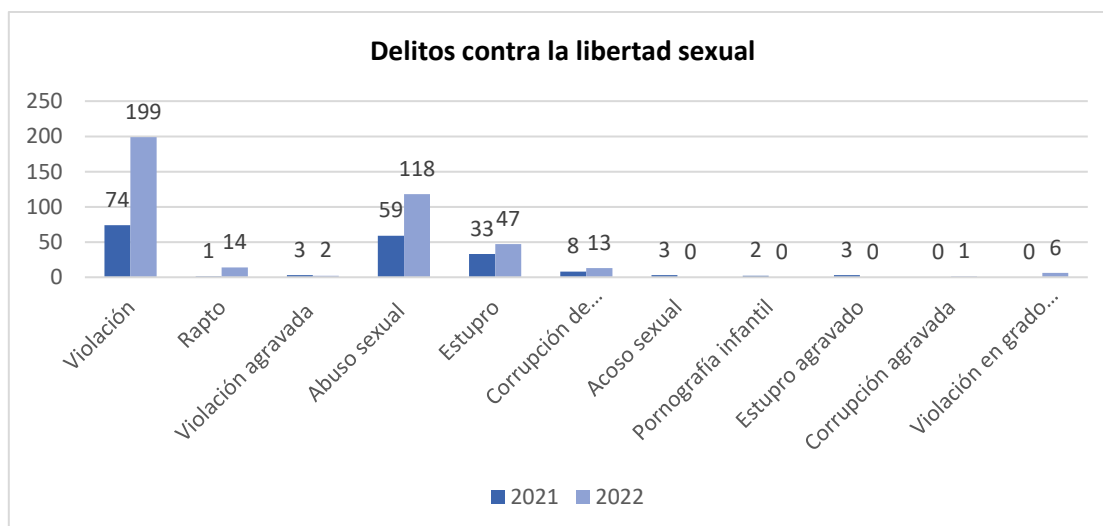
De acuerdo a los datos proporcionados por coordinación de defensorías de la niñez y adolescencia, las tipologías más atendidas son las siguientes:

- El derecho a la familia 29%
- Problemas sociales 20%
- Violencia (Delitos contra la integridad corporal, Derecho al respeto y la dignidad y Delitos contra la libertad sexual) 18%



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación de Defensoría de niñez y adolescencia de Sucre.

En relación al derecho a la familia, se puede identificar que se ha producido una reducción de casos en las diferentes tipologías entre el 2021 y el 2022, sin embargo, los casos que se atienden con mayor frecuencia son: La Asistencia familiar; Derecho de visita; Negligencia materna o paterna; Conflictos de guarda; y Abandono de niña, niño y adolescente.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación de Defensoría de niñez y adolescencia de Sucre.

En relación con los delitos contra la libertad sexual, llama la atención que se ha producido un importante incremento de los mismos el año 2022, las tipologías que se producen con mayor frecuencia son: La violación a niña, niño y adolescente; Abuso sexual; Estupro y Corrupción de menores.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación de Defensoría de niñez y adolescencia de Sucre.

Respecto a la integridad corporal las tipologías que se producían con mayor frecuencia el 2021 eran la Denegación de auxilio; Lesiones graves y leves y Reinserción familiar. Y el 2022 las tipologías que se registraron con mayor frecuencia son: La violencia familiar o doméstica; El rescate de menor en situación de riesgo y la Reinserción familiar (que se redujo en mas de un 50% en relación a la anterior gestión).

- **Noviazgos violentos**

En Chuquisaca. de acuerdo a los datos de la Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres (2016):

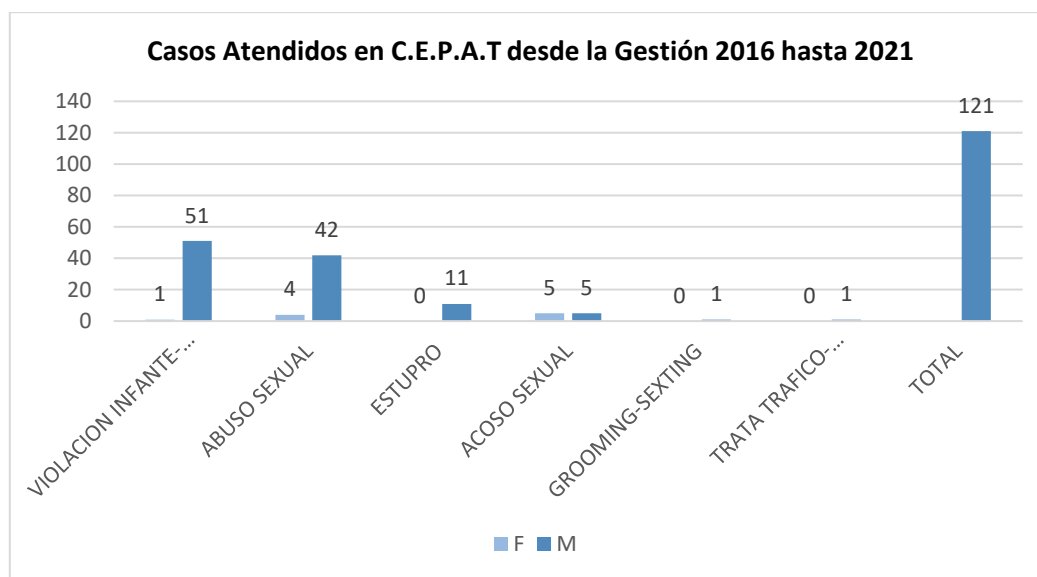
- El 74% de las mujeres de 15 años o más, refiere que vive o ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su relación, de acuerdo al tipo: 98% psicológica, 13% física y 23% sexual.
- Y el 37% en los últimos 12 meses, de acuerdo al tipo de violencia: 84% psicológica, 33% física y 27% sexual.

De acuerdo a EDSA 2016 el 41% de mujeres casadas o unidas, han experimentado por lo menos una situación de violencia por parte de su pareja en Chuquisaca en los últimos 12 meses– el 41,8% violencia emocional, el 21,7% violencia física y el 11,9% sexual -.

Muchas veces la violencia que se genera dentro de las relaciones de pareja no son percibidas por las adolescentes y jóvenes como tal, por la naturalización de la violencia al interior de las familias, por los estereotipos de género que naturalizan relaciones de poder relegando a la mujer a un rol de codependencia económica, familiar (por los/as hijos/as) de servicio y labores domésticas y “atención a la pareja e hijos” y emocional y por la idea del “amor romántico”, entre otros.

Existen mecanismos individuales y sociales que sostienen la producción, reproducción y tolerancia a hechos de violencia; frente a los cuales se pueden ofrecer herramientas que eduquen a la juventud para erradicar las situaciones violentas en el contexto de relaciones interpersonales “Es necesario alertar a las/os jóvenes acerca de la violencia mediante la cual pueden ser objeto en sus noviazgos; para prevenir e identificar la violencia de género, a través de la desnaturalización y deconstrucción de los estereotipos impuestos por la sociedad; construyendo relaciones en términos de igualdad, promoviendo la importancia de los buenos tratos; como la comunicación, el respeto e igualdad.”⁴

- **Casos atendidos en el CEPAT**



Fuente: PTDI Chuquisaca 2021-2021 en base a casos atendidos en CEPAT-SEDEGES

El CEPAT desde su creación en Chuquisaca en 2016, atendió a un total de 321 niñas y niños víctimas de violencia sexual: víctimas de violación, abuso sexual, Grooming y trata. De las que 62 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual fueron atendidas el 2020 y 121 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual fueron atendidas el 2021 por el CEPAT. Siendo las tipologías de violación y abuso sexual las más frecuentes.

Actualmente el CEPAT cuenta con una psicóloga que realiza la atención psicoterapéutica y acciones puntuales de prevención. Es necesario que progresivamente se amplíe el equipo para brindar un servicio interdisciplinario de atención psico – socio – legal a las víctimas y sus familias, contribuyendo a promover la reparación integral del daño y la reintegración familiar en coordinación con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia e instancias de protección, y a implementar una estrategia preventiva permanente en coordinación con el sistema educativo y el Consejo departamental contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, en el marco de las políticas vigentes⁵.

⁴ Programa educativo de Montevideo, basado en la resolución municipal N° 14277 de agosto de 2012, es una herramienta de acción preventiva contra la violencia de género desde las primeras fases del noviazgo entre los/as adolescentes acorde a las convenciones internacionales y leyes nacionales, provinciales y locales. <https://www.facebook.com/La-violencia-no-es-amor-490918747754503/>

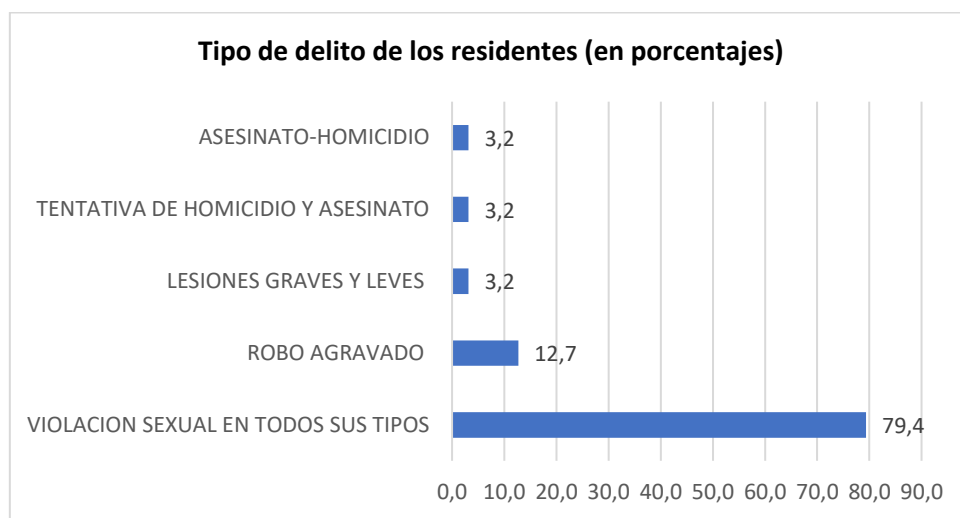
⁵ Protocolo de prevención atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Protocolo Único de atención especializada a víctimas de trata y tráfico de personas y rutas de intervención.

- **Adolescentes con responsabilidad penal**

Los adolescentes con responsabilidad penal son quienes incurran en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales. Que responden por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga.

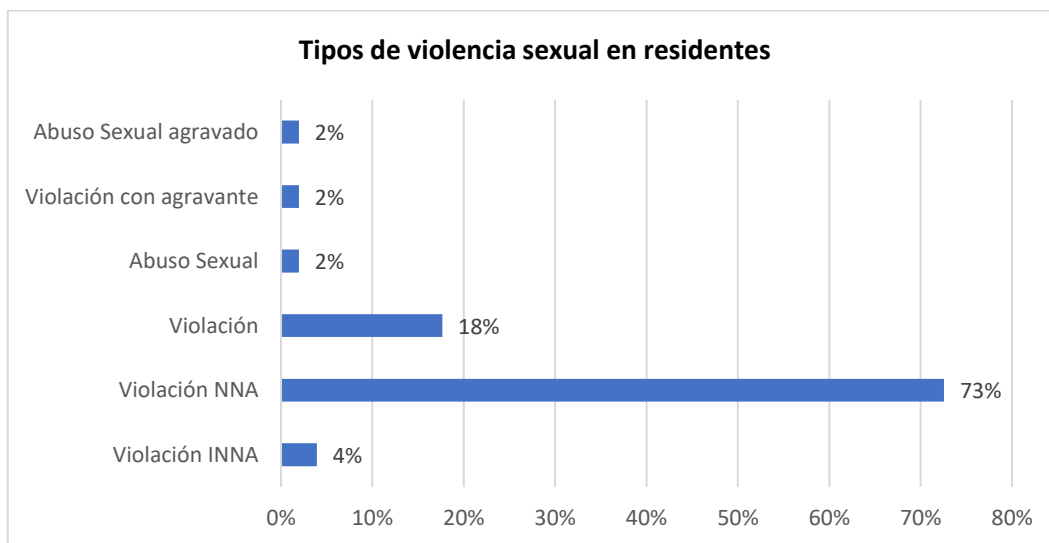
Actualmente el Centro de Reintegración Social Solidaridad atiende a 93 adolescentes, de los que se encuentran en cumplimiento de medida socioeducativa (el 82%), y con medida preventiva (4%) y prófugo o acogido, en ambos casos el 1% de los adolescentes.

Es importante aclarar que, aunque el 82% de los jóvenes se encuentran en cumplimiento de su medida socioeducativa, 63 cumplen medida socioeducativa en privación de libertad.



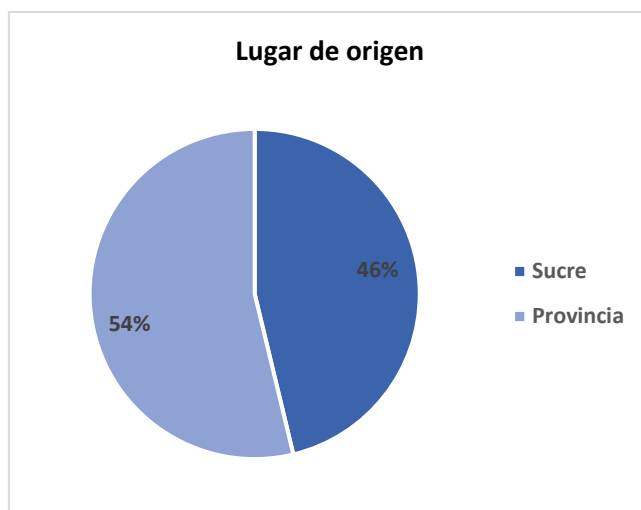
Fuente: ONG Realidades en base a base de datos de SEDEGES

De los 63 residentes en el centro, podemos observar que el 79.4% se encuentra allí debido a delitos sexuales, que incluyen violación sexual y otros como acoso sexual, abuso sexual y actos sexuales abusivos. Por otro lado, el 12.7% está detenido por haber cometido robos agravados, mientras que un 3.2% está en el centro por tentativa de homicidio. Otro 3.2% está encarcelado por asesinato o homicidio.



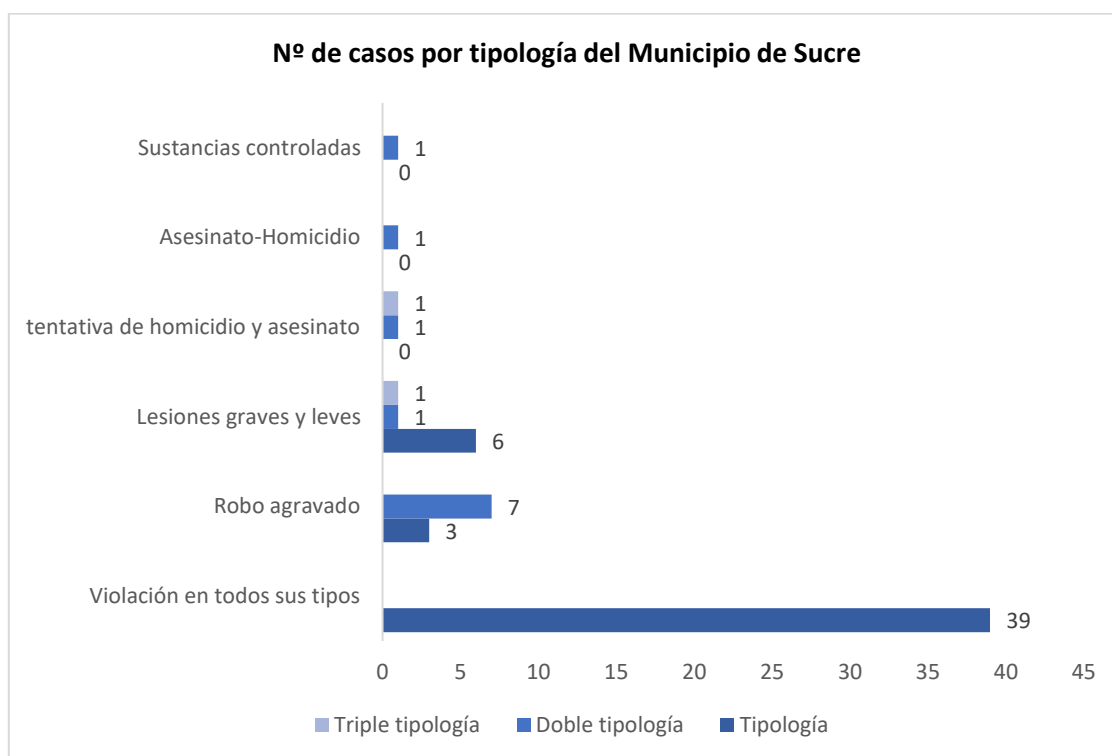
Fuente: ONG Realidades en base a datos de SEDEGES

Del 79,4% de residentes que cometieron delitos sexuales el 73% fue por violación a niña niño y adolescente, el 18% se encuentra en el centro por violación, en menor porcentaje de 4% violación a infante, niña niño y adolescente, por otro lado, el 2% está por abuso sexual, 2% por abuso sexual con agravante y finalmente violación con agravante con el 2% de residentes.



Fuente: ONG Realidades en base a datos de SEDEGES

Se puede observar que del total de residentes del centro de reintegración social Solidaridad, el 46% (43 casos), corresponden al Municipio de Sucre, frente al 54% (50 casos) que son de provincias del interior del departamento de Chuquisaca.



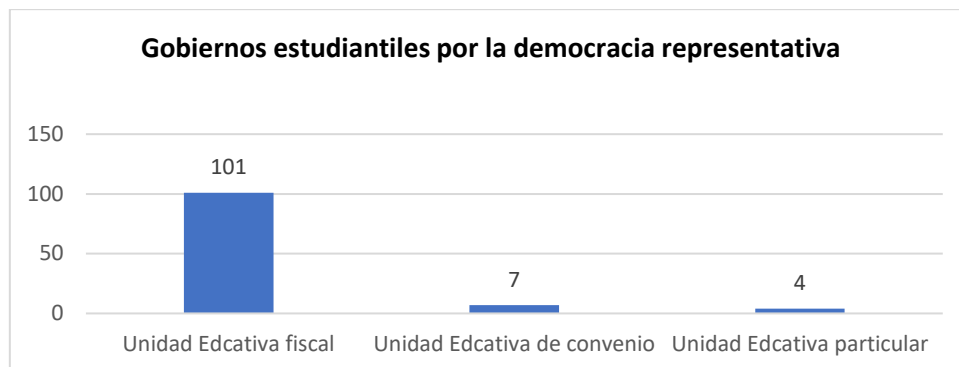
Fuente: ONG Realidades en base a datos de SEDEGES

Del total de casos que corresponden al municipio de Sucre, el 91% se encuentran dentro de la tipología de violación en todos sus tipos (39 casos), seguido del 23% robo agravado (10 casos) y el 19% por lesiones graves y leves (8 casos). Cabe aclarar que algunos adolescentes están por más de una de las tipologías anteriormente mencionadas.

2.5. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

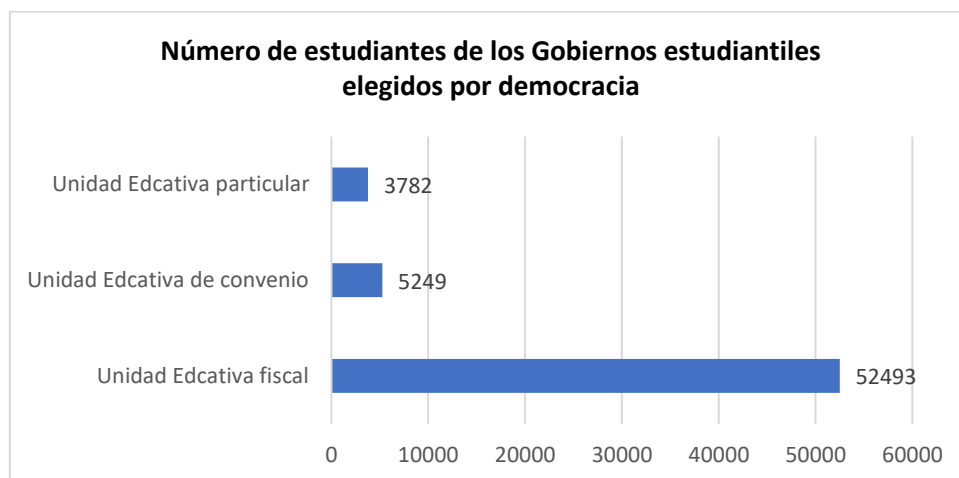
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a opinar y a realizar peticiones que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por las autoridades, de acuerdo al Código niña, niño y adolescente – Ley N° 548.

2.5.1. Gobiernos estudiantiles



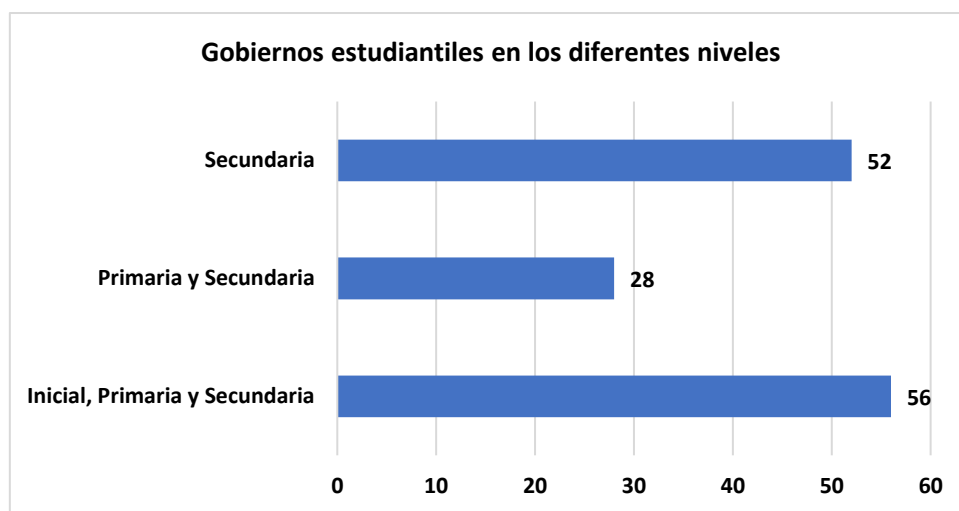
Fuente: Elaboración propia con base en SIFDE – TED

De acuerdo a los datos del SIFDE del Tribunal Electoral Departamental, se conformaron oficialmente 101 Gobiernos estudiantiles provenientes de Unidades Educativas fiscales. Por otro lado, se identificaron 7 gobiernos estudiantiles en Unidades Educativas de convenio y por último 4 gobiernos corresponden a Unidades Educativas particulares.



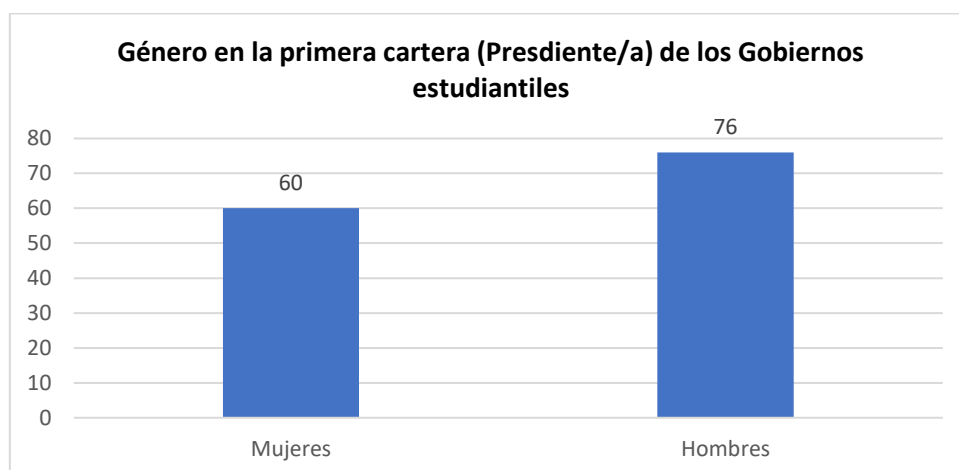
Fuente: Elaboración propia con base en SIFDE – TED

También se identifica una directa relación entre la cantidad de unidades educativas que tienen gobiernos estudiantiles democráticamente electos y el ejercicio del derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la participación estudiantil en colegios fiscales es más numerosa, ya que en las Unidades Educativas fiscales se movilizaron hasta 52.493 estudiantes, por otro lado, se movilizaron 5.249 estudiantes de Unidades Educativas de convenio y 3.783 de Unidades Educativas particulares.



Fuente: Elaboración propia con base en SIFDE – TED

Dentro del total de gobiernos estudiantiles que se encuentran conformados en Sucre, se identificó que 52 de estos pertenecen al nivel de secundaria, 28 Unidades Educativas solo de primaria y secundaria y 56 Unidades educativas cuentan con los gobiernos estudiantiles en todos sus niveles.



Fuente: Elaboración propia con base en SIFDE – TED

Así mismo la diferencia de mujeres y hombres ocupando la cartera de presidencia, aún es significativa, son 60 mujeres que ocupan la primera cartera y 76 hombres, lo que muestra que, a pesar de las políticas de paridad y alternancia en la elección de gobiernos estudiantiles, todavía existe una brecha de género.

2.5.2. Comité de la niña, niño y adolescente

El Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Sucre, es la instancia que representa a las niñas, niños y adolescentes ante las autoridades que tienen la obligación de escuchar y tomar en cuenta sus opiniones en todas las políticas públicas que les afectan.

El primer Comité Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de Sucre se creó el año 2015, En cumplimiento al Código Niña, Niño y Adolescente el Comité Municipal elaboró su Reglamento interno, aprobado el 29 de marzo de 2016 por Resolución administrativa N° 14/2016 de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

En el mencionado Reglamento Interno que fue elaborado por las niñas y niños del Comité, se puede destacar la obligatoriedad de desarrollar elecciones democráticas y representativas con participación de representantes de los 8 distritos municipales, organizaciones de niñas y niños como la Federación de Estudiantes de Secundaria y los Scouts del Grupo Junín, y poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes de Centros de Acogida, con Discapacidad, de Centros de Reintegración Social, en situación de trabajo y niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas como la Marka Quila Quila de Qhara Qhara Suyu.

Y a partir del 2015 se han elegido democráticamente a nuevos miembros del Comité municipal de niñez y adolescencia cada 2 años con apoyo de la Dirección Distrital de Educación y el SIFDE del Tribunal Electoral departamental de Chuquisaca, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y adolescencia del Gobierno Municipal de Sucre y el apoyo de ONGs y fundaciones como ONG Realidades, Aldeas SOS, CEADL, CEMSE, Save The Children, Mama Canguro entre otras.

Los Comités Municipales de Niñez y Adolescencia realizan diferentes actividades de promoción de derechos y participación en espacio de construcción de políticas públicas siendo sus principales logros:

- La elaboración participativa de la Ley Municipal de Niñez y Adolescencia N° 120/2018, presentada por el Comité Municipal de la niña, niño y adolescente por iniciativa ciudadana junto a ONG Realidades y el Observatorio de Derechos y aprobada el 5 de julio de 2018.
- La elaboración participativa del Reglamento de la Ley Municipal de Niñez y Adolescencia N° 120/2018 aprobado el 2019.
- La elaboración participativa del Plan Municipal de reactivación social frente a COVID 19 aprobado el año 2021

La activa participación en la elaboración del presente Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, a través del recojo de propuestas de grupos en situación de vulneración y de las niñas, niños y adolescentes de barrios periurbanos y zonas concurridas como el mercado campesino. Y la elaboración de propuestas presentadas al nuevo Comité de Niñez y Adolescencia de Sucre.

El penúltimo Comité Municipal de la niña, se creó el 9 de febrero de 2021, con una vigencia de 2 años del 2021 al 2023. Estaba compuesto al final de su gestión de la siguiente manera:

Titulares	Suplentes	Representación
E. M. PRESIDENTA		UE Junin
L. Ch.	K. N.	Grupo Scout Junín
K. R.V.	E. C.	Centro de reintegración social solidaridad
C. S.		Centro calor de hogar
M. O.		Centro Aprecia
G. P.		
C. D. M.		
B. F.		UE TAEPO
G. Y.		
L. D.		GACIP

El mismo que ha realizado las siguientes actividades principales:

- Promoción de derechos y difusión del rol del Comité en barrios periurbanos, ferias y centros de acogida.
- Participación en el Comité Departamental de la niña, niño y adolescente de Chuquisaca y el Comité Plurinacional de la niña, niño y adolescente de Bolivia.
- Participación en la evaluación del Plan departamental de la niñez y adolescencia de Chuquisaca 2016-2020.
- Participación en la conformación y elaboración del reglamento del Consejo Municipal Intersectorial de la niña, niño y adolescente.
- Recojo y elaboración de propuestas para el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025
- Difusión de la convocatoria a conformación del nuevo Comité Municipal de la niña, niño y adolescente de Sucre, promoviendo y acompañando los procesos democráticos de elección en los distritos urbanos y rurales, con poblaciones en situación de vulnerabilidad como centros de acogida, centros de reintegración social, centros de niñas y niños con discapacidad y en situación de trabajo.

Recientemente, el 13 de octubre de 2023 se conformó el nuevo Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de Sucre 2023-2025. Después de un largo proceso democrático de elección de representantes de los 8 distritos de Sucre y de organizaciones de niñas, niños y adolescentes promovido por el Comité Municipal de niñez y adolescencia saliente en coordinación con la Defensoría de la niñez y adolescencia del Gobierno municipal de Sucre, el SIFDE del Tribunal Electoral Departamental, la Dirección Distrital de Educación y entidades del Comité Municipal Intersectorial de niñez y adolescencia como ONG Realidades, Save The Children, Aldeas SOS y CEMSE.

El actual Comité Municipal de Niñez y Adolescencia está conformado de la siguiente manera:

Titulares	Suplentes	Representación
J. A. R. PRESIDENTE		Centro de educación especial APRECIA
A.R. VICEPRESIDENTA		UE Gregorio Reinolds
M. A. A. SECRETARIO DE ACTAS	D. Ch.	UE San Xavier
A. M. G.		UE Domingo Savio
M. L.	I. P.	UE Ademar Carbajal Collazos
M. M. O.	J. S.	Centro Calor de hogar Hogar Jesus de Nazareth
A. A.	L. C.	Grupo Scout Junin
C. M.	A. C.	Centro de reintegración social solidaridad
B. M. S.	Z. Ch.	UE Punilla
G. M.		UE Ilinfi
G. C.	D. S.	FGML
B. M.	M. G.	NNATS
	S. B.	UE Daniel Sanchez Bustamante
	C. H.	UE Audiologia
	L. Z.	UE entrabasaguas esquina Hiroshima
	A. C.	UE Qhora Qhora

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre ha designado a la Defensoría de niñez y adolescencia como la instancia que brinda apoyo técnico al Comité Municipal de niñez y adolescencia, sin embargo, a pesar de los lineamientos normativos tanto nacionales como autonómicos

establecidos en la ley N° 548 y la ley N° 120/2018, que estipulan la obligatoriedad de asignación presupuestaria y de brindar apoyo técnico y económico del Gobierno Autónomo Municipal, en el Municipio de Sucre no se ha asignado un presupuesto específico para el Comité Municipal de niñez y adolescencia en el PTDI y en el POA municipal.

2.6. PROBLEMAS Y RESPUESTA MUNICIPAL

2.6.1. Problemas identificados

2.6.1.1. problemas identificados por el Comité Municipal de Niñez y Adolescencia

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Salud		Mala alimentación y bajo consumo de productos saludables en las familias y dentro de las unidades educativas	Consumo de bebidas alcohólicas y drogadicción.
Educación		Falta de formación en el uso de nuevas tecnologías dentro de los colegios	Falta de Educación sexual en las unidades educativas y dentro de las propias familias
Protección	Existe demasiada institucionalización de niñas y niños.	Falta de comunicación dentro de las familias. Violencia y bullying dentro de los colegios. Niñez y adolescencia en situación de calle. Trata y tráfico de personas. Falta de atención psicológica a las niñas y niños en centros de acogida. Reintegración familiar de las niñas, niños en centros de acogida. Falta de acceso a atención médica.	Violencia y bullying en los colegios. Trata y tráfico de personas. Reintegración familiar de Adolescentes en centros de acogida. Separación de hermanos dentro de los centros de acogida. Falta de acceso a espacios de recreación y deportes por parte de las y los adolescentes que se encuentran en centros de acogida y de reintegración
Participación		Falta de atención y escucha a las necesidades de las niñas y niños por parte de las autoridades	Falta de atención y escucha a las necesidades de las adolescentes por parte de las autoridades
Otros		Bajos ingresos económicos Falta de empleo para los padres de familia	Falta de fuentes laborales dignas para adolescentes mayores de 14 años

2.6.1.2. Problemas identificados por las entidades que conforman el Consejo Municipal Intersectorial de la niñez y adolescencia

- Participación de la niñez y adolescencia y sistema de protección de la NNA

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Participación		Ausencia de recursos asignados de manera específica en el PTDI y POA para la conformación, funcionamiento, desarrollo de actividades y acompañamiento técnico al Comité Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de Sucre.	

		Reducido contacto y comunicación entre el Comité Municipal de niñez y adolescencia y gobiernos estudiantiles, grupos de Scouts, y organizaciones de niñas, niños y adolescentes en los distritos
		Limitados espacios de participación del Comité Municipal de niñez y adolescencia con las autoridades ejecutivas y legislativas
		No se ha logrado aún la participación permanente de niñas, niños y adolescentes representantes de los pueblos indígenas en el Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Sucre.
Sistema de protección de la NNA	Insuficiente asignación presupuestaria para la atención de la niñez y adolescencia de forma efectiva, que responda a los lineamientos normativos plurinacionales y autonómicos	
	Alta rotación de personal, y consecuente falta de especialización para la atención de la niñez y adolescencia (Falta de formación para atención a primera infancia, víctimas de violencia, nats, nasc, trata, adolescentes)	
	Ausencia de sistema de información vinculado al SINNA por deficiente coordinación del nivel central, y reducido equipamiento informativo y acceso a servicio de internet en todas las DNA y la falta de algunos registros administrativos (no se sistematizan datos embarazo en adolescentes, seguimiento a certificación de Centros AIDA, ILE, reportes de salud sobre la escala de desarrollo de primera infancia) y no se tiene acceso público a datos	
	Limitada coordinación interinstitucional e intergubernativa para el desarrollo de políticas públicas de prevención y atención porque el consejo municipal intersectorial de la niña niño y adolescente no se encuentra fortalecido y no cuenta con un reglamento interno aprobado de funcionamiento y plan anual que defina la participación de las instituciones públicas, privadas y de sociedad civil con delegados con poder de decisión	
	Baja participación de la comunidad y las familias de NNA (Juntas vecinales, juntas escolares o de padres y madres de familia, autoridades originarias campesinas) en instancias de coordinación y escuelas de padres y madres de familia	
	Reducida coordinación con otros comités municipales, departamentales que existen como el Consejo de trata, el consejo de lucha contra la violencia a los que acuden diferentes representantes por la rotación de personal produciendo desinformación, poca coordinación interinstitucional e intergubernativa y superposición de actividades	

• **Prevención de la violencia y vulneración de derechos de las NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
VIOLENCIA – Educación	Falta de programas interinstitucionales de prevención que sean sistemáticos, aplicables en diferentes grupos etarios y que considere una misma estructura y lineamientos, y eviten la duplicidad y superposición de acciones, para ser implementados por entidades gubernamentales, no gubernamentales de la sociedad civil organizada, como también por la Dirección Departamental de Educación (prevención de violencia, de abandono familiar, de trabajo infantil y explotación laboral, trata, niñez en calle, prevención de consumo de alcohol y drogas)		
VIOLENCIA, EIS	Los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes no se encuentran en todas las Unidades Educativas, siendo que estos abordan temas de Salud sexual reproductiva y educación Integral para la sexualidad, desde un enfoque de desarrollo integral, cuidado, prevención de todo tipo de violencias, entre otros.		
VIOLENCIA – Educación	No todas las Unidades Educativas cuentan con Planes de Convivencia Armónica y pacífica, estructurada de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de educación con base en el Código Niña, Niño y Adolescente, elaborados desde enfoques de derechos, cultura de paz y justicia restaurativa.		
Embarazo adolescente – Educación	A pesar de que la nueva curricula educativa aborda la Educación Integral para la sexualidad, no se cuenta con contenidos desarrollados para su abordaje con los diferentes grupos etarios de niñas, niños y adolescentes.		

Educación	Algunas unidades educativas en mal estado, sin bibliotecas, laboratorios, salas de computación y acceso a internet		
Educación	Limitada oferta gratuita de actividades de educación del tiempo libre, espacios al aire libre, actividades culturales, deportivas, de apoyo pedagógico y de promoción de la comunicación y convivencia familiar		
VIOLENCIA – Educación	Padres y madres de familia no cumplen a cabalidad sus deberes y no existe un control parental (desde un enfoque de derechos) que precautele y proteja los derechos de los infantes, niñas, niños y adolescentes. Además, no existen espacios donde se enseñen o apliquen mecanismos de educación restaurativa familiar – con procesos de infracción por incumplimiento		
VIOLENCIA – Educación		Las brigadas escolares de seguridad ciudadana se encuentran limitadas, no cuentan con su libreta de servicio civil y además no abordan temas de cultura de paz, comunicación asertiva, resolución de conflictos, prevención al consumo de sustancias controladas, alcohol, bullying y otros como parte de su formación para poder hacer replica.	
		Elevados índices de alcohol y drogas, promueven el incremento de la delincuencia juvenil y no se cuentan con programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social y laboral dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social, a personas drogodependientes y alcohólicas, a adolescentes con responsabilidad penal	
Salud – embarazo en adolescentes			Falta de centros de salud que brinden atención especializada y diferenciada, den orientación para la salud sexual y reproductiva, apliquen la anticoncepción de emergencia, ILE, prevención de ITS, que cuenten con la certificación AIDA.

• **Atención y reparación integral de derechos de las NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Educación – violencia	Bajo conocimiento de protocolos por parte de servidores públicos y la población (protocolo de denuncia de violencia no se conoce al interior de la comunidad educativa, la población no conoce los servicios de atención, los servidores públicos no conocen las rutas de atención).		
Salud – Violencia DSDR		Limitada aplicación del protocolo de atención a NNA víctimas de violencia sexual e ILE por parte de servidores públicos del área de protección y salud	
Protección – violencia		Limitado seguimiento y coordinación de la DNA con servicios de atención terapéutica para la reparación del daño a las víctimas y ejercicio de derechos y reintegración de adolescentes con responsabilidad penal desde un enfoque de justicia restaurativa.	
NNATS		No existe una coordinación adecuada entre la DNA y la jefatura departamental del trabajo al momento de realizar las inspecciones laborales.	
NNATS			Inexistencia de autorizaciones de trabajo emitidas por la DNA
NNATS		Cobertura del programa de protección social para 100 NNATs frente a la estimación de NNATS que superan los 10.000	
Derecho a la familia	Centro de acogimiento circunstancial no cuenta con personal interdisciplinario especializado para la atención a NNA de poblaciones vulnerables. Y tiene una limitada		

	capacidad ubicar y reintegrar a NNA a sus familias de origen o ampliada y aplicar otras modalidades para garantizar el derecho a vivir en familia
Derecho a la familia	Institucionalización de NNA en centros de acogida, intermitente seguimiento de DNA a NNA de centros de acogida, limitada definición de la situación jurídica de NNA para adopción
Derecho a la familia	Elevada cantidad de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida. No se cuenta con registro de seguimiento de NNA en acogimiento y de las intervenciones programáticas a fin de garantizar sus derechos, y en particular su derecho a vivir en familia. No se tiene un programa de reintegración familiar.

• **Protección social de derechos de las NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Educación - primera infancia	No existe dentro del sistema educativo la aplicación de herramientas de seguimiento al desarrollo de la primera infancia dentro de los kínderes, a pesar de ser estos los espacios que albergan a la mayor cantidad de niñas y niños menores de cinco años		
Protección – primera infancia	Falta de control adecuado a los centros infantiles que brindan servicios en el municipio de Sucre, sobre todo aquellos que pertenecen al sector privado, lo que no permite estandarizar la calidad de atención dentro de estos centros ni contar con una herramienta de seguimiento al desarrollo de las y los infantes.		
Derecho a la familia	No existen parámetro de estándares de calidad dentro de los centros de acogida, que permitan el monitoreo de los servicios que estos brindan a las y los niños y adolescente albergados en los centros.		

2.6.2. Alternativas de solución priorizadas

2.6.2.1. Alternativas de solución identificadas por las entidades que conforman el Comité Municipal de la Niña, Niño y Adolescente

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Salud		Mejorar la alimentación de las niñas y niños con el fomento del consumo de alimentos saludables como las frutas y verduras.	Prevenir el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, por medio de sensibilización a través de charlas y capacitaciones a las y los adolescentes en las unidades educativas.
Educación		Mejora la formación en el uso de nuevas tecnologías dentro de los colegios, dotando de equipos de computación.	Implementar dentro de las unidades educativas educación integral para la sexualidad, adecuado a las diferentes edades
Protección	Promover los diferentes tipos de cuidado antes de la institucionalización de las y los niños	Promover la comunicación dentro de las familias a través de servicios de orientación y capacitación a los padres y madres y familias. Implementar estrategias de prevención de Violencia y bullying dentro de los colegios mediante los planes de convivencia pacífica y armónica elaborados participativamente por las comunidades educativas, previo proceso de capacitación. Socializar e Implementar el protocolo de prevención de Niñez y adolescencia en situación de calle desde el programa de protección social, en coordinación con el comité de erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos. Implementar una estrategia de prevención de Trata de personas y tráfico de migrantes. Fortalecer una red de atención terapéutica para coordinar con DNA y CEPAT, para brindar	Prevención de todo tipo de violencias dentro de las unidades educativas por medio de la sensibilización tanto a estudiantes como maestros y sus familias. Prevenir la Trata y tráfico de personas incrementando la seguridad en las unidades educativas. Promover la reintegración familiar y otras modalidades de cuidado antes de que las y los adolescentes sean ingresados a centros de acogida. Difundir la normativa vigente y consolidar los mecanismos de control de la DNA para evitar la separación de hermanos dentro de los centros de acogida. Implementar espacios de recreación y deportes dentro de los centros de acogida y de reintegración

		atención psicológica a las niñas y niños en centros de acogida Reintegración familiar de las niñas, niños en centros de acogida. Difundir para mejorar el acceso al seguro universal de salud de las familias con bajos ingresos.	
Participación		Promover la participación del comité municipal en espacios de propuesta de políticas públicas “Que sean escuchadas nuestras propuestas”	Promover la participación del comité municipal en espacios de propuesta de políticas públicas
Otros		Promover la generación de fuentes laborales estatales para madres y padres de familia de bajos recursos	Identificación de fuentes laborales dignas y reubicación para adolescentes mayores de 14 años

2.6.2.2. Alternativas de solución identificadas por el Consejo Municipal Intersectorial de la niñez y adolescencia

- **Participación de la niñez y adolescencia y sistema de protección de la NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Participación		Que el GAM asigne recursos de manera específica en el PTDI y POA para la conformación, funcionamiento, desarrollo de actividades y acompañamiento técnico al Comité Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de Sucre. Y asigne un personal de apoyo técnico permanente.	
		Formular un plan de capacitación permanente y coordinación para el Comité NNA con el apoyo de entidades de la sociedad civil	
		Fortalecer el contacto y comunicación entre el Comité Municipal de niñez y adolescencia y gobiernos estudiantiles, grupos de Scouts, y organizaciones de niñas, niños y adolescentes en los distritos a través de actividades, sesiones públicas y visitas	
		Abrir espacios de participación del Comité Municipal de niñez y adolescencia con las autoridades ejecutivas y legislativas: Sesiones y Audiencias públicas.	
		Incidir en la participación permanente de niñas, niños y adolescentes representantes de los pueblos indígenas en el Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Sucre.	
Sistema de protección de la NNA	Incrementar la asignación presupuestaria para la atención de la niñez y adolescencia de forma efectiva, que responda a los lineamientos normativos plurinacionales y autonómicos y a la OG 19 del Comité Internacional del Niño Ampliar el plan de institucionalización de personal para DNA y servicios de atención a NNA, contando con un reglamento de selección y evaluación de personal. Elaborar un programa permanente de capacitación y actualización para el personal de DNA y servicios de atención a NNA (normativa y protocolos para atención a primera infancia, víctimas de violencia, nats, nasc, trata, adolescentes)		

	Consolidar el sistema de información vinculado al SINNA, ampliar equipamiento informativo y garantizar el acceso a servicio de internet (sistematizar datos de violencia, abandono, embarazo en adolescentes, Centros AIDA, ILE, reportes de salud sobre la escala de desarrollo de primera infancia)
	Fortalecer la coordinación interinstitucional e intergubernativa para el desarrollo de políticas públicas de prevención y atención consolidando el consejo municipal intersectorial de la niña niño y aprobando e implementando el reglamento interno, elaborar un plan anual que defina la participación de las instituciones públicas, privadas y de sociedad civil con delegados con poder de decisión y presentar informes anuales
	Implementar una estrategia de difusión de la línea gratuita y de los servicios de atención e instancias de participación (en idiomas de señas y lenguas originarias), promoviendo la participación de la comunidad y las familias de NNA (Juntas vecinales, juntas escolares o de padres y madres de familia, autoridades originarias campesinas) en instancias de coordinación y escuelas de padres y madres de familia
	Coordinar y delegar representantes para la coordinación con otros comités municipales, departamentales: El Comité de la primera infancia, subsistemas departamentales de protección, penal, consejo contra la trata y tráfico de personas y lucha contra la violencia y otros

• **Prevención de la violencia y vulneración de derechos de las NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
VIOLENCIA – Educación	Elaborar programas interinstitucionales e intergubernativos de prevención que sean sistemáticos, aplicables en diferentes grupos etarios y que considere una misma estructura y lineamientos (prevención de violencia, de abandono familiar, de trabajo infantil y explotación laboral, trata, niñez en calle, prevención de consumo de alcohol y drogas)		
VIOLENCIA, EIS	Consolidar los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes y ampliarlos promoviendo que el GAM asigne recursos para contratar psicólogos para los GAIE por distritos para abordar temas de Salud sexual reproductiva y educación Integral para la sexualidad, desde un enfoque de desarrollo integral, cuidado, prevención de todo tipo de violencias, entre otros.		
VIOLENCIA – Educación	Implementar una estrategia de fortalecimiento, seguimiento y apoyo a la implementación de Planes de Convivencia Armónica y pacífica, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de educación con base en el Código Niña, Niño y Adolescente, elaborados desde enfoques de derechos, cultura de paz y justicia restaurativa.		
Embarazo adolescente – Educación	Conformar una mesa técnica municipal para diseñar propuestas para la curricula educativa en Educación Integral para la sexualidad con contenidos desarrollados para su abordaje con los diferentes grupos etarios de niñas, niños y adolescentes.		
Educación	Fortalecer y mejorar la infraestructura y equipamiento de Unidades educativas. Abrir centros municipales comunitarios con acceso a bibliotecas, salas de computación y acceso a internet coordinando con juntas vecinales, promotoras comunitarias y ongs y fundaciones (mercados y barrios amigos de la niñez)		
Educación	En centros municipales comunitarios ampliar la oferta gratuita de actividades de educación del tiempo libre, espacios al aire libre, actividades culturales, deportivas, de apoyo pedagógico y de promoción de la comunicación y convivencia familiar		
VIOLENCIA – Educación	Sensibilizar y capacitar a Padres y madres de familia para que conozcan y cumplan con sus deberes, adquieran habilidades de control parental de dispositivos móviles (desde un enfoque de derechos) que precautele y proteja los derechos de los infantes, niñas, niños y adolescentes. Desde la escuela de padres, en coordinación con los GAIEs y centros municipales comunitarios abrir espacios de orientación, fortalecimiento de la comunicación no violenta, EIS, y otros		
VIOLENCIA – Educación		Fortalecer las brigadas escolares de seguridad ciudadana con su libreta de servicio civil y además con capacitaciones en temas de cultura de paz, comunicación asertiva, resolución de conflictos, prevención al consumo de sustancias controladas, alcohol, bullying y otros como parte de su formación para poder hacer replica.	
		Promover la reeducación, rehabilitación y reinserción social y laboral de NNA en riesgo social, de drogas y alcohol y adolescentes con responsabilidad penal. (NA)	

Salud – embarazo en adolescentes			Implementar una estrategia para sensibilizar e incidir en procesos de certificación de centros AIDAJ, para que los centros de salud brinden atención especializada y diferenciada, den orientación para la salud sexual y reproductiva, apliquen la anticoncepción de emergencia, ILE, prevención de ITS.
----------------------------------	--	--	---

• **Atención y reparación integral de derechos de las NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Educación – violencia	Fortalecer el conocimiento de protocolos por parte de servidores públicos y la población (protocolo de denuncia de violencia no se conoce al interior de la comunidad educativa, la población no conoce los servicios de atención, los servidores públicos no conocen las rutas de atención).		
Salud – Violencia DSDR		Desarrollar procesos de capacitación y campañas o estrategias de sensibilización para luchar contra los prejuicios y estereotipos en servidores públicos de DNA y Salud para la aplicación del protocolo de atención a NNA víctimas de violencia sexual e ILE	
Protección – violencia		Desarrollar procesos de capacitación en justicia restaurativa. Coordinar con servicios de atención terapéutica coordinados por la DNA para la reparación del daño a las víctimas y realizar el seguimiento a mecanismos de seguimiento de las DNA a NNA en centros de acogida y adolescentes en centros de reintegración social, desde un enfoque de justicia restaurativa.	
NNATS		Fortalecer la coordinación entre la DNA y la jefatura departamental del trabajo al momento de realizar las inspecciones laborales, consolidando la articulación en el comité de erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos	
NNATS			Fortalecer la capacitación e implementar una estrategia de aplicación de autorizaciones de trabajo por la DNA
NNATS		Fortalecer la estrategia de intervención y ampliar la cobertura del programa de protección social para NNATS y desarrollar estrategias preventivas de NNASC y NNATS desde el comité de erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos	
Derecho a la familia	Regular y fortalecer el Centro de acogimiento circunstancial, la especialización del personal mediante formación y sus mecanismos de búsqueda de familias de origen o ampliada. Desarrollar un programa para aplicar otras modalidades para garantizar el derecho a vivir en familia (guarda y otros)		
Derecho a la familia	Implementar un programa de reintegración familiar con un sistema de seguimiento de la DNA a NNA de centros de acogida para que contribuyan a la reintegración familiar o a la definición de la situación jurídica de NNA para adopción		
Derecho a la familia	Consolidar el programa prevención y promoción del derecho a la familia como política pública, para el abordaje a familias y NNA en situación de riesgo de perder el derecho a la familia		

• **Protección social de derechos de las NNA**

Ámbito	Primera Infancia	Niñez	Adolescencia
Educación - primera infancia	Implementar en el sistema educativo. herramientas de seguimiento al desarrollo de la primera infancia dentro de los kínderes y mediante estrategias comunitarias a través de medios de comunicación y redes sociales		
Protección – primera infancia	Regular el control adecuado a los centros infantiles que brindan servicios en el municipio de Sucre, sobre todo aquellos que pertenecen al sector privado, para estandarizar la calidad de atención dentro de estos centros y contar con una herramienta de seguimiento al desarrollo de las y los infantes.		
Derecho a la familia	Regular los centros de acogida y realizar un seguimiento a la aplicación de la normativa que contribuya a consolidar parámetro de estándares de calidad dentro de los centros de acogida, desarrollando estrategias de monitoreo de los servicios que estos brindan a las y los niños y adolescente albergados en los centros.		

3. POLÍTICA Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1. POLÍTICA



El presente Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se desarrollará en base a políticas de prevención, atención y protección definidas para cada grupo etareo:

- Primera infancia, se implementarán políticas públicas en el marco de un modelo de calidad de vida para la atención y desarrollo integral, mediante una política municipal de educación y atención en diferentes modalidades (los Centros Infantiles Municipales para el Desarrollo Infantil y en modalidades no institucionalizadas de atención familiar) en el marco del modelo sistémico de prevención, atención, cuidado y protección social.
- Niñez, se implementarán políticas de atención, protección social y prevención de violencia y trabajo infantil, a la primera infancia y por el derecho a vivir a la familia desde un enfoque de derechos, de participación en el marco de un modelo comunitario de prevención y protección integral.
- Adolescencia, se implementarán políticas de atención y prevención desde un enfoque de educación integral en sexualidad, modelo de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes, fortalecimiento de factores protectores y reducción de factores de riesgo, contribuyendo a la elaboración del proyecto de vida.

3.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.2.1. Visión

Al 2025 niñas, niños y adolescentes del municipio de Sucre, ejercen sus derechos, participando activamente en la transformación de sus realidades y acceden a oportunidades de desarrollo integral sostenible para vivir bien, en entornos familiares y comunitarios libres de toda forma de violencia.

3.2.2. Misión

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, cuenta con un sistema municipal de protección, consolidado con servicios especializados de calidad, que garantizan el disfrute y el ejercicio pleno de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del municipio, que participan activamente en la generación y seguimiento de políticas públicas municipales inclusivas de prevención y atención, con enfoque de derechos, género y generacional, estableciendo alianzas estratégicas, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad.

3.2.3. Líneas estratégicas

El presente Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, se ha diseñado en torno a 5 líneas estratégicas:

- **Participación de la niñez y adolescencia**

Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en la elaboración y seguimiento de políticas públicas municipales, contribuyendo a que las autoridades escuchen sus opiniones y sean tomadas en cuenta en las políticas que les afectan.

- **Sistema de protección de la niñez y adolescencia**

Fortalecer el sistema municipal de protección de la niñez y adolescencia, con programas, servicios y mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernativos, para la implementación de políticas de prevención, protección, atención y restitución de derechos de la niñez y adolescencia, con personal especializado e institucionalizado, en el marco de las competencias autonómicas municipales.

- **Prevención de la violencia y vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

Implementar programas de prevención de violencia y vulneración de derechos de la niñez y adolescencia, promoviendo la creación de entornos educativos, familiares y comunitarios favorables para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia y la convivencia pacífica y armónica

- **Atención y reparación integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

Brindar una atención integral psico socio legal a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o de vulneración de derechos desde un enfoque de protección reforzada, de derechos, diferencial, interseccional, de genero e intercultural, para contribuir a la reparación integral de daños

- **Protección social de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

Fortalecer los servicios de protección social para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de abandono, con riesgo de perder el derecho a la familia, de la primera infancia, en situación de trabajo u otros, desde un enfoque de abordaje familiar y comunitario

3.3. ESTRATEGIA

3.3.1. Criterios operativos

El presente Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se implementará bajo la rectoría del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en coordinación con el Comité Municipal de niñez y adolescencia de Sucre y el Consejo Municipal intersectorial de niñez y adolescencia, de acuerdo a la normativa autonómica vigente, y los siguientes criterios operativos:

- Integralidad, es decir que el plan multisectorial municipal de la niñez y adolescencia 2023-2025 se plantea desde un enfoque holístico que considera el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, comprendiendo las características propias de cada etapa etarea. Definiendo políticas de protección integral, que con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el gobierno municipal, con la participación de la Familia y la comunidad, para garantizar que todas las niñas y niños gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en cada etapa de desarrollo.
- Intergeneracional, es decir que el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 es un plan para todas las edades, que ajusta sus estructuras y funcionamiento y sus políticas a las necesidades y capacidades de todas y todos, en beneficio de todas y todos. Toda vez que, una sociedad para todas las edades permitiría a las generaciones efectuar inversiones recíprocas y compartir los frutos de esas inversiones, guiadas por los principios gemelos de reciprocidad y equidad. Para hablar se intergeneracionalidad no basta con estar juntos; lo importante es hacer y hacer juntos, y que ese hacer vaya más allá de la mera interacción y pase a la relación. (Naciones unidas 1999)
- Intersectorial, el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se desarrollará mediante la acción interinstitucional con la

intervención de los diferentes sectores, educación, salud, protección, prevención, para brindar respuestas integrales a partir de la acción articulada y coordinada.

- Interseccional, es decir que el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 buscará desarrollar medidas especiales de carácter temporal para eliminar las múltiples formas de discriminación que se presentan (por género, sexo, edad, origen u otro) dejando en mayor situación de vulnerabilidad a ciertas poblaciones que tienen múltiples desventajas y discriminaciones.
- Multinivel, es decir que el Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se plantea desde un enfoque de coordinación intergubernativa en el marco de las competencias autonómicas compartidas y concurrentes, toda vez que el enfoque de gobernanza multinivel o multiescalar postula que “tanto la comprensión de las dinámicas del desarrollo territorial, como de los medios de intervención sobre ellas, requiere de una mirada integral y compleja de las interacciones entre las diversas escalas geográficas del desarrollo (CEPAL 2017)

3.3.2. Gestión de implementación del Plan

Para la efectiva implementación del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, la Secretaria de desarrollo humano y social a través de la Coordinación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, coordinará con el Consejo Municipal Intersectorial de niñez y adolescencia, para que las diferentes instancias del Gobierno Municipal de Sucre y las entidades que comparten o concurren competencia contribuyan a la elaboración participativa e implementación intersectorial de Programas, Proyectos y Acciones del Plan Municipal de Niñez y Adolescencia, que se concretará entonces a través de dos tipos de procesos:

1. La coordinación intersectorial e interinstitucional a través del Consejo Municipal intersectorial de niñez y adolescencia, donde diferentes entidades del Estado, de acuerdo a sus competencias concurrentes y compartidas o a sus atribuciones normativas deberán coordinar acciones, por ejemplo, los sectores de salud, educación, seguridad ciudadana, organizaciones y entidades de la sociedad civil y otros. Estas acciones formaran parte de los planes anuales del Consejo.
2. La elaboración e implementación progresiva de Programas y Proyectos inscritos en los Planes Operativos Anuales de ejecución directa desde las instancias municipales como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la Unidad de Familia, el Programa de protección social para niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo, el servicio de prevención y otros, en cumplimiento de sus atribuciones conferidas por la normativa nacional y municipal (el Código de la Niña, Niño y Adolescente y la Ley municipal de niñez y adolescencia y su reglamentación) y desarrollados en el marco del sistema de planificación nacional y departamental (El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y el Plan territorial de desarrollo Integral - PTDI).

Y finalmente también participara de la implementación del plan el Comité Municipal de la niñez y adolescencia.

3.3.3. Seguimiento y monitoreo

El Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 adoptará un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación participativo bajo la coordinación de la Secretaría de desarrollo humano y social a través de la Coordinación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que coordina las instancias de participación, es decir el Consejo Municipal intersectorial de la niñez y adolescencia y el Comité Municipal de niñez y adolescencia.

Metodológicamente, se realizará un seguimiento sistemático de la consecución de indicadores de proceso mediante estrategias predictivas y propositivas, estableciéndose como el principal espacio de retroalimentación para los ajustes las reuniones semestrales, realizadas con la participación de todo el Consejo Municipal intersectorial de la niñez y adolescencia, que a su vez se sistematizarán en informes anuales, en los que se considerará el análisis cualitativo de logros intermedios, que a su vez permitirán que se medir la eficiencia de los procesos y eficacia de las operaciones, con características propositivas que posibiliten ajustes.

Con este mecanismo se procurará garantizar permanentemente no sólo la consecución de los indicadores de proceso, sino fundamentalmente en base al seguimiento de desarrollo de las Acciones Estratégicas relacionadas con los resultados del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025

- **Consejo Municipal intersectorial de la niña, niño y adolescente**

El Consejo Municipal intersectorial de la niña, niño y adolescente tiene como objeto principal articular a las entidades para coadyuvar en la implementación del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025. Y tiene como atribución participar en la elaboración, seguimiento y monitoreo del plan municipal de la niña, niño y adolescente. (Art. 36 b) Ley N° 120/2018)

- **Comité Municipal de la niñez y adolescencia**

El Comité municipal de niñez y adolescencia, es la máxima instancia de representación de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Sucre, y son responsables de participar en la elaboración, seguimiento y monitoreo del plan, programas, normativas y proyecto. Tiene la atribución de participar en la elaboración, seguimiento y monitoreo del Plan municipal de niñez y adolescencia (Art. 33b Ley N° 120/2018)

3.3.4. Evaluación

La evaluación se realizará paralelamente al seguimiento y monitoreo, se realizará participativamente en base a la medición y avance de indicadores de proceso (anuales) y de los resultados que serán reportados en informes anuales y evaluados bianualmente en el Congreso municipal de niñez y adolescencia

- **Congreso municipal de derechos de la niña, niño y adolescente**

El Congreso Municipal de derechos de la niña, niño y adolescente, conformado por la Máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el Comité Municipal intersectorial de la niña, niño y adolescente y el Comité Municipal de la niñas y adolescencia, y tiene como atribución aprobar y evaluar el Plan Municipal de la niña, niño y adolescente (Art. 29 a) Ley N° 120/2018)

4. PROGRAMACIÓN BASADA EN DERECHOS

4.1. Articulación a las políticas públicas nacionales y ODS

4.1.1. Articulación con los ODS

El Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, responde al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

A través de las siguientes metas:

- 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
- 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
- 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
- 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

4.1.2. Articulación PGDES

El Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 responde al Pilar 11 del PGDES, Soberanía y transparencia en la gestión pública

4.1.3. Articulación PDES 2021-2025

El Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025 se articula al PDES y al PTDI 2021-2025 de Sucre de acuerdo al siguiente detalle:

Resultado del PDES, PSDI / PEM o PTDI	Objetivos Estratégicos Institucionales PTDI 2021-2025 Sucre	COD	Acciones estratégicas institucionales PTDI 2021-2025 Sucre
Reducir en 10% la tasa de índices de violencia a través de la promoción y prevención de todas las formas de violencia a la Población en situación de vulnerabilidad en el municipio de sucre al 2025	Promover y garantizar la protección, la promoción y prevención de todas las formas de violencia a la población en situación de vulnerabilidad en el municipio de sucre	23.1.2	Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento de programas de promoción y/o atención de casos a niños, niñas y adolescentes en el municipio de Sucre.
		23.2.4	Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento que coadyuve a la población vulnerable en el municipio de Sucre.

4.2. RESPONSABILIDAD POR ACTOR INSTITUCIONAL

Acciones	Entidades	Responsabilidades
Comité Municipal de NNA de Sucre cuenta con apoyo logístico y técnico permanente y con recursos gestionados por GAM Sucre para la ejecución de actividades y desarrolla al menos 4 sesiones con autoridades	Coordinación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia.	Asignar personal especializado y suscribir acuerdos para acompañamiento técnico a Comité NNA. Brindándoles acompañamiento, apoyo técnico, logístico y financiero para el
	Organizaciones de sociedad civil.	
	Concejo municipal de Sucre.	

ejecutivas y legislativas, 1 actividad de prevención, al menos 2 actividades departamentales, nacionales o internacionales, y 2 ciclos de reuniones para la actualización de su reglamento y la elaboración y/ o seguimiento de política pública municipal (NA)		desarrollo de las actividades y modificación de reglamento, en coordinación con entidades del comité municipal intersectorial de niñez y adolescencia.
Al menos el 80% de los miembros del Comité NNA participan en 4 módulos de capacitación fortaleciendo los conocimientos en derechos y las habilidades de liderazgo y replican lo aprendido con al menos 4 organizaciones de NNA, con el apoyo de entidades de la sociedad civil (NA).	Comité municipal de niñez y adolescencia. Coordinación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Organizaciones de sociedad civil.	Elaborar el programa de formación, y organizar los procesos de formación en coordinación con entidades del comité municipal intersectorial de niñez y adolescencia.
Comité Municipal de niñez y adolescencia de Sucre realiza al menos 1 audiencia pública, visitas in situ y reuniones con al menos 4 organizaciones o grupos de niñas, niños y adolescentes (gobiernos estudiantiles, grupos de Scouts, y niñas, niños y adolescentes de grupos prioritarios) fortaleciendo la coordinación con NNA de grupos de base (NA)	Comité municipal de niñez y adolescencia. Coordinación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Organizaciones de sociedad civil.	Brindarles el apoyo técnico, logístico y financiero para el desarrollo de actividades: elaboración de mapeo de organizaciones de niñas y niños, elaboración del cronograma en base al plan de actividades y realizar los encuentros o visitas
Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Sucre cuenta con la activa participación de representantes de al menos 3 grupos de atención prioritaria (pueblos indígenas, NNATS, con discapacidad, y de centros de acogida y reintegración) (NA)	Coordinación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia. UMADIS- Programa de protección social. PIOCs.	Sensibilizar a las autoridades indígenas, promover una mayor información del comité en la población de NNA y adultos del pueblo indígena

• **Sistema de protección de la niñez y adolescencia**

Acciones	Entidades	Responsabilidades
Presupuesto asignado para Niñez y Adolescencia al POA del GAM Sucre con ejecución al 100% contribuye a ampliar la cantidad de personal institucionalizado, mejorar los servicios de atención y garantizar el funcionamiento del sistema de protección con al menos 1 congreso bianual de niñez y adolescencia, 3 sesiones del Comité Municipal de NNA y al menos 2 sesiones anuales del Consejo Municipal Intersectorial de NNA realizadas para la aprobación y seguimiento a las políticas públicas municipales y el Plan municipal NNA. (INA)	GAM Sucre. Coordinación de defensorías de la niñez y adolescencia. Consejo municipal intersectorial de NNA. Comité Municipal de Niñez y Adolescencia.	Planificar los eventos, elaborar los presupuestos y gestionarlos, organizar el desarrollo de los eventos en coordinación con el consejo municipal intersectorial de niñez y adolescencia

Personal de las DNA y los servicios de atención de NNA especializado, cuenta con un plan de institucionalización ampliado progresivamente en base al manual de puestos y funciones y evaluación de personal de acuerdo a reglamento interno de personal y 1 programa permanente de capacitación y actualización, que contribuye a que servidores públicos que trabajan con NNA conozca la normativa, políticas y protocolos para atención a primera infancia, víctimas de violencia, Nats, Nasc, trata, NNA con discapacidad, adolescentes con responsabilidad penal, brindando una atención de calidad. (INA)	GAM Sucre	Diseñar una estrategia de seguimiento a la aplicación del plan de institucionalización. Elaborar el programa de formación, y organizar los procesos de formación en coordinación con entidades del comité municipal intersectorial de niñez y adolescencia, realizar los procesos de formación.
Sistema de información municipal consolidado reporta información al SINNA, desde DNAs que cuentan con equipamiento informático, acceso a servicio de internet, reportando información desagregada por tipologías de atención y diseñando sus propios registros administrativos de acuerdo a normativa vigente ⁶ , publicando los datos anualmente en 1 informe municipal de situación de la niñez y adolescencia, por poblaciones vulnerables. (INA)	Coordinación de defensorías de la niñez y adolescencia. CIDIM Salud GAM Sucre	Coordinar con el VIPFE la articulación con el SINNA, diseñar formatos administrativos de recojo de información, realizar procesos de formación a las DNA, continuar actualizando la información
Consejo municipal intersectorial de NNA fortalecido, cuenta con Reglamento Interno aprobado, Planes anuales e Informes de actividades anuales presentados, se reúne al menos 2 veces al año y desarrolla actividades a través de comisiones, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para la implementación del Plan Municipal de NNA y políticas municipales. (INA)	Consejo municipal intersectorial de NNA	Organizar y convocar a reuniones, elaborar una agenda de contactos, promover la organización interna del consejo municipal intersectorial de NNA
Estrategia de difusión de la línea gratuita de la DNA y de los servicios de atención e instancias de participación (en idiomas de señas y lenguas originarias) se difunde por medios de comunicación y redes sociales, informando a la población y promoviendo la participación de la	Coordinación de defensorías de la niñez y adolescencia. Dirección de comunicación GAM Sucre	Diseñar estrategia, elaborar medios portadores de información y difundir información

⁶ Los Gobiernos municipales tienen la atribución normativa de proporcionar información registro estadístico especializado en niñez y adolescencia, de datos de atención de casos de violencia y vulneración de derechos, descritos en el clasificador de tipologías del Ministerio de Justicia. Y además deben generar sus herramientas de reporte administrativo, de registro de embarazo en adolescentes, coordinación con entidades de atención terapéutica, reportes de salud sobre la escala de desarrollo de primera infancia, seguimiento a la certificación de Centros AIDA, NNA con discapacidad, aplicación de la ILE, hijas e hijos de trabajadoras sexuales y otras poblaciones vulnerables

comunidad y las familias de NNA (Juntas vecinales, juntas de padres y madres de familia, autoridades originarias campesinas) en el Consejo Municipal intersectorial de NNA y en la Escuelas de padres y madres de familia (INA)		
Delegados del Consejo Municipal intersectorial de NNA y Comité Municipal de NNA de Sucre participan en instancias de coordinación: Comité de la primera infancia, subsistemas departamentales de protección, penal, consejo contra la trata y tráfico de personas, comité de erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos, comité de prevención de violencia, y plataforma de lucha contra la violencia y otros fortaleciendo la coordinación interinstitucional e intergubernativa para la implementación del Plan municipal de NNA y políticas municipales (INA)	Consejo Municipal intersectorial de NNA Comité Municipal de NNA	Promover la organización interna del consejo municipal intersectorial de NNA

• **Prevención de la violencia y vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

Acciones	Entidades	Responsabilidades
1 programa interinstitucional e intergubernativo de prevención de violencia familiar y sexual elaborado participativamente se promueve por el GAMS, en coordinación con el CEPAT, SEDEGES, JIO – GAD Chuquisaca, Salud, Educación, Policía - Seguridad Ciudadana, OSC, Comité municipal NNA en corresponsabilidad de padres y madres de familia (INA)	Unidad de Prevención GAM Sucre.	Diseñar el programa participativamente en reuniones de coordinación
1 estrategia de fortalecimiento, apoyo a la implementación y seguimiento de Planes de Convivencia Pacífica y Armónica, implementada de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de educación y el Código Niña, Niño y Adolescente, elaborados desde enfoques de derechos, cultura de paz y justicia restaurativa contribuye a que las UE contribuyan a la prevención de la violencia desde la educación (INA)	Unidad de Prevención GAM Sucre. Educación GAM Sucre	Coordinar con la academia y OSC para realizar un diagnóstico de la situación de planes de convivencia pacífica y armónica, elaborar un informe con recomendaciones y orientaciones técnicas, realizar procesos de formación e intercambio de experiencias, coordinar con GAIES y realizar seguimiento
1 campaña de sensibilización permanente de deberes de padres y madres de familia, contribuye a la crianza positiva, la comunicación no violenta, generar habilidades de control parental de dispositivos móviles (desde un enfoque de derechos) y EIS fortaleciendo la	Unidad de Prevención GAM Sucre. Unidad de Familia GAM Sucre.	Diseñar la estrategia comunicacional de la campaña de sensibilización, diseñar los medios portadores de información, organizar equipo y cronograma, realizar las actividades de sensibilización

comunicación entre padres, madres y sus hijas/os, desde la Escuela de Padres, en coordinación con GAIEs y centros municipales comunitarios (INA)		
N° de Brigadas escolares de seguridad ciudadana fortalecidas con capacitaciones en temas de cultura de paz, comunicación asertiva, resolución de conflictos, prevención al consumo de sustancias controladas, alcohol, bullying respeto a la diversidad y no discriminación y otros como parte de su formación para poder hacer replica en las UE. (NA)	Seguridad ciudadana GAM Sucre	Coordinar con entidades de OSC y Unidades educativas, diseñar los procesos de capacitación e implementarlos
1 campaña de prevención de violencia con al menos 4 actividades de calle (ferias, conciertos y concursos) y/o a través del arte en sus diferentes expresiones, 1 ciclo de formación, y 1 estrategia de comunicación por medios y redes sociales se implementa desde la coordinación interinstitucional, en fechas emblemáticas de derechos.	Unidad de prevención GAM Sucre. Consejo Municipal intersectorial de NNA.	Diseñar la estrategia comunicacional de la campaña de prevención, organizar equipo, materiales y cronograma, realizar las actividades de prevención
14 Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes consolidados, contribuyen a aplicar el protocolo de denuncia de violencia en Unidades Educativas, para implementar estrategias de prevención, EIS, desde un enfoque de desarrollo integral, en coordinación con DNA del GAM Sucre, la dirección de educación, policía, la USFXCH y OSC. (INA)	GAM Sucre. Unidad de prevención GAM Sucre.	Coordinar con Dirección departamental de educación y con OSC formadoras el cronograma e formación del protocolo, coordinar con los responsables de la campaña de prevención, fortalecer los canales de referencia y contrareferencia
1 Programa de reeducación, rehabilitación y reinserción social y laboral dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social, drogodependientes y alcohólicas, a adolescentes con responsabilidad penal se elabora e implementa desde seguridad ciudadana en coordinación con entidades públicas, privadas y de sociedad civil, en corresponsabilidad de padres y madres de familia. (NA)	Seguridad Ciudadana, Prevención GAM Sucre en coordinación con Dirección de Juventudes,	Coordinar con Jefatura de trabajo empleo y previsión social, Policía, SEDEGES y el Subsistema penal adolescente para diseñar participativamente el programa e implementarlo
1 mesa técnica conformada para diseñar proyectos educativos comunitarios de prevención de violencia y EIS, con acciones implementadas para su abordaje con los diferentes grupos etareos infantes, niñas, niños y adolescentes, en consonancia con las políticas	Educación GAM Sucre. Unidad de prevención GAM Sucre.	Convocar a reuniones de la mesa técnica y realizar el seguimiento al desarrollo de trabajo técnico, coordinando con las entidades participantes, con el comité NNA y con especialistas

autonómicas y nacionales, a través del uso de redes sociales. (INA)		
1 estrategia de sensibilización y seguimiento a la certificación de centros AIDAJ, contribuye a que los centros de salud brinden una atención especializada y diferenciada a adolescentes, que reciben orientación para la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, anticoncepción de emergencia, ILE, prevención de ITS. (A)	Salud GAM Sucre. Unidad de prevención GAM Sucre. Unidad de Familia GAM Sucre.	Diseñar la estrategia y herramienta de seguimiento Diseñar la estrategia de sensibilización, elaborar los materiales o contenidos e implementar las acciones de sensibilización
1 programa de oferta gratuita de actividades de educación del tiempo libre, actividades culturales y deportivas y de apoyo extraescolar, se desarrolla en centros municipales comunitarios y espacios al aire libre, promoviendo la comunicación y convivencia familiar (INA)	Secretaría de deportes GAM Sucre. Unidad de prevención GAM Sucre. Unidad de Familia GAM Sucre. Consejo Municipal intersectorial de NNA.	Realizar reuniones de coordinación con entidades culturales, artísticas, voluntarias y de tiempo libre, diseñar un cronograma, difundirlo y realizar el seguimiento a las actividades

• **Atención y reparación integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

Acciones	Entidades	Responsabilidades
1 protocolo municipal de atención a NNA víctimas de violencia para DNA, difundido se implementa por las DNA y todos los actores del sistema de protección integral de la NNA y el sistema penal adolescente (INA)	Coordinación de Defensorías de la niñez y adolescencia	Coordinar con entidad formadora, diseñar cronograma de formación, elaborar material de difusión del proceso de formación, difundirlo y realizarlo
1 protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en UE y 1 Guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar elaborados por el Ministerio de Educación, se difunden y socializan a profesores, GAIE y a la comunidad educativa, en coordinación con la DNA, contribuyendo a conocer herramientas de identificación de casos y promoviendo que se rompa el silencio en las UE en cumplimiento de la normativa vigente	Coordinación de Defensorías de la niñez y adolescencia. Consejo Municipal intersectorial de NNA.	Coordinar con entidad formadora, diseñar cronograma de formación, diseñar herramientas de identificación de casos, elaborar material de difusión del proceso de formación, difundirlo y realizarlo
1 estrategia de comunicación, sensibilización y formación para luchar contra los prejuicios y estereotipos de género, se implementa dirigida a servidores públicos de DNA, Educación y Salud para la aplicación de la Ruta interinstitucional de atención a NNA víctimas de violencia y violencia sexual e ILE (NA)	Consejo Municipal intersectorial de NNA.	Diseñar la estrategia comunicacional, organizar equipo, diseñar materiales y medios portadores de la información y sensibilización, elaborar cronograma, realizar las actividades de sensibilización Coordinar con OSC para brindar la formación, elaborar el material y realizar la formación
1 curso de formación en justicia restaurativa contribuye a una mayor comprensión y a la aplicación de la misma, fortaleciendo la responsabilización del hecho, la	Consejo Municipal intersectorial de NNA.	Coordinar con entidad formadora, diseñar cronograma de formación, elaborar material de difusión del proceso de formación diferenciado para víctimas, familiares, ofensores

reparación integral del daño y la reintegración de ambas partes, con participación de la familia y la comunidad. (NA)		y comunidad, y servidores públicos, preparar materiales de formación y realizar los procesos de formación
Derivar a víctimas de violencia para atención terapéutica contribuyen a la reparación integral del daño	Defensorías de la niñez y adolescencia.	Coordinar con entidades de atención de salud mental o atención psicológica especializada y derivar.
Ciclos de formación on-line sobre rutas de atención y protocolos de atención de DNA (Trata, NNASC, NNATS, Derecho a la familia) se desarrollan dirigidos a servidores públicos, promotoras comunitarias, GAIE, Centros AIDA y OSC.	Consejo Municipal intersectorial de NNA.	Coordinar con entidad formadora, diseñar cronograma de formación, elaborar material de difusión del proceso de formación, difundirlo y realizarlo
Fortalecida la coordinación entre la DNA y la jefatura departamental del trabajo para realizar las inspecciones laborales, consolidando la articulación en el comité de erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos (NA)	Coordinación de defensorías de la niñez y adolescencia.	Realizar reuniones de coordinación, realizar capacitación en protocolos de NNATS y NNASC, diseñar estrategia de intervención, elaborar agenda conjunta de actividades, realizar las actividades de calle e inspección
100% de DNA capacitadas, implementan una estrategia de aplicación del formulario de autorización de trabajo adolescente, previo proceso de sensibilización a servidores públicos, NNATS, padres y madres de familia y empleadores (A)	Coordinación de defensorías de la niñez y adolescencia.	Coordinar con entidad formadora, diseñar cronograma de formación, elaborar material de difusión del proceso de formación, difundirlo y realizarlo Diseñar estrategia de sensibilización, elaborar medios portadores de información para servidores públicos, NNATS, padres y madres de familia y empleadores, implementar la estrategia
Estrategia de intervención del programa de protección social para NNATS fortalecida contribuye a ampliar la cobertura del programa desarrollando acciones de atención y estrategias preventivas de NNASC y NNATS (NA)	programa de protección social para NNATS	Revisar las rutas de atención y prevención en reuniones interinstitucionales, formar al equipo del programa, realizar intercambios de experiencias, concluir el protocolo de intervención, difundirlo y aplicarlo
Hogar transitorio elabora su reglamento, se fortalece con capacitación especializada del personal y el diseño e implementación de mecanismos de búsqueda de familias de origen o ampliada, contribuyendo a aplicar otras modalidades para garantizar el derecho a vivir en familia (guarda y otros) (INA)	Defensorías de niñez y adolescencia.	Coordinar con entidades especialistas, definir las fases de elaboración del reglamento, realizar reuniones técnicas y la fase de validación y aprobación participativa del reglamento, realizar el seguimiento a su aplicación
Programa de reintegración familiar con un sistema de seguimiento de la DNA a NNA de centros de acogida para que se reduzca la institucionalización y se contribuya a la reintegración familiar o a la definición de la situación jurídica de NNA para adopción de NNA de centros de acogida (INA)	Defensorías de la niñez y adolescencia.	Diseñar el sistema de seguimiento, organizar un cronograma con el subsistema de protección judicial, realizar el seguimiento

Programa prevención y promoción del derecho a vivir en familia se consolida como política pública, para el abordaje a familias y NNA en situación de riesgo de perder el derecho a la familia, fortaleciendo capacidades parentales (INA)	Unidad de Familia GAM Sucre.	Diseñar el programa participativamente, implementar una estrategia de aprobación e incidencia, realizar el seguimiento
---	------------------------------	--

• **Protección social de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

Acciones	Entidades	Responsabilidades
Herramientas de seguimiento al desarrollo de la primera infancia Implementadas en el sistema educativo (en kínderes) y mediante estrategias comunitarias a través de medios de comunicación y redes sociales (I)	Educación GAM Sucre.	Diseñar herramientas, coordinar con entidades del estado y OSC y realizar el seguimiento
1 Reglamento de control de centros infantiles que brindan servicios en el municipio de Sucre, se implementa con procesos de formación para estandarizar la calidad de atención de los centros, la aplicación de herramientas de seguimiento al desarrollo de las y los infantes y aplicación de la norma de vigilancia de trastornos o discapacidad en la primera infancia. (I)	Coordinación de CIDIMs. Coordinación de defensorías de niñez y adolescencia.	Coordinar con entidades especialistas, definir las fases de elaboración del reglamento, realizar reuniones técnicas y la fase de validación y aprobación participativa del reglamento, realizar el seguimiento a su aplicación
1 estrategia de monitoreo de los servicios de atención a la primera infancia se elabora y aplica (INA)	CIDIMs. Coordinación de defensorías de niñez y adolescencia.	Diseñar la estrategia de monitoreo, aplicarla
Al menos 2 programas fortalecidos cuentan con planificación programática para la atención y prevención: Programa de Asistencia social a las Familia y Programa de Protección a NNA trabajadores (INA).		Diseñar participativamente los programas, capacitar al personal, realizar el seguimiento a la validación y aprobación de los programas y realizar el seguimiento

4.3. PROGRAMACIÓN

- Participación de la niñez y adolescencia

LINEA DE BASE	RESULTADO (PMNNA)	ACCION (PMNNA)	INDICADOR (PMNNA)
1 comité municipal de la niña, niño y adolescente de Sucre 2023-2025 electo democráticamente cuenta con Reglamento Interno	Se ha garantizado el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en la elaboración y seguimiento de políticas públicas municipales, contribuyendo a que las autoridades escuchen sus opiniones y sean tomadas en cuenta en las políticas que les afectan.	Comité Municipal de NNA de Sucre, fortalecido contribuye a garantizar el ejercicio del derecho a la participación de las NNA	Comité Municipal de NNA de Sucre cuenta con apoyo logístico y técnico permanente y con recursos gestionados por GAM Sucre para la ejecución de actividades y desarrolla al menos 4 sesiones con autoridades ejecutivas y legislativas, 1 actividad de prevención, al menos 2 actividades departamentales, nacionales o internacionales, y 2 ciclos de reuniones para la actualización de su reglamento y la elaboración y/ o seguimiento de política pública municipal (NA) Al menos el 80% de los miembros del Comité NNA participan en 4 módulos de capacitación fortaleciendo los conocimientos en derechos y las habilidades de liderazgo y replican lo aprendido con al menos 4 organizaciones de NNA, con el apoyo de entidades de la sociedad civil (NA). Comité Municipal de niñez y adolescencia de Sucre realiza al menos 1 audiencia pública, visitas in situ y reuniones con al menos 4 organizaciones o grupos de niñas, niños y adolescentes (gobiernos estudiantiles, grupos de Scouts, y niñas, niños y adolescentes de grupos prioritarios) fortaleciendo la coordinación con NNA de grupos de base (NA) Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Sucre cuenta con la activa participación de representantes de al menos 3 grupos de atención prioritaria (pueblos indígenas, NNATS, con discapacidad, y de centros de acogida y reintegración) (NA)

• **Sistema de protección de la niñez y adolescencia**

LINEA DE BASE	RESULTADO (PMNNA)	ACCION (PMNNA)	INDICADOR (PMNNA)
Comité Municipal NNA conformado cada 2 años y Consejo Municipal intersectorial de NNA recientemente conformado permite la coordinación	Se ha fortalecido el Sistema municipal de protección de la niñez y adolescencia, con instancias de coordinación permanente institucionalizadas y servicios de atención a NNA, que contribuyen a implementar la normativa vigente mediante programas de atención, prevención y protección, en el marco de las competencias autonómicas y atribuciones normativas municipales	Sistema de protección municipal de la NNA, funciona implementando el plan municipal de NNA en el marco de la normativa vigente	Presupuesto asignado para Niñez y Adolescencia al POA del GAM Sucre con ejecución al menos el 90% contribuye a la atención de las niñas, niños y adolescentes del municipio
			Servicios de atención mejorados por la coordinación interinstitucional en el sistema de protección municipal fortalecido que se reúne en al menos 3 sesiones anuales del Comité Municipal de NNA, 2 sesiones anuales del Consejo Municipal Intersectorial de NNA y 1 congreso bianual realizados para la aprobación y seguimiento a las políticas públicas municipales y el Plan municipal NNA. (INA)
			Personal de las DNA y los servicios de atención de NNA especializado, cuenta con un plan de institucionalización ampliado progresivamente en base al manual de puestos y funciones y evaluación de personal de acuerdo a reglamento interno de personal del GAM
			Servidores públicos que trabajan con NNA participan de 1 programa permanente de capacitación y actualización, que contribuye a que conozcan la normativa, políticas y protocolos para atención a primera infancia, víctimas de violencia, Nats, Nasc, trata, NNA con discapacidad. Adolescentes con responsabilidad penal, brindando una atención de calidad. (INA)
			Sistema de información municipal consolidado reporta información al SINNA, desde DNAs que cuentan con equipamiento informático, acceso a servicio de internet, reportando información desagregada por tipologías de atención y diseñando sus propios registros administrativos de acuerdo a normativa vigente ⁷ ,

⁷ Los Gobiernos municipales tienen la atribución normativa de proporcionar información registro estadístico especializado en niñez y adolescencia, de datos de atención de casos de violencia y vulneración de derechos, descritos en el clasificador de tipologías del Ministerio de Justicia. Y además deben generar sus herramientas de reporte

			publicando los datos anualmente en 1 informe municipal de situación de la niñez y adolescencia, por poblaciones vulnerables. (INA)
			Consejo municipal intersectorial de NNA fortalecido, cuenta con Reglamento Interno aprobado, Planes anuales e Informes de actividades anuales presentados, se reúne al menos 2 veces al año y desarrolla actividades a través de comisiones, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para la implementación del Plan Municipal de NNA y políticas municipales. (INA)
			Estrategia de difusión de la línea gratuita de la DNA y de los servicios de atención e instancias de participación (en idiomas de señas y lenguas originarias) se difunde por medios de comunicación y redes sociales, informando a la población y promoviendo la participación de la comunidad y las familias de NNA (Juntas vecinales, juntas de padres y madres de familia, autoridades originarias campesinas) en el Consejo Municipal intersectorial de NNA y en la Escuela de padres y madres de familia (INA)
			Delegados del Consejo Municipal intersectorial de NNA y Comité Municipal de NNA de Sucre participan en instancias de coordinación: Comité de la primera infancia, subsistemas departamentales de protección, penal, consejo contra la trata y tráfico de personas, comité de erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos, comité de prevención de violencia, y plataforma de lucha contra la violencia y otros fortaleciendo la coordinación interinstitucional e intergubernativa para la implementación del Plan municipal de NNA y políticas municipales (INA)

administrativo, de registro de embarazo en adolescentes, coordinación con entidades de atención terapéutica, reportes de salud sobre la escala de desarrollo de primera infancia, seguimiento a la certificación de Centros AIDA, NNA con discapacidad, aplicación de la ILE, hijas e hijos de trabajadoras sexuales y otras poblaciones vulnerables

• **Prevención de la violencia y vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

LINEA DE BASE	RESULTADO (PMNNA)	ACCION (PMNNA)	INDICADOR (PMNNA)
2540 casos de violencia en Chuquisaca: • 1854 casos de violencia familiar • 217 casos de violación • 103 casos de estupro • 174 casos de violación NNA (Fuente Fiscalía General del Estado 2022)	Se han implementado programas de prevención de violencia y vulneración de derechos de la niñez y adolescencia, promoviendo la creación de entornos educativos, familiares y comunitarios favorables para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia y la convivencia pacífica y armónica	Programa de prevención de violencia hacia la NNA	1 programa interinstitucional e intergubernativo de prevención de violencia familiar y sexual elaborado participativamente se promueve por el GAMS, en coordinación con el CEPAT, SEDEGES, JIO – GAD Chuquisaca, Salud, Educación, Policía - Seguridad Ciudadana, OSC, Comité municipal NNA en corresponsabilidad de padres y madres de familia (INA) 1 estrategia de fortalecimiento, apoyo a la implementación y seguimiento de Planes de Convivencia Pacífica y Armónica, implementada de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de educación y el Código Niña, Niño y Adolescente, elaborados desde enfoques de derechos, cultura de paz y justicia restaurativa contribuye a que las UE contribuyan a la prevención de la violencia desde la educación (INA) 1 campaña de sensibilización permanente de deberes de padres y madres de familia, contribuye a la crianza positiva, la comunicación no violenta, generar habilidades de control parental de dispositivos móviles (desde un enfoque de derechos) y EIS fortaleciendo la comunicación entre padres, madres y sus hijas/os, desde la Escuela de Padres, en coordinación con promotoras comunitarias, GAIEs y centros municipales comunitarios (INA) N° de Brigadas escolares de seguridad ciudadana fortalecidas con capacitaciones en temas de cultura de paz, comunicación asertiva, resolución de conflictos, prevención al consumo de sustancias controladas, alcohol, bullying, respeto a la diversidad y no discriminación, y otros como parte de su formación para poder hacer replica en las UE, en coordinación con seguridad ciudadana. (NA)

			1 campaña de prevención de violencia con al menos 4 actividades de calle (ferias, conciertos y concursos) y/o a través del arte en sus diferentes expresiones, 1 ciclo de formación, y 1 estrategia de comunicación por medios y redes sociales se implementa desde la coordinación interinstitucional, en fechas emblemáticas de derechos 14 Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes consolidados, contribuyen a aplicar el Protocolo de denuncia de violencia en Unidades Educativas, para implementar estrategias de prevención, EIS, desde un enfoque de desarrollo integral, en coordinación con DNA del GAM Sucre, la dirección de educación, policía, la USFXCH y OSC. (INA) 1 Programa de reeducación, rehabilitación y reinserción social y laboral dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social, drogodependientes y alcohólicas, a adolescentes con responsabilidad penal se elabora e implementa desde seguridad ciudadana en coordinación con entidades públicas, privadas y de sociedad civil, en corresponsabilidad con padres y madres de familia. (NA)
574 embarazos en adolescentes que se registraron en 2021 en Sucre: • 557 fueron embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años edad (97%). • 17 embarazos fueron en niñas y adolescentes menores de 15 años en edad (3%). (UNFPA en base a INE 2021)		Programa de Prevención del embarazo en adolescentes	1 mesa técnica conformada para diseñar proyectos educativos comunitarios de prevención de violencia y EIS, con acciones implementadas para su abordaje con los diferentes grupos etareos infantes, niñas, niños y adolescentes, en consonancia con las políticas autonómicas y nacionales, a través del uso de redes sociales. (INA) 1 programa de oferta gratuita de actividades de educación del tiempo libre, actividades culturales y deportivas y de apoyo extraescolar, se desarrolla en centros municipales comunitarios y espacios al aire libre, promoviendo la comunicación y convivencia familiar (INA)

• **Atención y reparación integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

LINEA DE BASE	RESULTADO (PMNNA)	ACCION (PMNNA)	INDICADOR (PMNNA)
De 10034 casos atendidos por la DNA el 20% son casos de violencia: • El derecho a la familia 29% • Problemas sociales 20% • Violencia (Delitos contra la integridad corporal, Derecho al respeto y la dignidad y Delitos contra la libertad sexual) 18% (DNA 2022)	Se ha brindado una atención integral psico socio legal a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o de vulneración de derechos, en situación de trabajo, de centros de acogida, y en riesgo de perder el derecho a la familia, desde un enfoque de protección reforzada, de derechos, diferencial, interseccional, de genero e intercultural, para contribuir a la reparación integral de daños	Programa de Atención a víctimas de violencia y reparación integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes	1 protocolo municipal de atención a NNA víctimas de violencia para DNA, difundido se implementa por las DNA y todos los actores del sistema de protección integral de la NNA y el sistema penal adolescente (INA)
			1 Protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en UE y 1 Guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar elaborados por el Ministerio de Educación, se difunden y socializan ampliamente a profesores, GAIE y a la comunidad educativa, en coordinación con la DNA, contribuyendo a conocer herramientas de identificación de casos y promoviendo que se rompa el silencio en las UE en cumplimiento de la normativa vigente
			1 estrategia de comunicación, sensibilización y formación para luchar contra los prejuicios y estereotipos de género, se implementa dirigida a servidores públicos de DNA, Educación y Salud para la aplicación de la Ruta interinstitucional de atención a NNA víctimas de violencia y violencia sexual e ILE (NA)
			1 curso de formación en justicia restaurativa contribuye a una mayor comprensión y a la aplicación de la misma, fortaleciendo la responsabilización del hecho, la reparación integral del daño y la reintegración de ambas partes, con participación de la familia y la comunidad. (NA)
			N° de casos de víctimas de violencia derivados por la DNA para atención terapéutica contribuyen a la reparación integral del daño (NA)
			Ciclos de formación on line sobre rutas de atención y protocolos de atención de DNA (Trata, NNASC, NNATS, Derecho a la familia) se desarrollan dirigidos a servidores públicos, promotoras comunitarias, GAIE, Centros AIDA y OSC.

		Programa de protección social para NNATS	Fortalecida la coordinación entre la DNA y la jefatura departamental del trabajo para realizar las inspecciones laborales, consolidando la articulación en el Consejo Municipal Intersectorial de NNA (NA) 100% de DNA capacitadas, implementan una estrategia de aplicación del formulario de autorización de trabajo adolescente, previo proceso de sensibilización a servidores públicos, NNATS, padres y madres de familia y empleadores (A) Estrategia de intervención del programa de protección social para NNATS fortalecida contribuye a ampliar la cobertura del programa desarrollando acciones de atención y estrategias preventivas de NNASC y NNATS en coordinación con Consejo Municipal Intersectorial de NNA (NA)
		Programa municipal del derecho a la familia	Hogar Transitorio elabora su reglamento, se fortalece con capacitación especializada del personal y el diseño e implementación de mecanismos de búsqueda de familias de origen o ampliada, contribuyendo a aplicar otras modalidades para garantizar el derecho a vivir en familia (guarda y otros) (INA) Programa de reintegración familiar con un sistema de seguimiento de la DNA a NNA de centros de acogida para que se reduzca la institucionalización y se contribuya a la reintegración familiar o a la definición de la situación jurídica de NNA para adopción de NNA de centros de acogida (INA) Programa prevención y promoción del derecho a vivir en familia se consolida como política pública, para el abordaje a familias y NNA en situación de riesgo de perder el derecho a la familia, fortaleciendo capacidades parentales. (INA)

• **Protección social de derechos de las niñas, niños y adolescentes**

LINEA DE BASE	RESULTADO (PMNNA)	ACCION (PMNNA)	INDICADOR (PMNNA)
El 38.88% de la población total del municipio son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años: • El 25,2% son infantes de 0 a 4 años (34.648) • El 23,7% son niños y niñas de 5 a 9 años (32.557) • El 24% son niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años (33.019) • Y el 27,2% son adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (37.403). (INE 2020)	Se han fortalecido los servicios de protección social para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de abandono, con riesgo de perder el derecho a la familia, primera infancia, en situación de trabajo u otros, desde un enfoque de abordaje familiar y comunitario	Programas de protección social y familia	Herramientas de seguimiento al desarrollo de la primera infancia Implementadas en el sistema educativo (en kínderes) y mediante estrategias comunitarias a través de medios de comunicación y redes sociales
327 infantes, niñas, niños y adolescentes se encuentran en centros de acogida (2021) En Chuquisaca se registran 75.000 NNA entre 5 y 17 años que realizan una actividad laboral o trabajo (43.000 entre los 5 a 13 años y 31.000 entre los 14 a 17 años) (INE 2019)			1 Reglamento de control de centros infantiles que brindan servicios en el municipio de Sucre, se implementa con procesos de formación para estandarizar la calidad de atención de los centros, la aplicación de herramientas de seguimiento al desarrollo de las y los infantes y aplicación de la norma de vigilancia de trastornos o discapacidad en la primera infancia.
			1 estrategia de monitoreo de los servicios de atención a la primera infancia se elabora y aplica (INA) Al menos 2 programas fortalecidos cuentan con planificación programática para la atención y prevención: Programa de Asistencia social a las Familia y Programa de Protección a NNA trabajadores (INA)

4.4. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN FINANCIERA

4.4.1. Presupuesto asignado en el PTDI 2021 – 2025 de Sucre

Tasa de atención de los servicios de prevención (T.A.S.P.)	población vulnerable ejecutadas en la gestión / N° de atenciones a la población vulnerable programadas en la gestión) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25-26	45.607.927,39	25%	administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social
Tasa de fortalecimiento de programas de atención de violencia hacia la mujer (T.F.P.A.V.H.M.)	T.F.P.A.V.H.M.= (N° de acciones de fortalecimiento en el año N / total de mujeres víctimas de violencia beneficiadas) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25-26	10.452.086,51	15%	Registro administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social
Tasa de fortalecimiento de programas de atención de casos de niños, niñas y adolescentes (T.F.P.A.C.N.N.A.)	T.F.P.A.C.N.N.A.= (N° de acciones de fortalecimiento en el año N / total de población de niños, niñas y adolescentes beneficiados) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25-26	35.155.840,89	10%	Registro administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social
Tasa de fortalecimiento a la población vulnerable (T.F.P.V.)	T.F.P.V.= (N° de fortalecimientos a la población vulnerable ejecutadas / N° de fortalecimientos a la población vulnerable programadas) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25-26	182.266.887,35	25%	Registro administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social
Tasa de fortalecimiento de programas de atención de adultos mayores (T.F.P.A.A.M.)	T.F.P.A.A.M.= (N° de acciones de fortalecimiento en el año N / total de población de adultos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25	148.339.852,17	10%	Registro administrativo de la Secretaria Municipal de Desarrollo

4.4.2. Otras fuentes de financiamiento

Además del presupuesto municipal asignado para las actividades a desarrollarse del Plan Multisectorial Municipal de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre 2023-2025, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en el marco de la normativa vigente realizará gestiones de recursos de las otras entidades estatales, de sociedad civil y cooperación interinstitucional, a través de:

- El establecimiento de convenios intergubernativos entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca o el nivel central que asignan presupuestos para la atención y prevención de la violencia en el Plan Territoriale de Desarrollo Integral o Planes Multisectoriales o sectoriales.
- El establecimiento de acuerdos con las entidades llamadas por ley para brindar atención y prevención de la violencia, que reciben recursos del GAM Sucre, como Educación, Salud, Seguridad Ciudadana.
- El establecimiento de acuerdos y convenios entre el GAM Sucre con entidades de sociedad civil (ONGs, Fundaciones), de cooperación internacional y de organismos internacionales de derechos.
- El establecimiento de acuerdos y convenios entre el GAM Sucre y empresas y medios de comunicación, a través de la Responsabilidad Social Empresarial.
- La coordinación para el apoyo técnico voluntario de Promotoras Comunitarias, Organizaciones Sociales, academia, redes y entidades de sociedad civil.